

PROTOCOLES D'INTERVENTION CLINIQUE À L'USAGE DES PREMIERS RÉPONDANTS



**Direction des services préhospitaliers d'urgence
Ministère de la Santé et des Services sociaux
JANVIER 2007**

Première édition : 1995
Deuxième édition : 2002
Troisième édition : 2007
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec

Toute reproduction par quelque procédé que ce soit est interdite à moins d'autorisation écrite préalable.

Note : Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

PRÉAMBULE

En juin 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux a retenu des orientations en matière de services préhospitaliers d'urgence au Québec. Ces orientations prennent source dans le rapport *Chaque minute compte*. Le Ministère a notamment reconnu la nécessité d'une approche structurée qui assure la qualité dans la distribution des soins préhospitaliers d'urgence.

Le présent document contient les protocoles d'intervention de base à l'usage des premiers répondants. Chaque protocole établit, pour un problème donné, les actes à poser et la séquence dans laquelle ils doivent être posés.

Les protocoles d'intervention clinique des premiers répondants ont été élaborés dans le but d'assurer les soins de base le plus rapidement possible aux personnes dont la vie est en danger imminent. Ils visent également à standardiser la distribution des soins préhospitaliers d'urgence et assurer la concertation avec les techniciens ambulanciers. Enfin, ils sont des outils à la fois d'évaluation et d'amélioration de la qualité ainsi qu'un outil d'apprentissage.

Le présent recueil est une version revue et améliorée des protocoles initiaux. Cette révision fait suite à la révision des protocoles d'intervention clinique à l'usage des techniciens ambulanciers effectuée par la Table de concertation provinciale des directeurs médicaux des services préhospitaliers d'urgence du Québec.

COMITÉ DE RÉVISION

Claude Bordeleau

Technicien ambulancier instructeur, SPU Montérégie

Dr Jocelyn Moisan

Directeur médical, SPU de l'Outaouais

Dr Dave Ross

Directeur médical régional, SPU Montérégie

Collaborateurs

Dre Karyne Amyot	Responsable PR, SPU Montérégie
Sébastien Légaré	Technicien ambulancier instructeur
Éric Bruneau	Technicien ambulancier instructeur
Stéphane Martin	Technicien ambulancier instructeur
Gabriel Bourdon	Technicien ambulancier instructeur
Martine Bernard	Technicienne assurance qualité
Joël Vachon	Technicien ambulancier

Photographie page titre

Sophie Provost, incendie-resom.com

TABLE DES MATIÈRES

GÉNÉRALITÉS	13
PROTOCOLE D'APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE	15
1 RÉP/ACP. APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE.....	17
SITUATION DE SINISTRES	21
1 RÉP/SIN.1 INTERVENTION SUR UN SITE DE SINISTRE COMPORTANT PLUSIEURS VICTIMES.....	23
1 RÉP/SIN 2 TRIAGE : MÉTHODE START.....	25
PROBLÈMES INDUSTRIELS.....	27
1 RÉP/IND.1 EXPOSITION À DES MATIÈRES DANGEREUSES (INTERVENTION GLOBALE)	29
1 RÉP/IND.2 EXPOSITION À DES SUBSTANCES TOXIQUES	33
SITUATIONS DE RÉANIMATION	37
1 RÉP/RÉA.0 INTERVENTION GLOBALE – ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE	39
1 RÉP/RÉA.1 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE MÉDICAL – ADULTE.....	43
1 RÉP/RÉA.3 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE TRAUMATIQUE ADULTE.....	45
1 RÉP/RÉA.5 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE MÉDICAL – PÉDIATRIE	47
1 RÉP/RÉA.6 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE TRAUMATIQUE – PÉDIATRIE	49
PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX	51
1 RÉP/ENV.1 ACCIDENT DE PLONGÉE	53
1 RÉP/ENV.2 BRÛLURES.....	55
1 RÉP/ENV.3 COUP DE CHALEUR	59
1 RÉP/ENV.4 ÉLECTRISATION / ÉLECTROCUTION	61
1 RÉP/ENV.5 ENGELURE	65
1 RÉP/ENV.6 HYPOTHERMIE.....	67
1 RÉP/ENV.7 SUBMERSION	71
PROBLÈMES MÉDICAUX	73
1 RÉP/MED.2 ATTEINTE DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE	75
1 RÉP/MED.7 CONVULSIONS.....	77
1 RÉP/MED.8 DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE	81
1 RÉP/MED.10 DOULEUR THORACIQUE	85
1 RÉP/MED.11 EPISTAXIS	87
1 RÉP/MED.12 INTOXICATION.....	89
1 RÉP/MED.13 OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES PAR UN CORPS ÉTRANGER (8 ANS ET + OU + 25 KG)	93
1 RÉP/MED.17 RÉACTION ALLERGIQUE/ANAPHYLACTIQUE.....	95
PROBLÈMES OBSTÉTRICAUX	99
1 RÉP/OBS.1 ACCOUCHEMENT D'URGENCE.....	103
1 RÉP/OBS.2 FEMME ENCEINTE EN TRAVAIL	109
1 RÉP/OBS.4 PROCIDENCE DU CORDON	111

PROBLÈMES PÉDIATRIQUES.....	113
GÉNÉRALITÉS	115
1 RÉP/PED.1 ATTEINTE DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE	117
1 RÉP/PED.2 CONVULSIONS.....	119
1 RÉP/PED.3 DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE	121
1 RÉP/PED.4 OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES PAR UN CORPS ÉTRANGER (0-7 ANS OU < 25 KG) ..	123
1 RÉP/PED.5 RÉACTION ALLERGIQUE/ANAPHYLACTIQUE.....	125
PROBLÈMES MÉDICAUX-LÉGAUX	129
1 RÉP/MED-LEG.1 ENFANT MALTRAITÉ	131
1 RÉP/MED-LEG.2 ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE AVEC RÉANIMATION IMPRATICABLE.....	133
1 RÉP/MED-LEG.3 DIRECTIVES DE NON-INITIATION DE LA RÉANIMATION.....	135
1 RÉP/MED-LEG.4 MORT ÉVIDENTE.....	137
1 RÉP/MED-LEG.5 PRÉSENCE D'UN MÉDECIN / SAGE-FEMME SUR PLACE	139
PROBLÈMES TRAUMATIQUES.....	141
INFORMATION SUR LES PROBLÈMES TRAUMATIQUES	143
1 RÉP/ACP.TRAU APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE.....	145
1 RÉP/TRAU.1 TRAUMATISME ADULTE (INCLUANT TRAUMATISME THORACIQUE ET ABDOMINAL)	147
1 RÉP/TRAU.3 TRAUMATISME ISOLÉ DES EXTRÉMITÉS	151
1 RÉP/TRAU.4 TRAUMATISME OU BRÛLURE OCULAIRE	153
1 RÉP/TRAU.5 TRAUMATISME PÉDIATRIQUE	155
TECHNIQUES.....	159
1 RÉP/TECH.1 RETRAIT DU CASQUE PROTECTEUR.....	161
1 RÉP/TECH.2 CONTRÔLE D'HÉMORRAGIE	162
1 RÉP/TECH.3 IMMOBILISATION DE LA COLONNE VERTÉBRALE CHEZ L'ADULTE	163
1 RÉP/TECH.4 IMMOBILISATION DES EXTRÉMITÉS	165
1 RÉP/TECH.5 IMMOBILISATION DU BÉBÉ	166
1 RÉP/TECH.6 IMMOBILISATION DE L'ENFANT.....	167
1 RÉP/TECH.7 INSTALLATION DU K.E.D.....	168
1 RÉP/TECH.8 INSTALLATION DU MATELAS IMMOBILISATEUR DANS LES CAS DE TRAUMATISME	170
1 RÉP/TECH.9 OXYGÈNE	172
1 RÉP/TECH.10 TRANSPORT D'UN MEMBRE AMPUTÉ.....	173
AUTRES.....	175
PROTOCOLE DE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ	176
INTERVENTION AVEC DEA PAR LES PREMIERS RÉPONDANTS.....	176
LEXIQUE.....	177

AVANT-PROPOS

La démarche que nous vous proposons est simple. Essentiellement, elle consiste en un protocole de base, le protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP), auquel se greffent tous les autres protocoles.

Le protocole d'approche clinique préhospitalière, ou protocole de base, vise à donner au premier répondant une approche standardisée de l'évaluation de la victime. Cette approche comporte neuf (9) étapes au cours desquelles le premier répondant peut, suivant la nature du problème rencontré, faire référence à un protocole plus spécifique.

Dans toute situation, le premier répondant doit, en premier lieu, voir à la sécurité de la scène pour éviter qu'il ne devienne lui-même une victime. Une fois la sécurité de la scène assurée, il procède à l'évaluation et à la stabilisation de l'état de la victime dans l'attente des techniciens ambulanciers.

En toutes circonstances, qu'il ait dévié ou non vers un protocole particulier, le premier répondant doit toujours revenir au protocole d'approche clinique préhospitalière pour éviter d'oublier une étape qui pourrait être essentielle pour la survie de la victime ou la coordination avec les autres intervenants.

Il se peut que plus d'un protocole soit applicable dans certaines situations. Le premier répondant devra alors établir une priorité dans la série de protocoles à appliquer et veiller à leur application dans la mesure où ils ne sont pas contradictoires.

GÉNÉRALITÉS

Certains éléments des protocoles s'appliquent à toutes les interventions, nous les avons donc regroupés dans la présente section. Nous retrouvons ici de multiples composantes des protocoles, certaines s'appliquant à l'ensemble de l'intervention, certaines s'adressant qu'à un point bien précis, d'autres relevant simplement du bon jugement et de l'attitude des premiers répondants.

1. NPO (Nil Per Os)

Aucun aliment liquide ou solide ne doit être ingéré par le patient à moins d'avis contraire dans le protocole spécifique.

2. Rédaction du AS-805 – RIP

Un formulaire AS-805 doit être rédigé pour toutes les interventions où le premier répondant a eu contact avec un patient, ainsi que les interventions qui se concluent par un refus de soins.

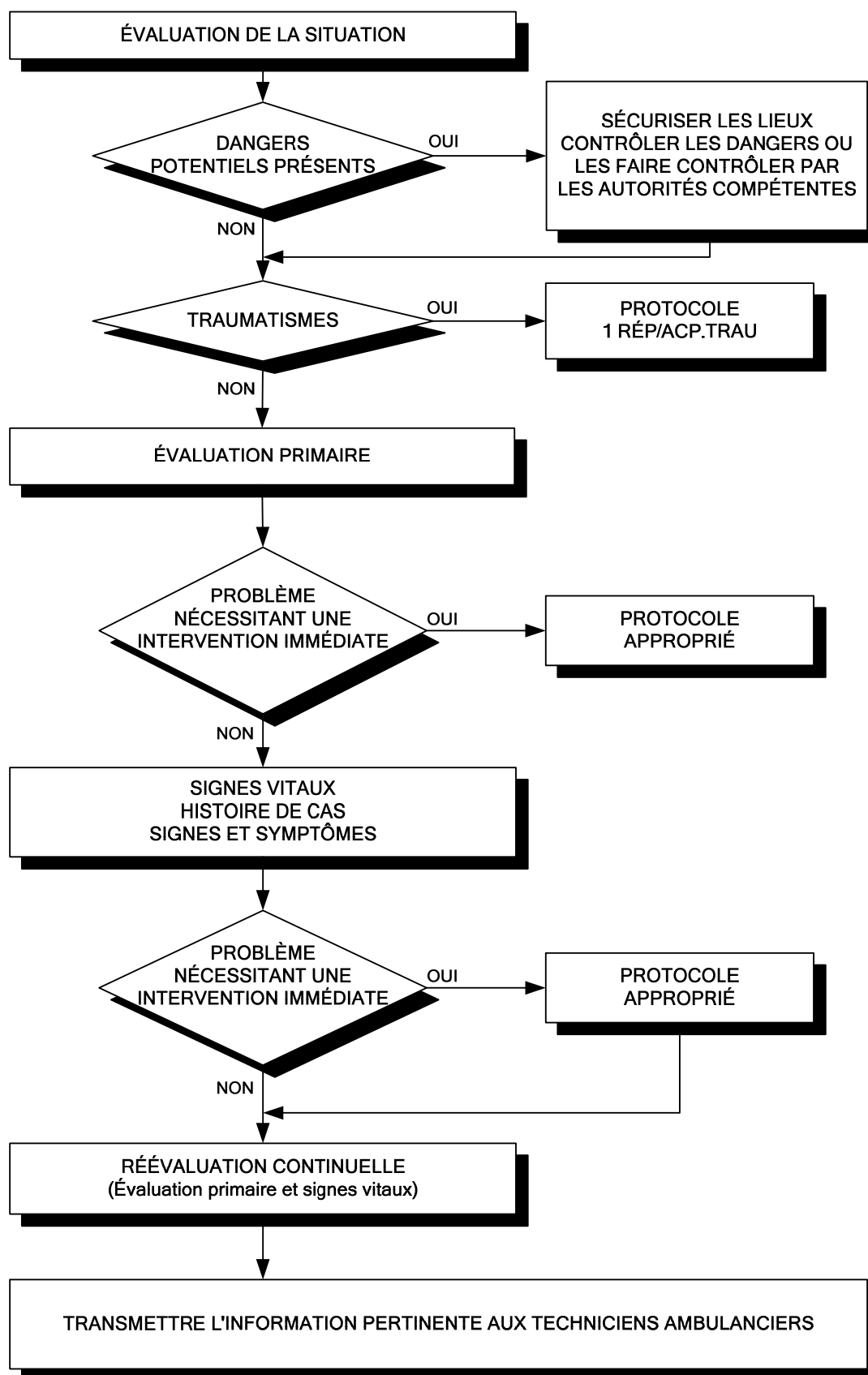
3. Consentement, aptitude et refus

Lors d'une intervention préhospitalière, un consentement de traitement doit être obtenu. Certains éléments doivent être mis en lumière :

- a) Le patient a le droit de consentir, en tout ou en partie, aux traitements offerts.
- b) Un consentement peut être donné ou retiré en tout temps.
- c) Une personne qui apparemment souffre d'un problème psychiatrique est présumée apte et peut, par le fait même, refuser d'être soignée ou transportée par les techniciens ambulanciers dans un établissement.
- d) Le mineur de 13 ans et moins est automatiquement considéré inapte.
- e) Le mineur de 14 à 17 ans peut consentir ou refuser les soins sauf si le refus peut faire atteinte à son intégrité ou à sa survie.
- f) Lorsque le patient exprime le désir de ne pas être traité, le premier répondant doit :
 - Ouvrir le DSA pour enregistrer le refus;
 - Tenter d'obtenir le consentement du patient; s'il en est incapable, il doit :
 - Évaluer l'aptitude du patient : sa capacité à prendre une décision raisonnable;
 - S'assurer, lors de l'évaluation de l'aptitude, qu'il évalue les quatre sphères d'orientation, valider la compréhension du patient des présents événements et la raison du refus;
 - S'assurer de transmettre au meilleur de ses connaissances les conséquences possibles de l'absence de traitement, selon les signes, les symptômes, etc. afin de permettre un consentement (ou refus) éclairé;
 - S'assurer de transmettre les informations de façon neutre, objective, sans pression induite et ce, afin de permettre un consentement (ou refus) libre;
 - Tenter à nouveau d'obtenir son consentement si le refus semble déraisonnable.
- g) Lorsque le patient est apte et exerce son refus, le premier répondant doit bien documenter la situation et attendre les techniciens ambulanciers. Le refus adressé aux premiers répondants se limite en effet, à la notion de soins et ne peut pas s'appliquer au transport.
- h) Lorsque le patient est inapte et refuse les soins, le premier répondant doit alors bien documenter la situation et attendre les techniciens ambulanciers. Si la collaboration du patient est impossible à obtenir, le premier répondant doit obtenir du représentant du patient (mandataire, tuteur ou curateur, conjoint légal, membre de la famille ou toute personne intéressée), le consentement au traitement.
- i) En cas d'urgence, **danger grave et immédiat**, le consentement du patient ou de son représentant n'est pas requis. Les premiers répondants doivent attendre les policiers avant d'entreprendre toute action problématique car ces derniers sont les seuls intervenants autorisés par la loi à suspendre les droits d'un individu et/ou utiliser la force « nécessaire et raisonnable ».

PROTOCOLE D'APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE 1 RÉP/ACP



Approche clinique préhospitalière

1. Évaluer la situation.

2. Dangers potentiels :

Présence de dangers potentiels

- Sécuriser les lieux, contrôler les dangers ou les faire contrôler par les autorités compétentes.

Absence de dangers potentiels

- Évaluer le nombre de victimes (mécanisme de l'accident, triage, etc.);
- Sécuriser les espaces de travail;
- Demander les ressources supplémentaires nécessaires;
- Passer à l'étape suivante.

3. Traumatismes :

Présence de traumatisme

- Se référer au protocole 1 RÉP/ACP.TRAU.

Absence de traumatisme

- Passer à l'étape suivante.

4. Évaluation primaire :

- L'**: (État de conscience) présence ou absence de réaction;
- A** : (Airway) ouverture des voies respiratoires - protection cervicale si indiqué;
- B** : (Breathing) respiration;
- C** : (Circulation) pouls;
- D** : (Disability) incapacité, niveau de conscience « AVPU »;
- E** : (Expose) découvrir la partie affectée seulement.

5. Problème durant l'évaluation primaire :

Problème nécessitant une intervention immédiate

- Débuter le protocole approprié.

Problème ne nécessitant pas une intervention immédiate

- Passer à l'étape suivante.

6. Prise des signes vitaux et histoire de cas (signes et symptômes) :

- Prise des signes vitaux : pouls (fréquence et localisation) et respiration;
- Histoire de cas O.P.Q.R.S.T. et S.A.M.P.L.E.

7. Problème rencontré durant la prise de signes vitaux et l'histoire de cas :
Problème nécessitant une intervention immédiate

- Débuter le protocole approprié.

Problème ne nécessitant pas une intervention immédiate

- Passer à l'étape suivante.

8. Réévaluation en attente des techniciens ambulanciers :

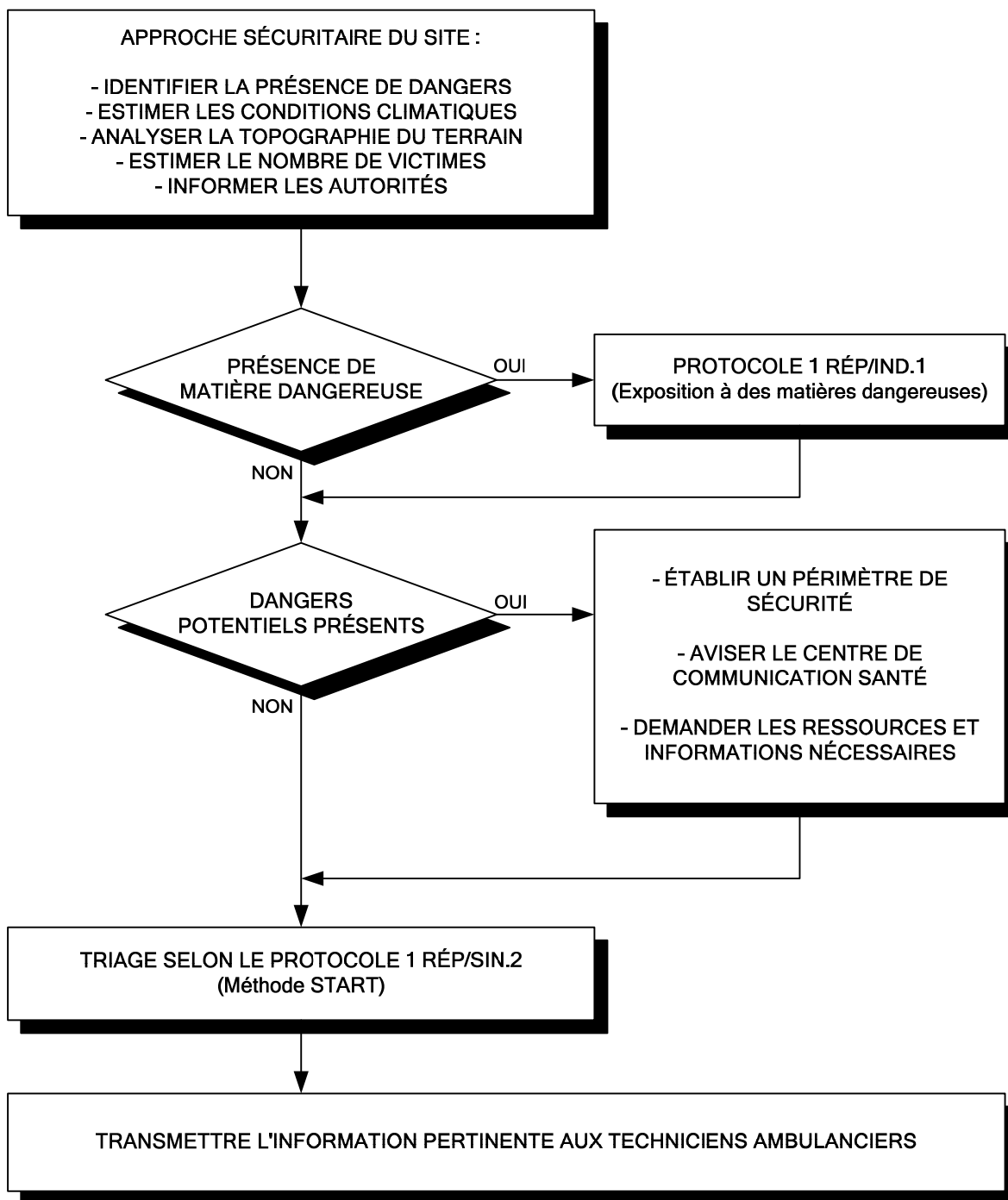
- Répéter l'évaluation primaire;
- Prise des signes vitaux aux cinq (5) minutes.

9. Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.
Remarques

- Le rapport d'intervention préhospitalière non complété ne devrait jamais retarder un transport vers le CH.
- **Respiration**
 - La respiration peut s'évaluer en termes de fréquence respiratoire, mais également en fonction de d'autres critères dont :
 - L'amplitude respiratoire (mouvement du thorax);
 - L'absence/présence de bruits respiratoires;
 - L'état de conscience A ou V;
 - Le remplissage capillaire (normalement < 2 secondes);
 - Absence/présence de cyanose;
 - Le soulèvement du thorax lors de l'assistance respiratoire.
- **Ventilation**
 - Lorsque la respiration est spontanée, l'inefficacité de la ventilation s'évalue en fonction des critères suivants :
 - État de conscience à V, P, ou U;
 - Cyanose;
 - Rythme respiratoire < 8 / minute.
- **Pouls**
 - Au moment de la prise de pouls, indiquer la localisation et la fréquence.
- **Stabilisation**
 - Intervention primaire sur les lieux et complément de stabilisation et d'histoire de cas en attente des techniciens ambulanciers.
- **OPQRST ET SAMPLE**

O.	D ébut (<u>O</u> nset)	S.	S ignes et symptômes (Signs and symptoms)
P.	P rovocation (Provocation)	A.	A llergies (Allergies)
Q.	Q ualité (Quality)	M.	M édicaments (Medications)
R.	R adiation (Radiation)	P.	P assé médical pertinent (Pertinent past history)
S.	S évérité (Severity)	L.	L e dernier repas (Last oral intake)
T.	T emps (Time)	E.	E vénements déclencheurs (Event leading to the injury or illness)

SITUATION DE SINISTRES

INTERVENTION SUR UN SITE DE SINISTRE COMPORTANT PLUSIEURS VICTIMES 1 RÉP/SIN.1

1 RÉP/SIN.1
Intervention sur un site de sinistre comportant plusieurs victimes
1. Approche sécuritaire du site :

- Identifier la présence de dangers;
- Estimer les conditions climatiques;
- Analyser la topographie du terrain;
- Estimer le nombre de victimes;
- Informer les autorités.

2. Matières dangereuses :
Présence de matières dangereuses

- Suivre le protocole 1 RÉP/IND.1 (exposition à des matières dangereuses).

Absence de matières dangereuses

- Passer à l'étape suivante.

3. Dangers potentiels :
Présence de dangers potentiels

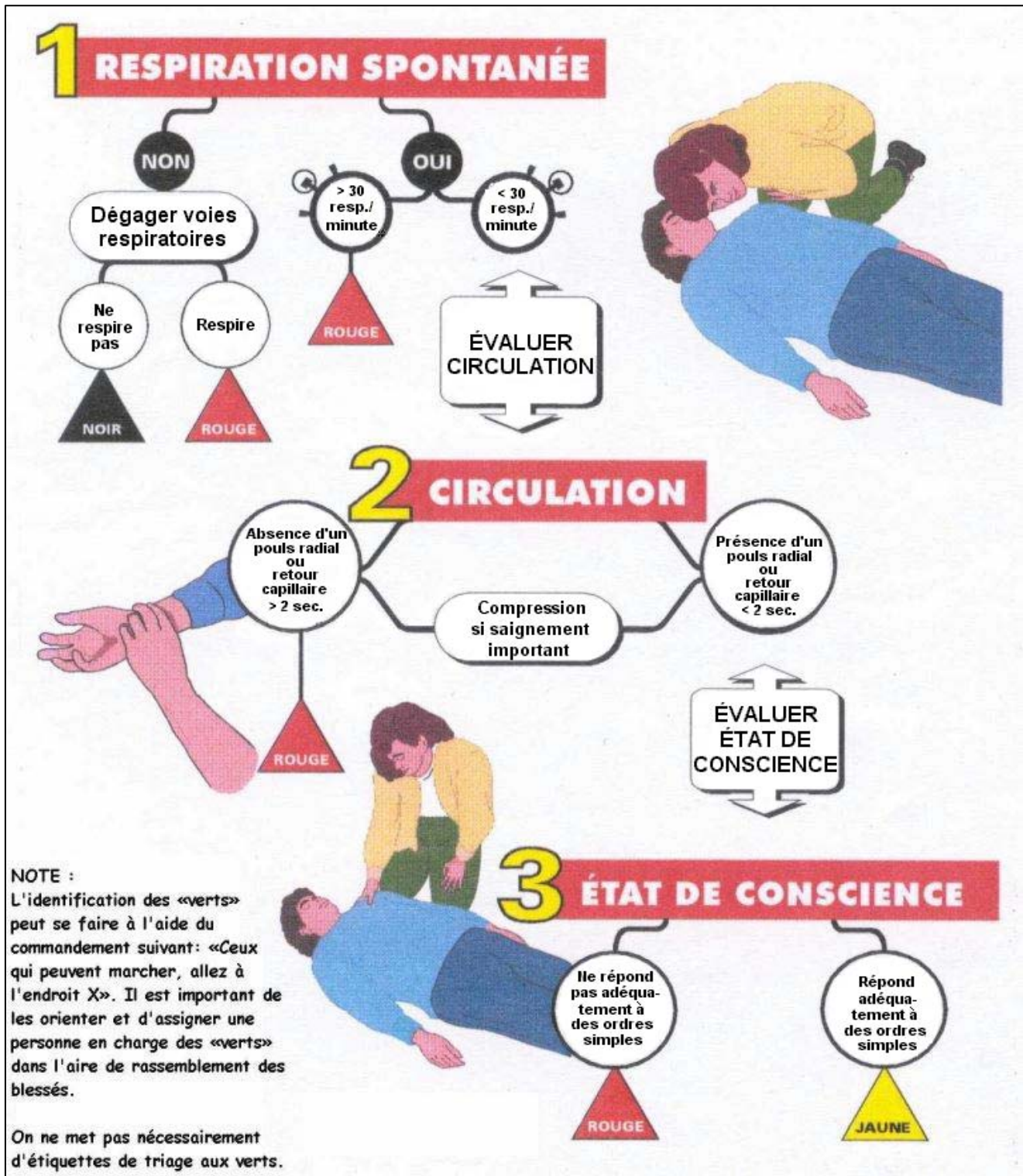
- Établir un périmètre de sécurité (aucune intervention à l'intérieure du périmètre de sécurité);
- Aviser le Centre de communication santé;
- Demander les ressources et informations nécessaires.

Absence de dangers potentiels

- Passer à l'étape suivante.

4. Triage selon la méthode START (1 RÉP/SIN.2) en attente de la première équipe de techniciens ambulanciers.
5. Transmettre l'information pertinente à la première équipe de techniciens ambulanciers et se mettre disponible pour les assister.

TRIAGE : MÉTHODE START 1 RÉP/SIN.2



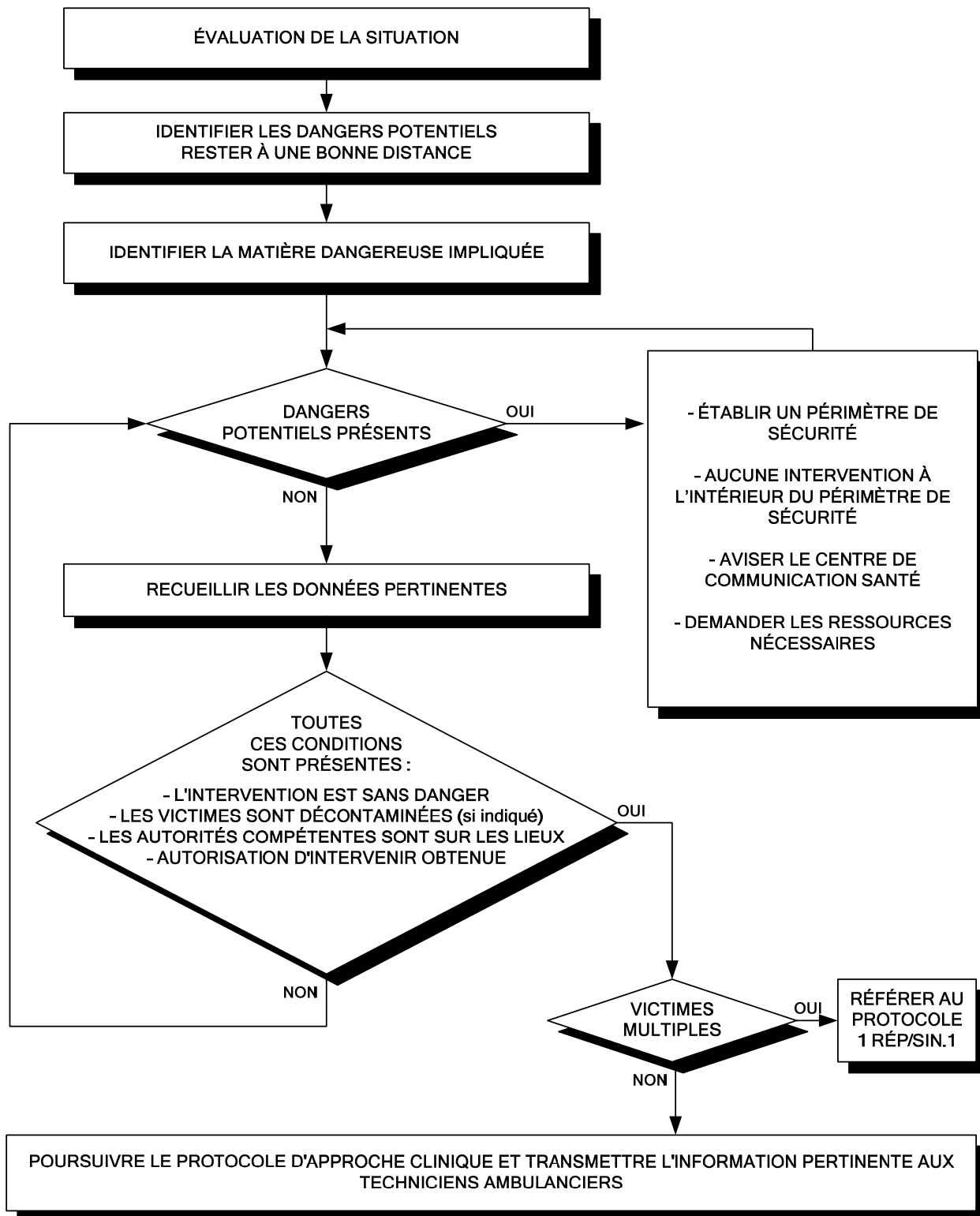
1 RÉP/SIN.2

Triage : Méthode START

1. Demander aux personnes qui peuvent marcher, de se rendre à l'endroit indiqué (identifier un endroit sécuritaire pour regrouper ces gens) :
 - Victimes classées « vertes ».
2. Évaluer la respiration :
 - Absence de respiration spontanée**
 - Ouvrir les voies respiratoires :
 - Respiration spontanée : Victime classée « Rouge »;
 - Absence de respiration spontanée : Victime classée « Noire ».
 - Présence de respiration spontanée**
 - Respiration à 30 par minute et plus : Victime classée « Rouge »;
 - Respiration à moins de 30 par minute : Passer à l'étape suivante.
3. Évaluer la circulation :
 - Absence d'un pouls radial ou retour capillaire à plus de 2 secondes**
 - Victime classée « Rouge ».
 - Présence du pouls radial ou retour capillaire à moins de 2 secondes**
 - Passer à l'étape suivante;
 - Contrôler les saignements importants.
4. Évaluer l'état de conscience :
 - Absence d'une réponse adéquate aux ordres simples**
 - Victime classée « Rouge ».
 - Présence d'une réponse adéquate aux ordres simples**
 - Victime classée « Jaune ».
5. Transmettre l'information pertinente à la première équipe de techniciens ambulanciers et se mettre disponible pour les assister.

PROBLÈMES INDUSTRIELS

**EXPOSITION A DES MATIERES DANGEREUSES,
INTERVENTION GLOBALE 1 RÉP/IND.1**



Exposition à des matières dangereuses (Intervention globale)

Au moment d'une intervention impliquant des matières dangereuses, l'évaluation de la scène devient particulièrement importante puisqu'il en va de la sécurité des intervenants. Une attention particulière doit donc être portée à cette étape dans le protocole d'approche clinique préhospitalière. Cette approche est décrite ci-dessous afin de s'assurer que le premier répondant ne prenne aucun risque qui pourrait s'avérer préjudiciable à sa santé ou à sa sécurité.

Le sauvetage et la décontamination des victimes d'une exposition aux matières dangereuses doivent être effectués par les autorités compétentes (service d'incendie ou équipe spécialisée). **La responsabilité du premier répondant est de s'assurer que ces étapes ont été effectuées avant la prise en charge de la victime.**

1. Évaluer la situation.

2. Identifier les dangers potentiels :

Dangers potentiels présents

- Identifier les dangers potentiels à bonne distance :
 - Du site industriel (se référer aux personnes compétentes);
 - De l'accident routier : respecter un périmètre de sécurité;
 - Stationner le véhicule des premiers répondants à une distance raisonnable;
 - Revêtir un vêtement individuel de protection, si disponible.
- Identification, à l'aide du Guide nord-américain des mesures d'urgence, des matières impliquées : plaque, fiche signalétique;
- Si un ou des dangers potentiels sont suspectés :
 - Établir un périmètre de sécurité;
 - Aucune intervention à l'intérieur du périmètre de sécurité;
 - Aviser le Centre de communication santé.
 - Demander les ressources nécessaires.

Danger potentiel absent

- Passer à l'étape suivante.

3. Recueillir les données pertinentes :

- Poursuivre l'évaluation de la situation en identifiant les autorités compétentes et s'y référer : service d'incendie, responsable du site industriel ou toute autorité reconnue.

4. Respecter les quatre conditions suivantes avant de passer à la prochaine étape :

- L'intervention est sans danger ou les dangers ont été contrôlés;
- La décontamination de la victime, si nécessaire, a été faite par les ressources compétentes;
- Les autorités compétentes sont sur les lieux;
- L'autorisation d'intervenir a été obtenue des autorités compétentes.

Une réponse négative à une ou plusieurs des conditions énumérées ci-dessus

- Se référer à l'étape 2 (Dangers potentiels présents).

Une réponse positive aux quatre conditions énumérées ci-dessus doit être obtenue avant de passer à l'étape suivante.
5. Évaluer le nombre de victimes :
Présence de plusieurs victimes

- Se référer au protocole 1 RÉP/SIN.1 (Intervention sur un site de sinistre comportant plusieurs victimes).

Absence de plusieurs victimes

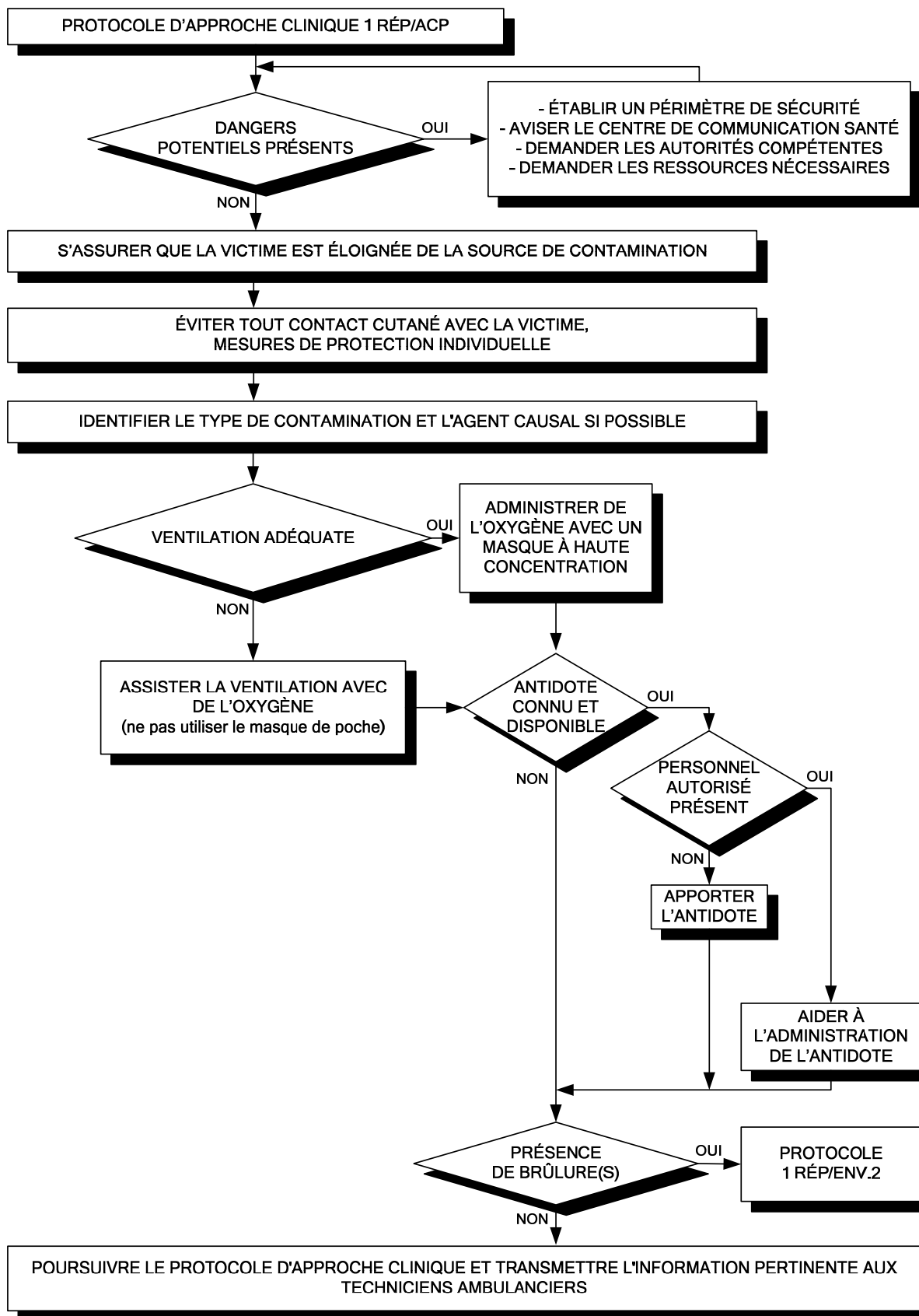
- Passer à l'étape suivante.

6. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente sur l'état de la victime aux techniciens ambulanciers.
Remarques

- Aviser le personnel administratif de toute exposition des ressources à des matières dangereuses afin de permettre leur décontamination et celle des équipements avant la remise en service.
- Rapporter toute situation avec le maximum d'information afin de permettre un suivi médical.

Le vêtement de protection n'est pas conçu pour la protection contre les matières dangereuses. Il est important de rester vigilant et de respecter les consignes établies par les autorités compétentes.

EXPOSITION À DES SUBSTANCES TOXIQUES 1 RÉP/IND.2



Exposition à des substances toxiques

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).

2. Identifier les dangers potentiels :

- Identifier les dangers potentiels à bonne distance du site industriel : se référer aux personnes compétentes; respecter un périmètre de sécurité; stationner le véhicule des premiers répondants à une distance raisonnable; revêtir un vêtement individuel de protection, si disponible.
- Identification, à l'aide du *Guide nord-américain des mesures d'urgence*, des matières impliquées : plaque, fiche signalétique.

Dangers potentiels présents

- Établir un périmètre de sécurité;
- Aucune intervention à l'intérieur du périmètre de sécurité;
- Aviser le Centre de communication santé;
- Demander les autorités compétentes;
- Demander les ressources nécessaires.

Danger potentiel absent

- Passer à l'étape suivante.

3. S'assurer que la victime est éloignée de la source de contamination.

4. Appliquer les mesures de protection et éviter tout contact cutané avec la victime.

5. Identifier le type de contamination et l'agent causal si possible.

6. Évaluer la ventilation :

Ventilation inadéquate

- Assister la ventilation avec un appareil mécanique et administrer de l'oxygène.
(Ne pas utiliser le masque de poche car danger de contamination)

Ventilation adéquate

- Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.

7. Vérifier si l'antidote est disponible :

Antidote connu et disponible

- Personnel autorisé présent : aider à l'administration de l'antidote;
- Personnel autorisé absent : remettre l'antidote aux techniciens ambulanciers;
- Passer à l'étape suivante.

Antidote inconnu et non disponible

- Passer à l'étape suivante.

8. Vérifier la présence de brûlures :**Présence de brûlures**

- Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.2 (Brûlures).

Absence de brûlures

- Poursuivre le protocole.

9. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.**Renseignements requis**

- Nature du contaminant (fiche signalétique si disponible).
- Temps d'exposition au contaminant.
- Temps écoulé depuis la contamination.

Remarques

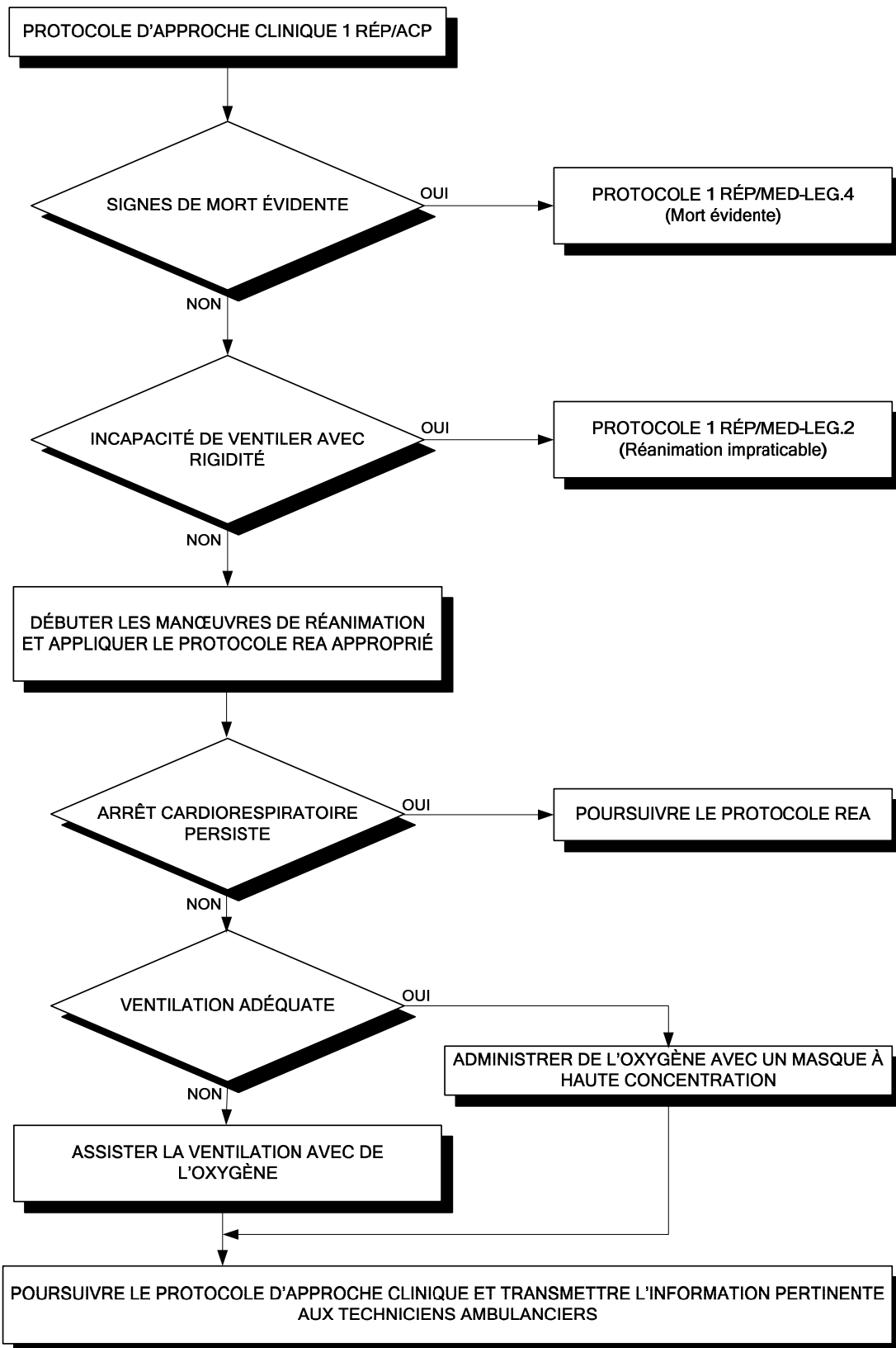
- Dans le cas d'intoxication par substances toxiques, ne jamais ventiler la victime en utilisant les techniques de bouche à bouche ou de bouche à masque.
- Inhalation simple : il est possible que la victime n'ait pas besoin de décontamination.

Principes de décontamination

- S'assurer que la partie affectée a été découverte, retirer les vêtements et les bijoux contaminés.
- Si la substance est une poudre, broser la victime.
- Rincer la partie affectée avec une grande quantité d'eau sans contaminer les régions saines (attention aux produits réactifs à l'eau).

SITUATIONS DE RÉANIMATION

INTERVENTION GLOBALE 1 RÉP/REA.O



1 RÉP/REA.0
Intervention globale – arrêt cardiorespiratoire

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Activer le défibrillateur externe automatisé au contact visuel du patient.
3. En présence de signe de mort évidente, se référer au protocole 1 RÉP/MED-LEG.4 (Mort évidente).
4. Confirmer l'ACR par l'évaluation de l'ABC et procéder simultanément à l'installation des électrodes de défibrillation sauf si impossibilité d'ouvrir les voies respiratoires et de ventiler en raison d'une rigidité cadavérique; se référer au protocole 1 RÉP/MED-LEG.2 (ACR avec réanimation impraticable).
5. En présence d'une ordonnance de non réanimation, se référer au protocole 1 RÉP/MED-LEG.3 (Ordonnance de non réanimation).
6. Débuter les manœuvres de réanimation et appliquer le protocole de réanimation approprié :
 - Arrêt cardiorespiratoire médicale – adulte; (1 RÉP/REA.1)
 - Arrêt cardiorespiratoire traumatique – adulte; (1 RÉP/REA.3)
 - Arrêt cardiorespiratoire médical – pédiatrie; (1 RÉP/REA.5)
 - Arrêt cardiorespiratoire traumatique – pédiatrie. (1 RÉP/REA.6)
7. Au moment où des mouvements sont perçus auprès de la victime, arrêter la RCR et vérifier la présence de signes de circulation, incluant le pouls.
8. En présence de signes de circulation chez la victime :
 - Ventilation spontanée adéquate**
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration à 10 L/min ou plus;
 - Si l'état d'éveil est V, P ou U, installer la victime en position latérale de sécurité et administrer de l'oxygène à haute concentration à 10 L/min ou plus.
 - Ventilation spontanée inadéquate**
 - Assister la ventilation et continuer d'administrer de l'oxygène à haute concentration à 10 L/min ou plus.
9. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Renseignements requis

- Circonstances de l'événement.
- Temps depuis l'arrêt.
- Avec ou sans témoin.
- RCR débutée ou non avant l'arrivée des premiers répondants.
- Utilisation d'un DEA avant l'arrivée des premiers répondants.
- Nombre de chocs donnés.

Remarques

- L'utilisation de la canule oropharyngée et de l'oxygène doit se faire le plus rapidement possible.
- Si le patient est réanimé et redevient en ACR, recommencer le protocole d'ACR depuis le début.
- À l'arrivée des techniciens ambulanciers, continuer le protocole tel que prévu et suivre les indications des techniciens ambulanciers.
- La ventilation spontanée d'une victime devrait être jugée inadéquate lorsque le premier répondant constate un des deux signes suivants ou les deux :
 - ♦ Mauvaise coloration;
 - ♦ Fréquence respiratoire < 8 / minute.

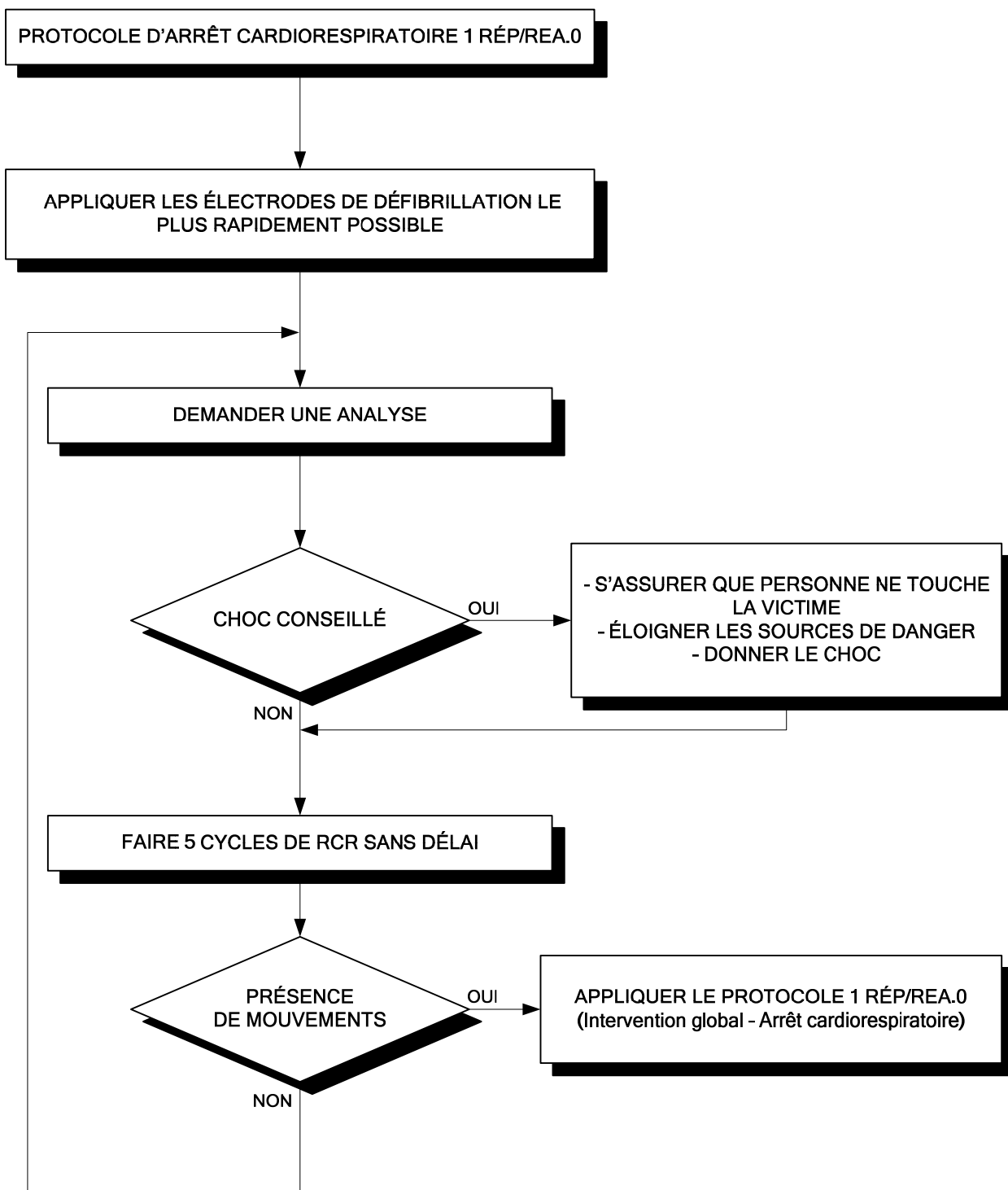
Exclusion à la défibrillation

- Enfant de moins d'un an.

ATTENTION :

Chez l'enfant inanimé, si le pouls est < 60 / minute avec des signes de mauvaise perfusion (pâleur, cyanose), il faut débiter la RCR selon les normes de la FMCQ.

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE MÉDICAL – ADULTE 1 RÉP/REA.1



1 RÉP/REA.1
Arrêt cardiorespiratoire médical – adulte

1. Se référer au protocole d'intervention globale – arrêt cardiorespiratoire (1 RÉP/REA.0).
2. Appliquer les électrodes de défibrillation le plus rapidement possible.
3. Demander une analyse (DEA) :

Choc non conseillé

- Reprendre la RCR sans délais (étape 4).

Choc conseillé

- S'assurer que personne ne touche la victime et éloigner les sources de danger (ex : oxygène), charger et donner le choc.
- Reprendre la RCR sans délais (étape 4).

4. Faire cinq cycles de RCR selon les normes de la FMCQ.
5. Répéter les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à ce que la victime présente des mouvements ou jusqu'à ce que les techniciens ambulanciers prennent la relève.

Si présence de mouvements

- Continuer le protocole d'intervention globale – arrêt cardiorespiratoire (1 RÉP/REA.0).

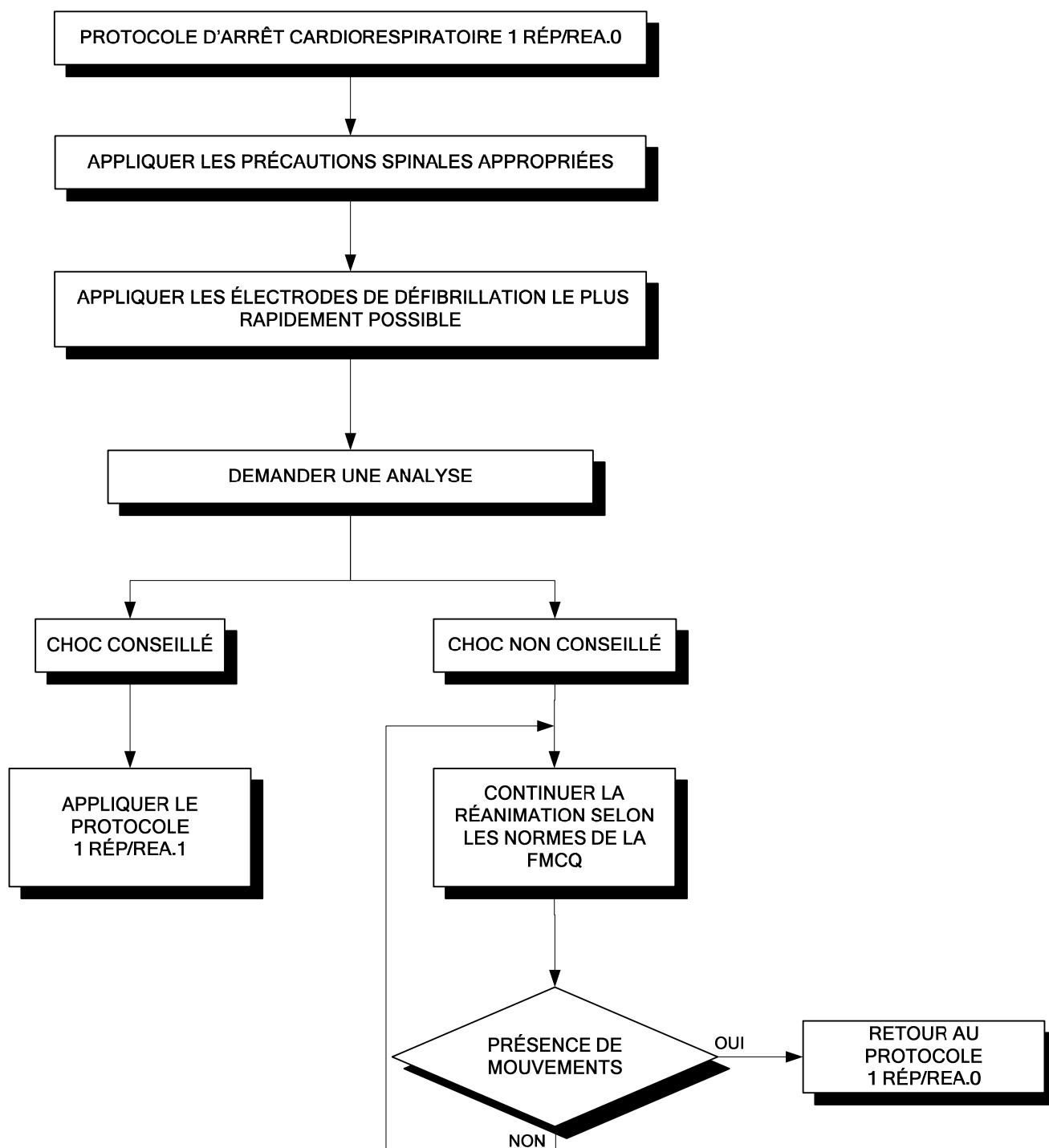
Si les techniciens ambulanciers prennent la relève

- Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes.

Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la relève

- Continuer le protocole 1 RÉP/REA.1.

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE TRAUMATIQUE – ADULTE 1 RÉP/REA.3



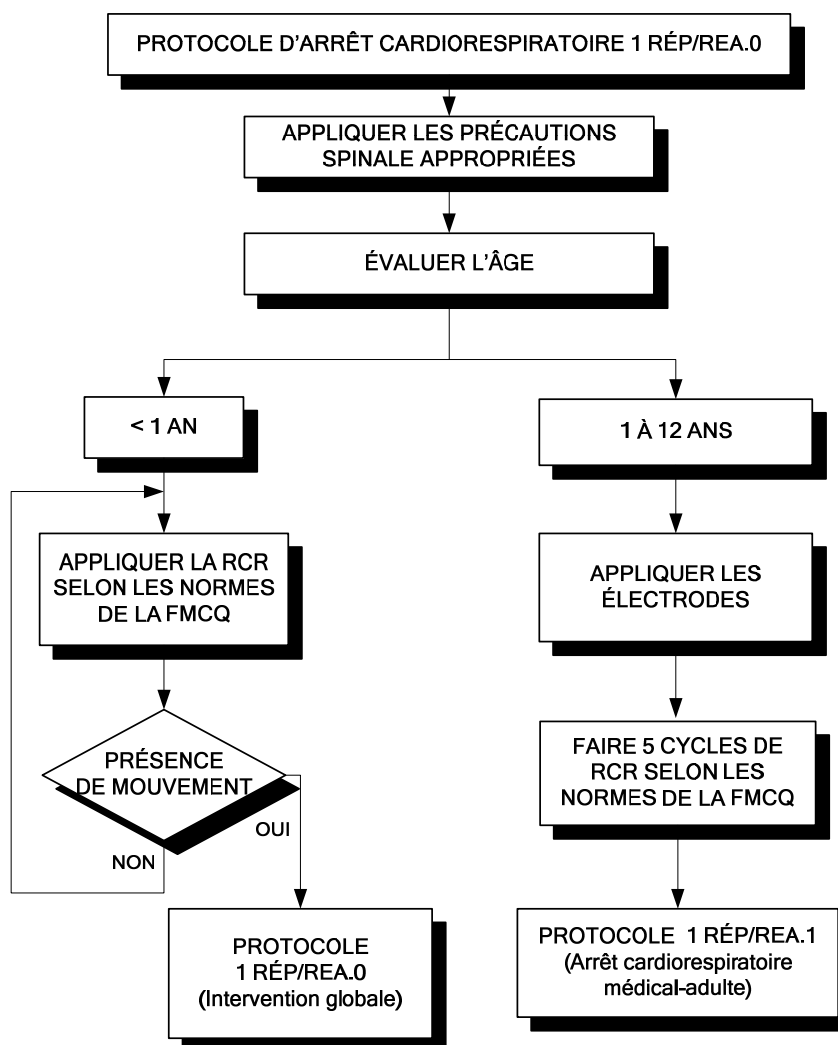
1 RÉP/REA.3

Arrêt cardiorespiratoire traumatique adulte

Critère d'inclusion :

Tout arrêt cardiorespiratoire dans un contexte traumatique avec impact à haute vitesse ou plaie pénétrante.

1. Se référer au protocole d'intervention globale – arrêt cardiorespiratoire (1 RÉP/REA.0).
2. Appliquer les précautions spinales appropriées et procéder simultanément à l'installation des électrodes de défibrillation.
3. Demander une analyse :
 - Choc non conseillé**
 - Reprendre la RCR sans délais à l'étape 4.
 - Choc conseillé**
 - Appliquer le protocole 1 RÉP/ REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire médical – adulte).
4. Faire la RCR selon les normes de la FMCQ, sans refaire d'analyse, jusqu'à ce que la victime présente des mouvements ou jusqu'à ce que les techniciens ambulanciers prennent la relève.
 - Si présence de mouvements**
 - Continuer le protocole 1 RÉP/REA.0 (Intervention globale – arrêt cardiorespiratoire).
 - Si les techniciens ambulanciers prennent la relève**
 - Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes.
 - Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la relève**
 - Continuer le protocole 1 RÉP/REA.3.

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE MÉDICAL – PÉDIATRIE 1 RÉP/REA.5

1 RÉP/REA.5
Arrêt cardiorespiratoire médical – pédiatrie

1. Se référer au protocole d'intervention globale – arrêt cardiorespiratoire (1 RÉP/REA.O).

2. Évaluer l'âge du patient :

Pour les bébés de moins d'un an :

- Faire la RCR selon les normes de la FMCQ.
- Passer à l'étape 3.

Pour les enfants de 1 à 12 ans :

- Installer le DEA et appliquer les électrodes.
- Faire cinq cycles de RCR selon les normes de la FMCQ, **sauf** si l'ACR est survenu en présence des PR et qu'il est subit et inattendu.
- Appliquer immédiatement le protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire médical – adulte).

3. Continuer les manœuvres de réanimation jusqu'à ce que la victime présente des mouvements ou jusqu'à ce que les techniciens ambulanciers prennent la relève.

Si présence de mouvements

- Continuer le protocole 1 RÉP/REA.0 (Intervention globale – arrêt cardiorespiratoire).

Si les techniciens ambulanciers prennent la relève

- Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes.

Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la relève

- Continuer le protocole 1 RÉP/REA.5

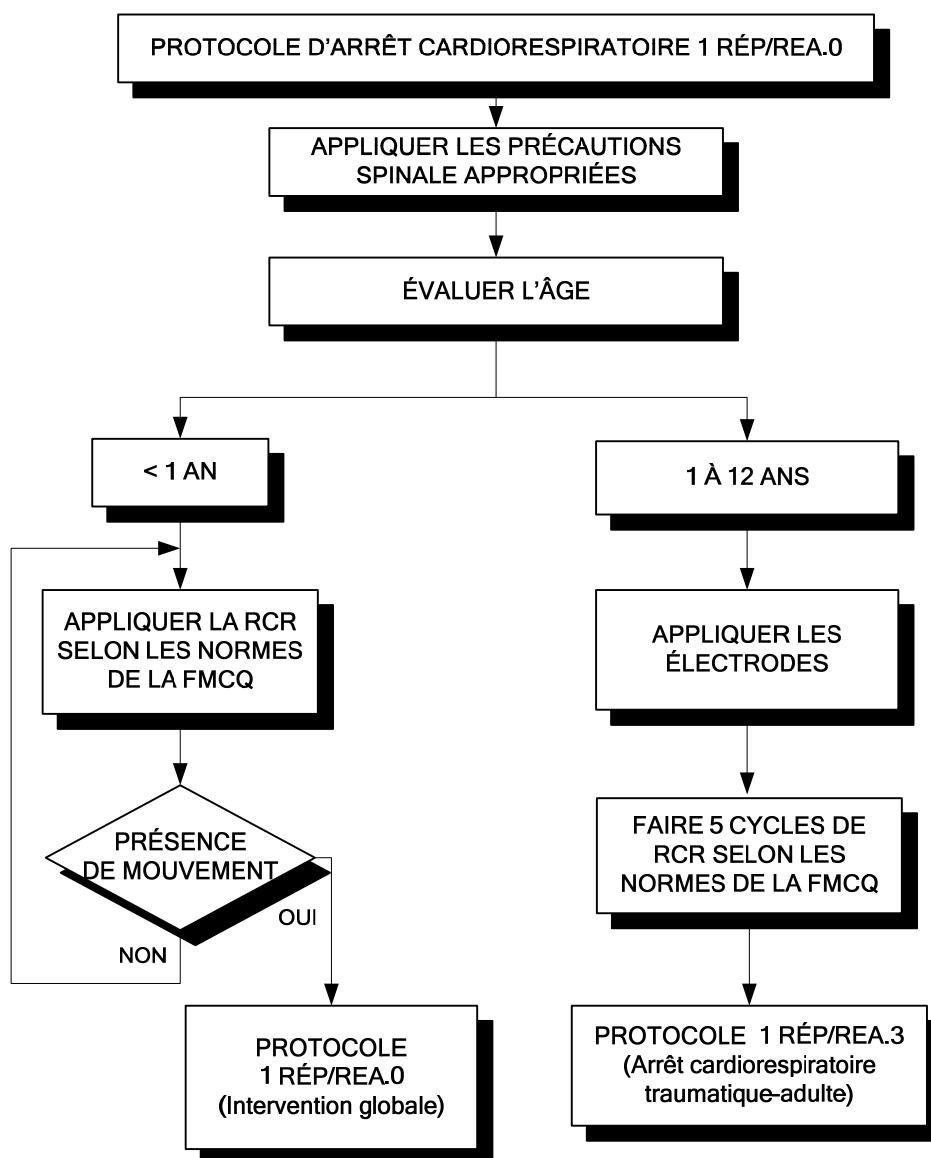
Remarques

- Surveillance continue et réévaluation des signes vitaux chez l'enfant en arrêt cardiorespiratoire.
- Toujours suspecter la présence d'une obstruction des voies respiratoires.
- Appliquer les électrodes pédiatriques / réducteur d'énergie si disponible en position antérolatéral. Sinon, appliquer les électrodes adultes en antéropostérieur.

ATTENTION :

Chez l'enfant inanimé, si le pouls est < 60 / minute avec des signes de mauvaise perfusion (pâleur, cyanose), il faut débiter la RCR selon les normes de la FMCQ.

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE TRAUMATIQUE – PÉDIATRIE 1 RÉP/REA.6



1 RÉP/REA.6
Arrêt cardiorespiratoire traumatique – pédiatrie
Critère d'inclusion :

Tout arrêt cardiorespiratoire dans un contexte traumatique avec impact à haute vitesse ou plaie pénétrante chez un enfant.

1. Se référer au protocole d'intervention globale – arrêt cardiorespiratoire (1 RÉP/REA.0).
2. Appliquer les précautions spinales appropriées.
3. Évaluer l'âge du patient :
 - Pour les bébés de moins d'un an :
 - Passer à l'étape 4.
 - Pour les enfants de plus de 1 an :
 - Installer le DEA et appliquer les électrodes.
 - Faire cinq cycles de RCR selon les normes de la FMCQ.
 - Appliquer immédiatement le protocole 1 RÉP/REA.3 (Arrêt cardiorespiratoire traumatique-adulte).
4. Faire la RCR selon les normes de la FMCQ, jusqu'à ce que la victime présente des mouvements ou jusqu'à ce que les techniciens ambulanciers prennent la relève.
 - Si présence de mouvements
 - Continuer le protocole 1 RÉP/REA.0 (Intervention globale – arrêt cardiorespiratoire).
 - Si les techniciens ambulanciers prennent la relève
 - Assister les techniciens ambulanciers et suivre leurs consignes.
 - Si aucun mouvement et les techniciens ambulanciers ne sont pas prêts à prendre la relève
 - Continuer le protocole 1 RÉP/REA.6.

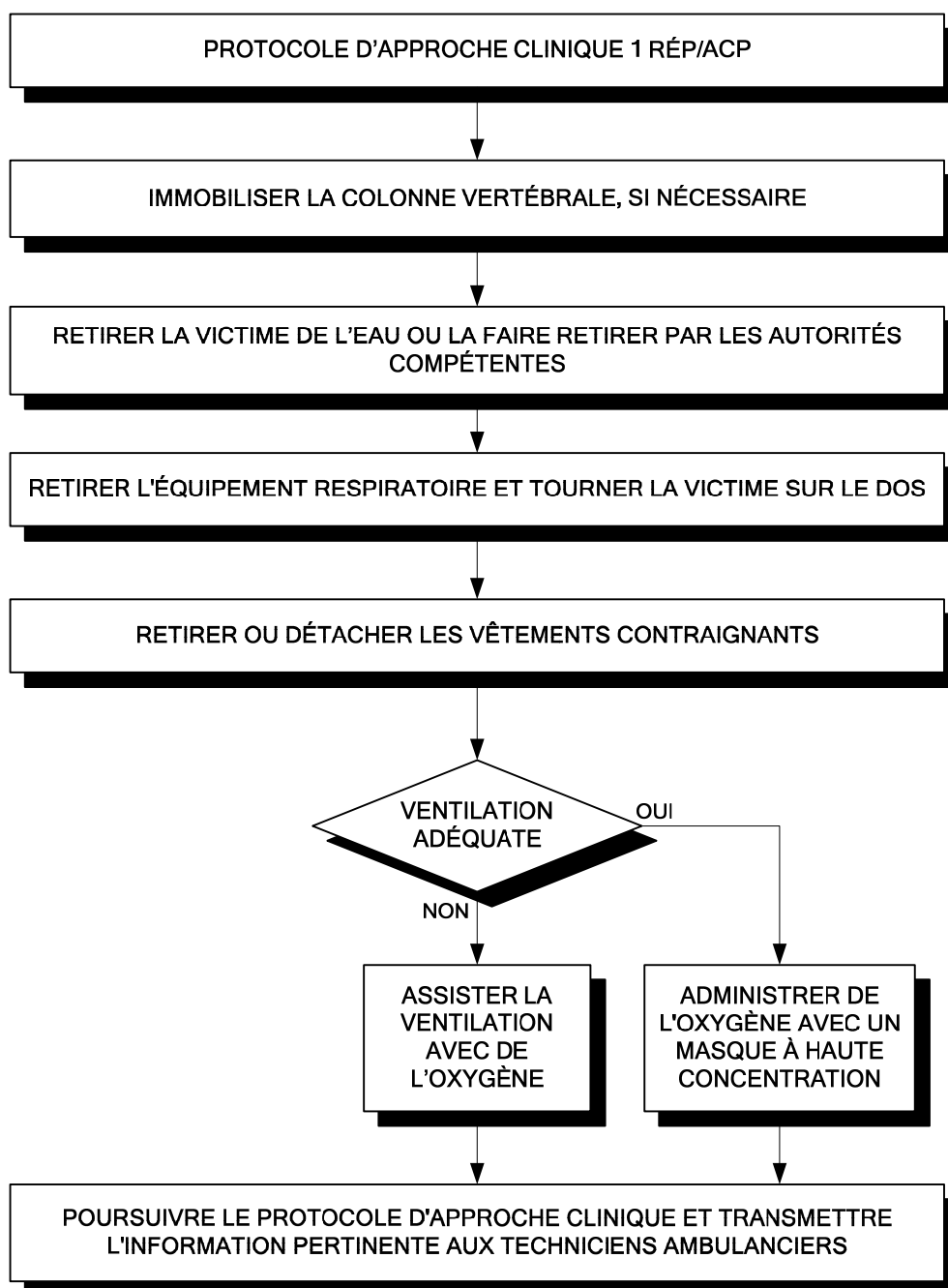
Remarques

- Surveillance continue et réévaluation des signes vitaux chez l'enfant en arrêt cardiorespiratoire.
- Toujours suspecter la présence d'une obstruction des voies respiratoires.
- Appliquer les électrodes pédiatriques / réducteur d'énergie si disponible en position antérolatérale. Sinon, appliquer les électrodes adultes en antéropostérieur.

ATTENTION :

Chez l'enfant inanimé, si le pouls est < 60 / minute avec des signes de mauvaise perfusion (pâleur, cyanose), il faut débiter la RCR selon les normes de la FMCQ.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX

ACCIDENT DE PLONGÉE 1 RÉP/ENV.1

Accident de plongée

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Immobiliser la colonne vertébrale si nécessaire.
3. Retirer la victime de l'eau ou la faire retirer par les autorités compétentes.
4. Retirer l'équipement respiratoire et tourner la victime sur le dos.
5. Retirer ou détacher les vêtements contraignants.
6. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
7. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

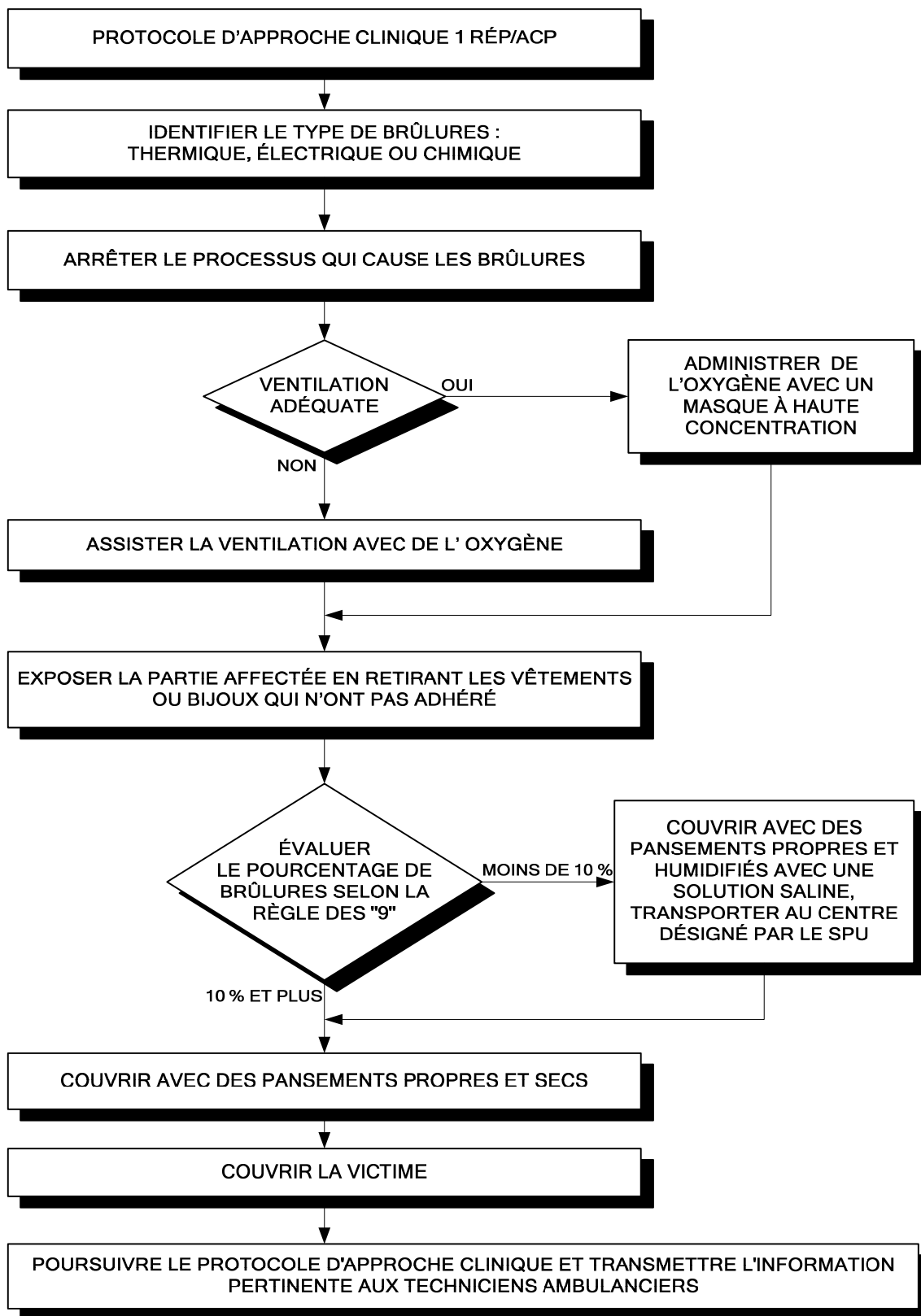
Renseignements requis

- Profondeur de la plongée.
- Durée de la plongée.
- Nombre de plongées.
- Temps écoulé depuis la plongée.
- Le carnet de plongée ou l'ordinateur de plongée si disponible.
- Informations sur la remontée.
- Mélange de gaz utilisé.
- Transport aérien prévu dans les 24/48 heures après la plongée.

Remarque

- Attention aux dangers de traumatisme; appliquer le ou les protocoles appropriés selon la situation et l'état de la victime.

BRÛLURES 1 RÉP/ENV.2



Brûlures

Critères d'inclusion :

Brûlure(s) électrique(s).
 Brûlure(s) chimique(s).
 Brûlure(s) thermique(s).

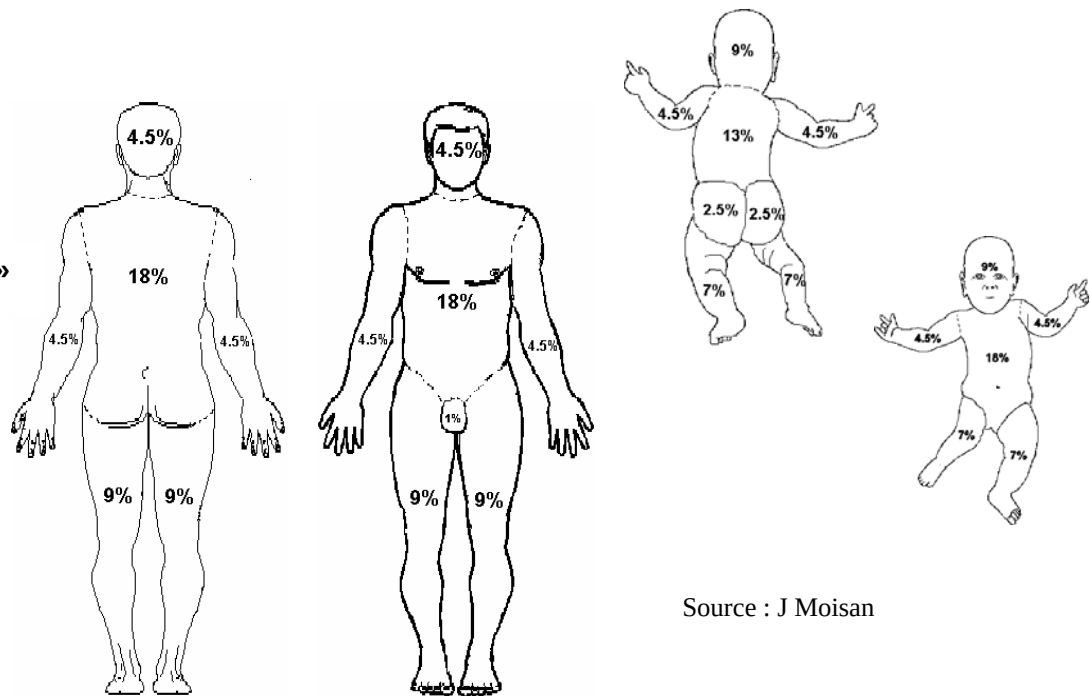
1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Identifier le type de brûlures (thermique, électrique, chimique).
3. Arrêter le processus qui cause les brûlures (si possible).
4. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
5. Exposer la partie affectée en retirant les vêtements ou bijoux qui n'ont pas adhéré.
6. Évaluer le pourcentage de brûlures selon la règle des « 9 » :
 - Brûlures de moins de 10 % selon la règle des « 9 »
 - Couvrir les brûlures avec des pansements propres stériles (des pansements humidifiés avec une solution saline peuvent être appliqués). Attention aux agents chimiques réactifs à l'eau.
 - Brûlures de plus de 10 % selon la règle des « 9 »
 - Couvrir avec des pansements propres et secs.
7. Couvrir la victime :
 - La victime de brûlures est plus sensible à l'hypothermie.
8. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Renseignements requis

- Cause des brûlures.
- Possibilité de traumatisme associé.
- Présence de fumée.
- Durée d'exposition.

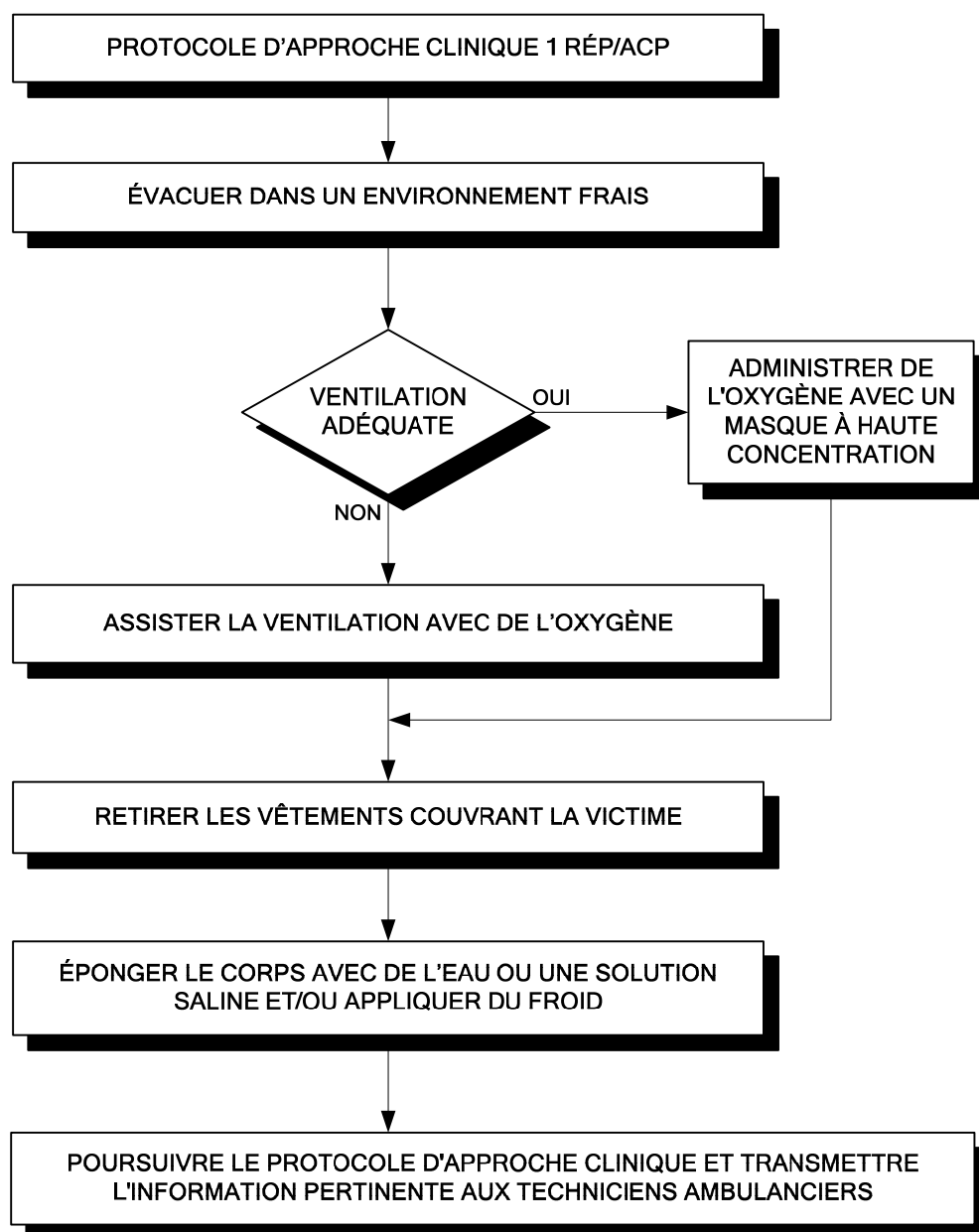
Remarques

- Évaluer l'étendue des brûlures en utilisant la règle des « 9 ».
- Les brûlures de grandes superficies ou les brûlures du visage, des mains, des pieds et des organes génitaux doivent être considérées comme des brûlures nécessitant des soins spécialisés.
- Lors de brûlures au visage, toujours considérer la possibilité de brûlures des voies respiratoires, même en l'absence de signes et de symptômes.
- Les signes de brûlures du système respiratoire incluent des brûlures nasales et oropharyngées, des bruits anormaux de la respiration, une coloration noire de la langue ou de la base des narines et des expectorations noirâtres. Ces signes sont des indices d'éventuelles complications respiratoires.
- Attention aux agents chimiques réactifs à l'eau.
- Ne jamais percer les cloques.

Règle des « 9 »


Source : J Moisan

COUP DE CHALEUR 1 RÉP/ENV.3



1 RÉP/ENV.3

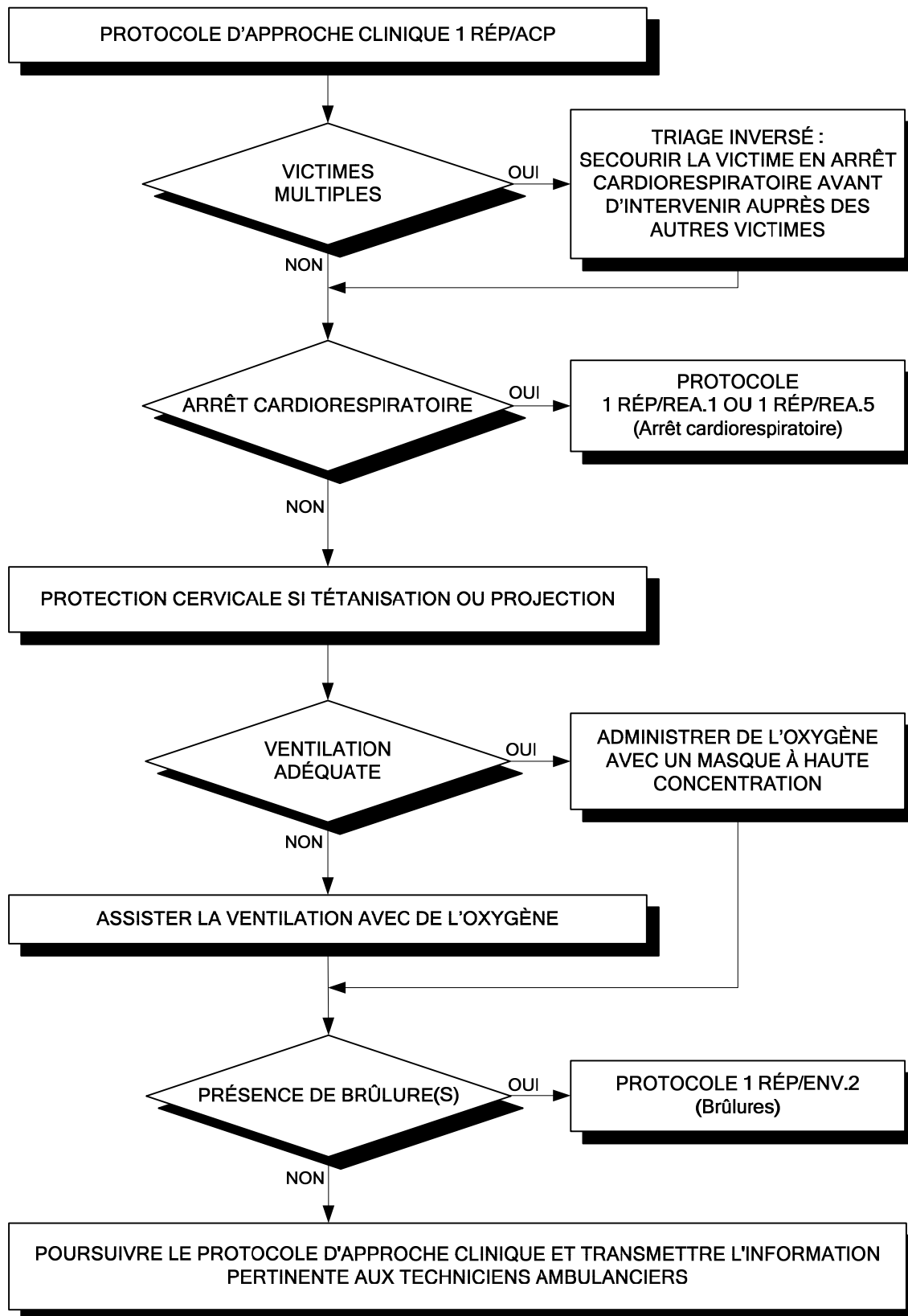
Coup de chaleur

Critère d'inclusion :

Victime exposée à un environnement chaud, avec ou sans exercice, avec changement de l'état de conscience ou état confusionnel/combatif.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Évacuer la victime dans un environnement frais.
3. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
4. Retirer les vêtements couvrant la victime.
5. Rafraîchir la victime en épongeant tout le corps avec de l'eau ou une solution saline et/ou en appliquant du froid au niveau axillaire et/ou inguinal, si disponible.
6. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

ÉLECTRISATION / ÉLECTROCUTION 1 RÉP/ENV.4



1 RÉP/ENV.4

Électrisation / Électrocution

L'environnement de la victime électrisée pose un danger pour les intervenants. Le premier répondant doit toujours assurer sa protection avant d'intervenir. Le circuit électrique doit être interrompu par du personnel qualifié. Le premier répondant doit se tenir loin de la source électrique lorsqu'il administre les soins à la victime.

Critères d'inclusion :

- Brûlure par arc électrique.
- Toute personne atteinte par une décharge électrique.

1. **Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).**
2. **Si arrêt cardiorespiratoire :**
 - Se référer au protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire).
 - S'il s'agit d'un incident d'électrisation avec victimes multiples, le principe de triage inversé doit être appliqué. Secourir en priorité les victimes qui sont en arrêt cardiorespiratoire avant d'intervenir auprès des autres victimes.
3. **Assurer une protection cervicale si histoire de téτανisation ou de projection.**
4. **Évaluer la ventilation :**
 - Ventilation inadéquate**
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate**
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
5. **Vérifier la présence de brûlures :**
 - Présence de brûlures**
 - Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.2 (Brûlures).
 - Absence de brûlures**
 - Passer à l'étape suivante.
6. **Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.**

**L'électricité peut causer des blessures internes graves sans signe extérieur, elle peut aussi causer des arythmies cardiaques ou un arrêt cardiorespiratoire.
Surveiller étroitement ces victimes.**

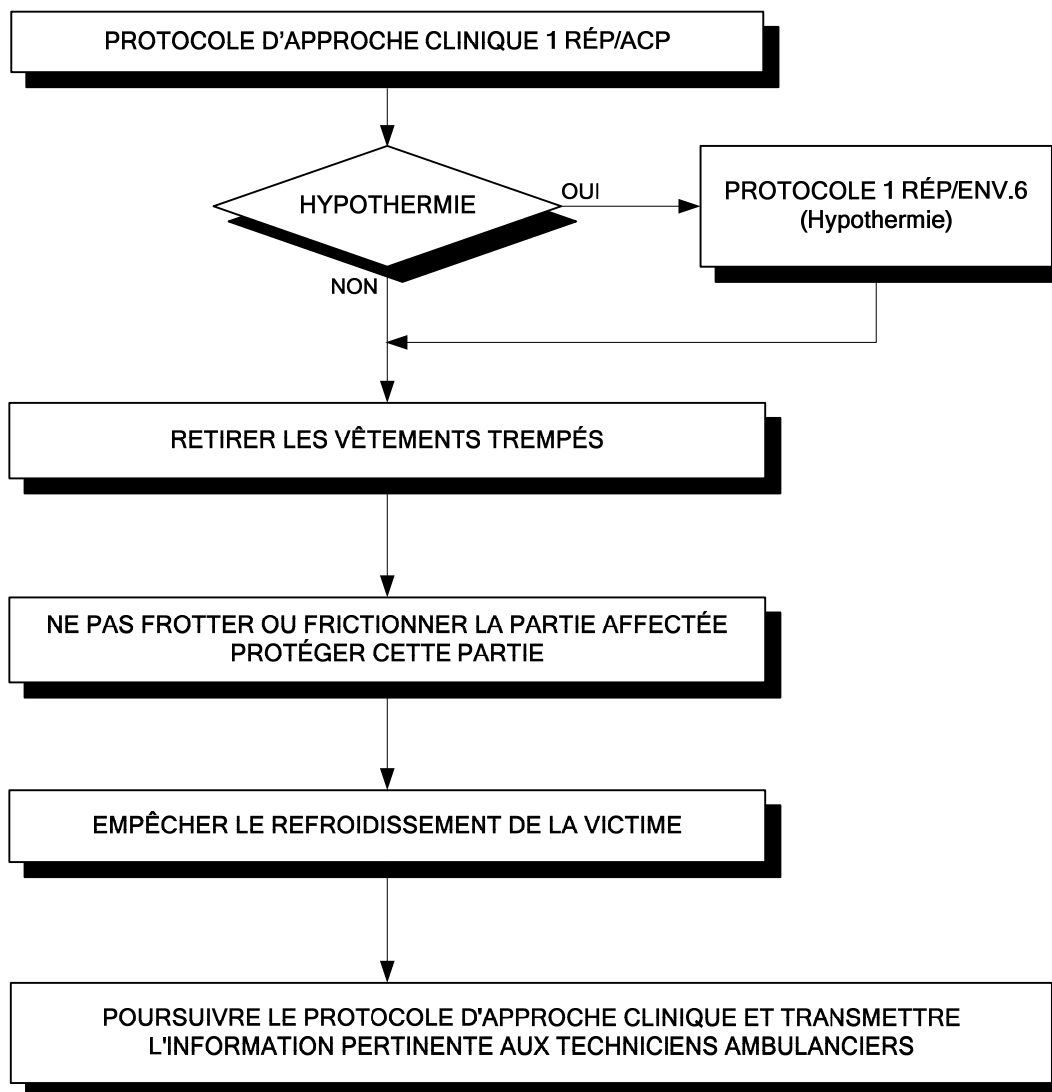
Renseignements requis

- Obtenir une histoire des circonstances d'électrisation, histoire de syncope, intensité et nature du courant (voltage, ampérage).
- Surveiller les signes de traumatisme. L'électrisation peut provoquer une contraction violente des muscles pouvant projeter la victime.

Remarque

- La sévérité des blessures dépend de la durée d'exposition et de la quantité d'énergie.

ENGELURE 1 RÉP/ENV.5



1 RÉP/ENV.5

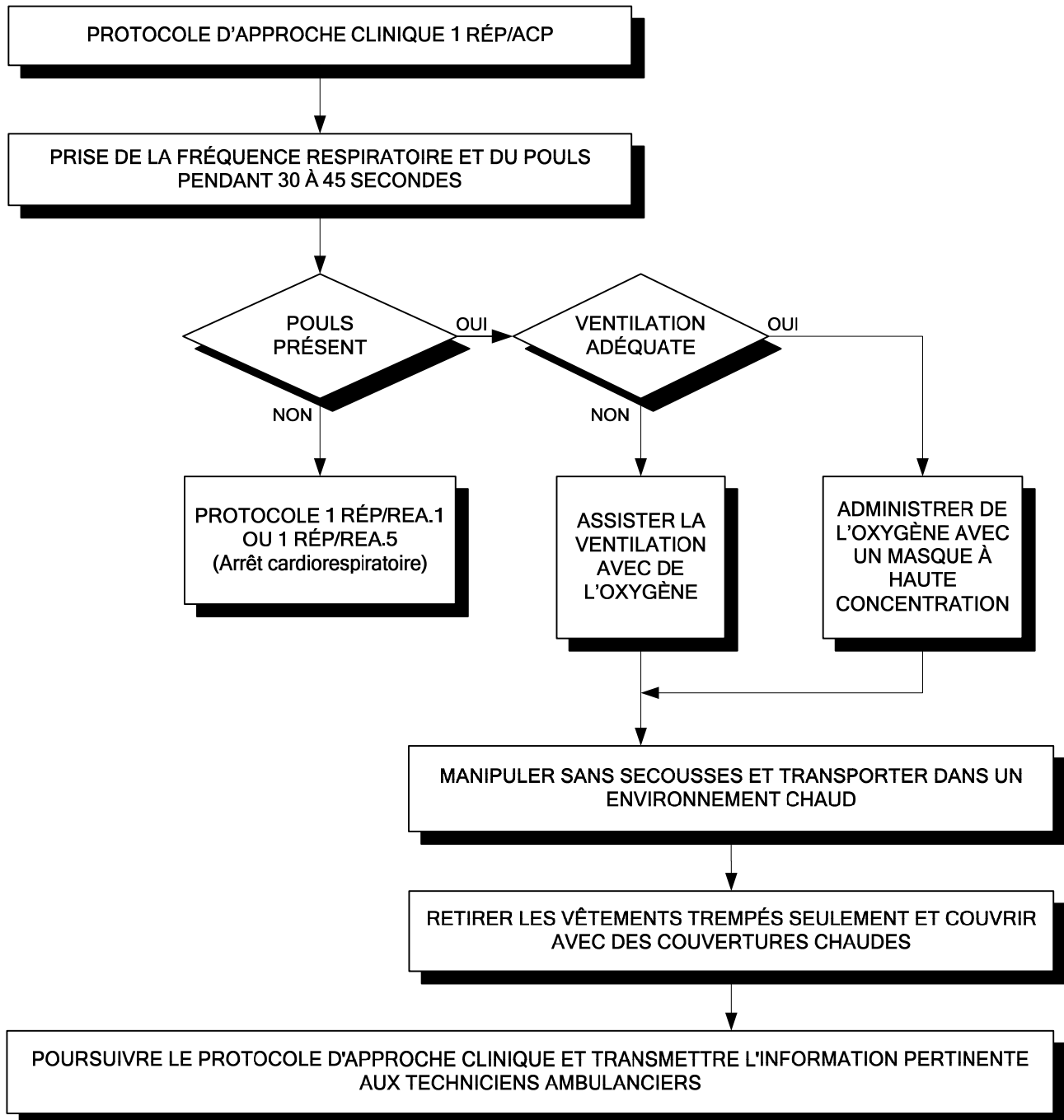
Engelure

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Vérifier si hypothermie :
 - Présence d'hypothermie
 - Se référer au protocole 1 RÉP/ENV.6 (Hypothermie), après avoir complété ce protocole revenir au protocole 1 RÉP/ENV.5.
 - Absence d'hypothermie
 - Passer à l'étape suivante.
3. Retirer les vêtements trempés.
4. Ne pas frotter ni frictionner la partie affectée. Tenter de la protéger.
5. Empêcher le refroidissement de la victime.
6. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarque

- L'engelure est par définition une lésion due au froid, elle est donc généralement localisée à l'endroit qui a été exposé à un environnement froid ou à une source de froid. Il faut distinguer l'engelure de l'hypothermie. L'engelure peut survenir sans hypothermie et n'affecter qu'une partie du corps.

HYPOTHERMIE 1 RÉP/ENV.6



1 RÉP/ENV.6

Hypothermie

Critère d'inclusion :

Ce protocole doit être appliqué seulement dans des situations où la victime est retrouvée dans un environnement froid et que son corps est froid.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP). Dans les cas d'hypothermie, la fréquence respiratoire et le pouls doivent être pris pendant 30 à 45 secondes afin de s'assurer de leur présence. Si on note la présence d'un pouls, aucun massage cardiaque ne doit être entrepris. Dans le cas contraire, entamer le protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5, cependant on ne devra pas dépasser un maximum de 3 chocs au total.
2. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
3. Manipuler avec soin (sans secousses) et transporter dans un environnement chaud.
4. Retirer les vêtements trempés seulement et couvrir la victime avec des couvertures chaudes.
5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Chez une victime d'hypothermie en arrêt cardiorespiratoire, les manœuvres de réanimation doivent être débutées même si un long délai s'est écoulé depuis l'événement.

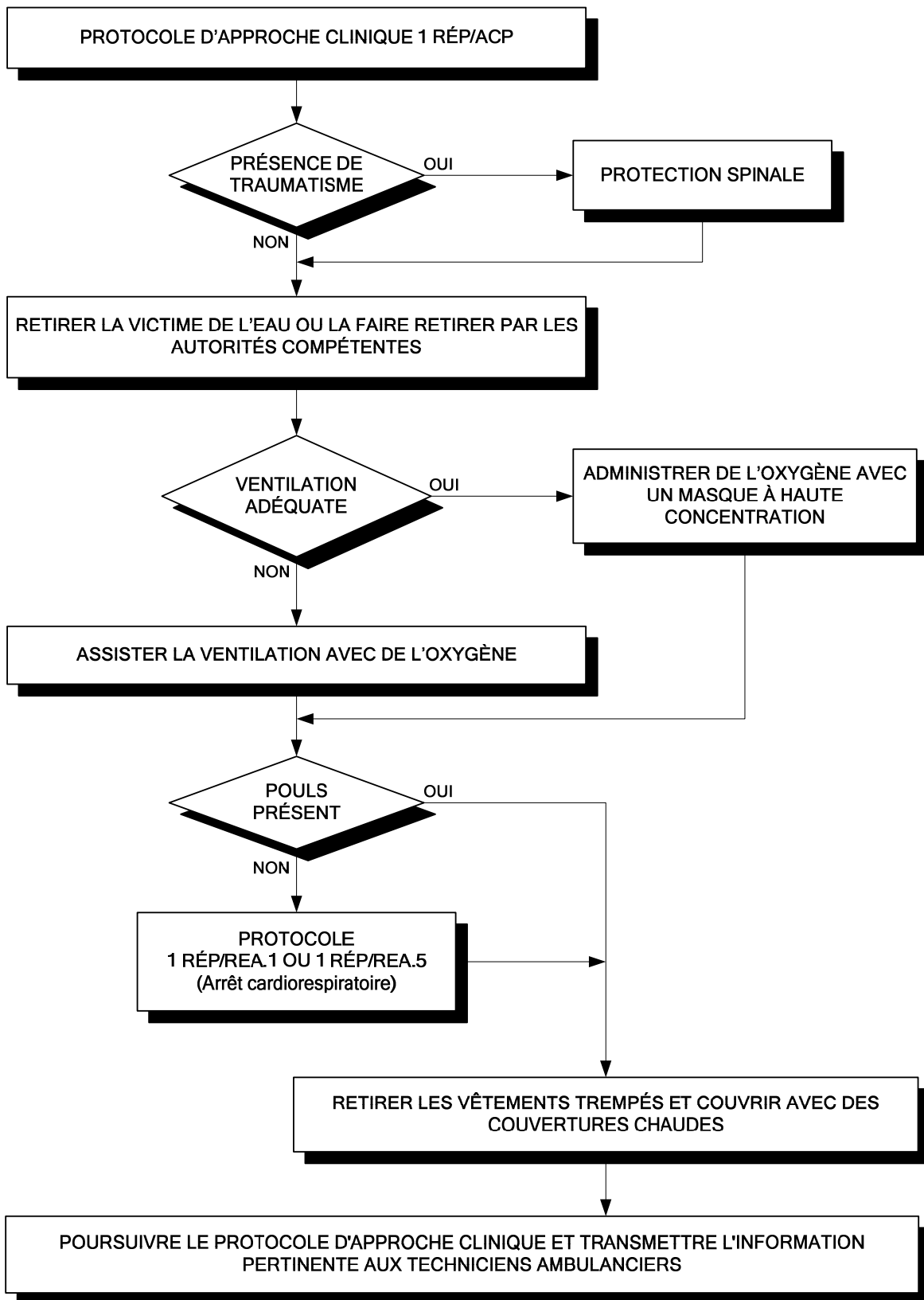
Renseignements requis

- Prise d'alcool ou de médicament.
- Durée de l'exposition au froid.

Remarques

- S'il y a présence d'engelures se référer au protocole 1 RÉP/ENV.5.
- La victime doit être évacuée avec un minimum de secousses à cause du danger d'apparition d'arythmie cardiaque sévère.
- L'hypothermie est une situation particulière en préhospitalier, elle implique des changements au niveau des normes habituelles connues. Toute victime exposée à un environnement froid ou présentant des signes de refroidissement devrait être considérée hypothermique, particulièrement s'il s'agit d'un jeune enfant ou d'une personne âgée. Une atteinte du niveau de l'état de conscience peut être le seul signe laissant présager d'une hypothermie. Considérer le danger d'engelure.
- Dans les cas d'hypothermie, on ne peut pas se fier au retour capillaire.

SUBMERSION 1 RÉP/ENV.7



Submersion

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Vérifier la présence de traumatisme :
 - Présence de traumatisme
 - Assurer une protection spinale.
 - Absence de traumatisme
 - Passer à l'étape suivante.
3. Retirer la victime de l'eau ou la faire retirer par les autorités compétentes.
4. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
5. Prendre le pouls :
 - Absence de pouls
 - Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1 OU 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire-adulte ou pédiatrie).
 - Présence de pouls
 - Passer à l'étape suivante.
6. Retirer les vêtements trempés seulement et couvrir la victime avec des couvertures chaudes.
7. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Renseignements requis

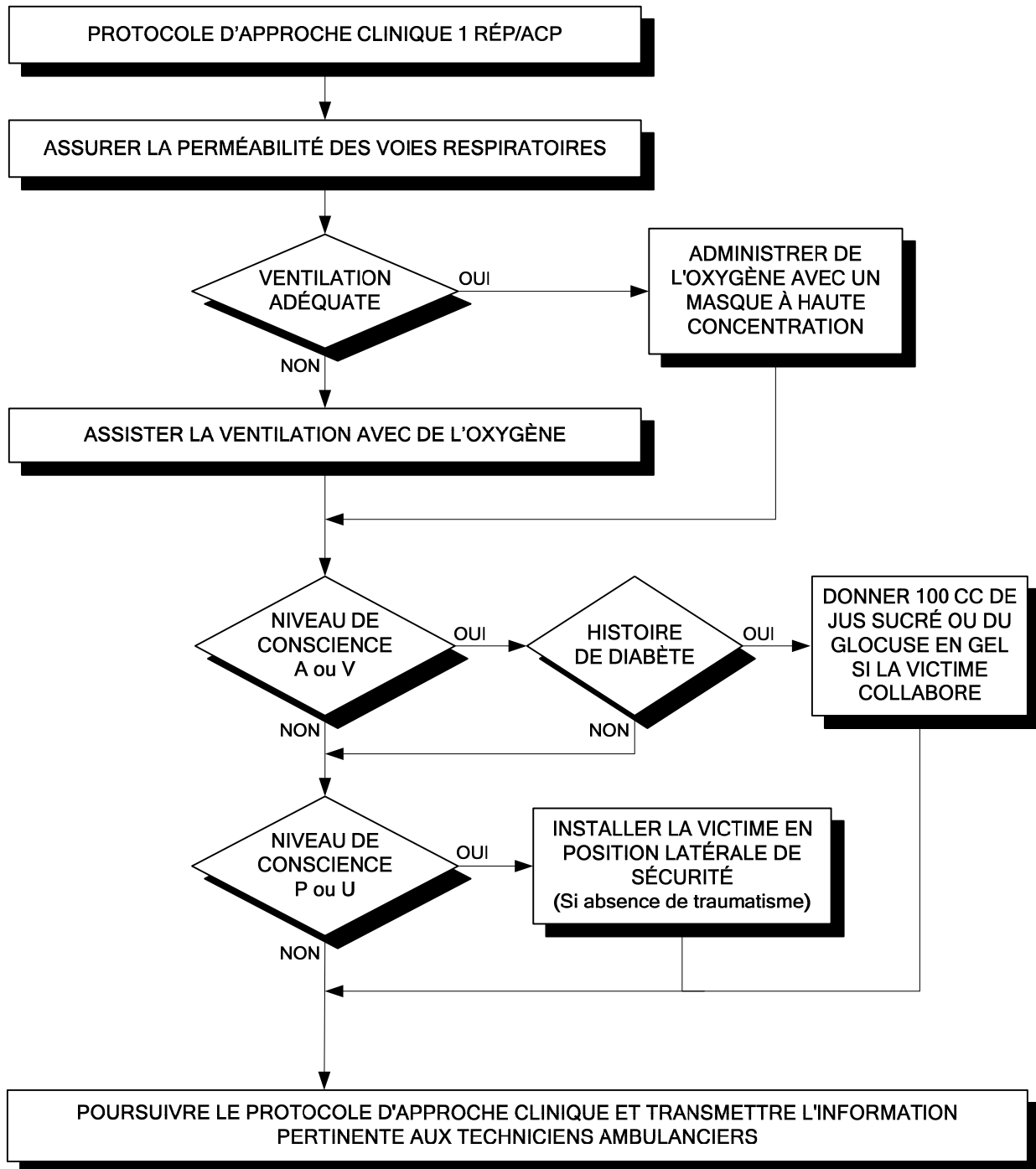
- Durée d'immersion.
- Circonstances de l'événement.

Remarques

- Toujours débiter les manœuvres de RCR dans les cas de noyade lorsque la victime est en ACR, il y a possibilité de survie malgré une longue durée de submersion.
- Si hypothermie, se référer au protocole hypothermie 1 RÉP/ENV.6.

PROBLÈMES MÉDICAUX

ATTEINTE DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE 1 RÉP/MED.2



1 RÉP/MED.2

Atteinte de l'état de conscience

Critères d'inclusion :

Victime avec niveau de conscience « V, P ou U ».
Confusion.
Faiblesse.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Maintenir l'ouverture des voies respiratoires.
3. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
4. Niveau de conscience et histoire de diabète :
 - Niveau de conscience « A ou V » et histoire de diabète
 - Donner 100 cc de jus sucré ou du glucose en gel si la victime collabore.
 - Niveau de conscience « P ou U », ou aucune histoire de diabète
 - Installer la victime en position latérale de sécurité (Si absence de traumatisme);
 - Assurer une surveillance étroite.
5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

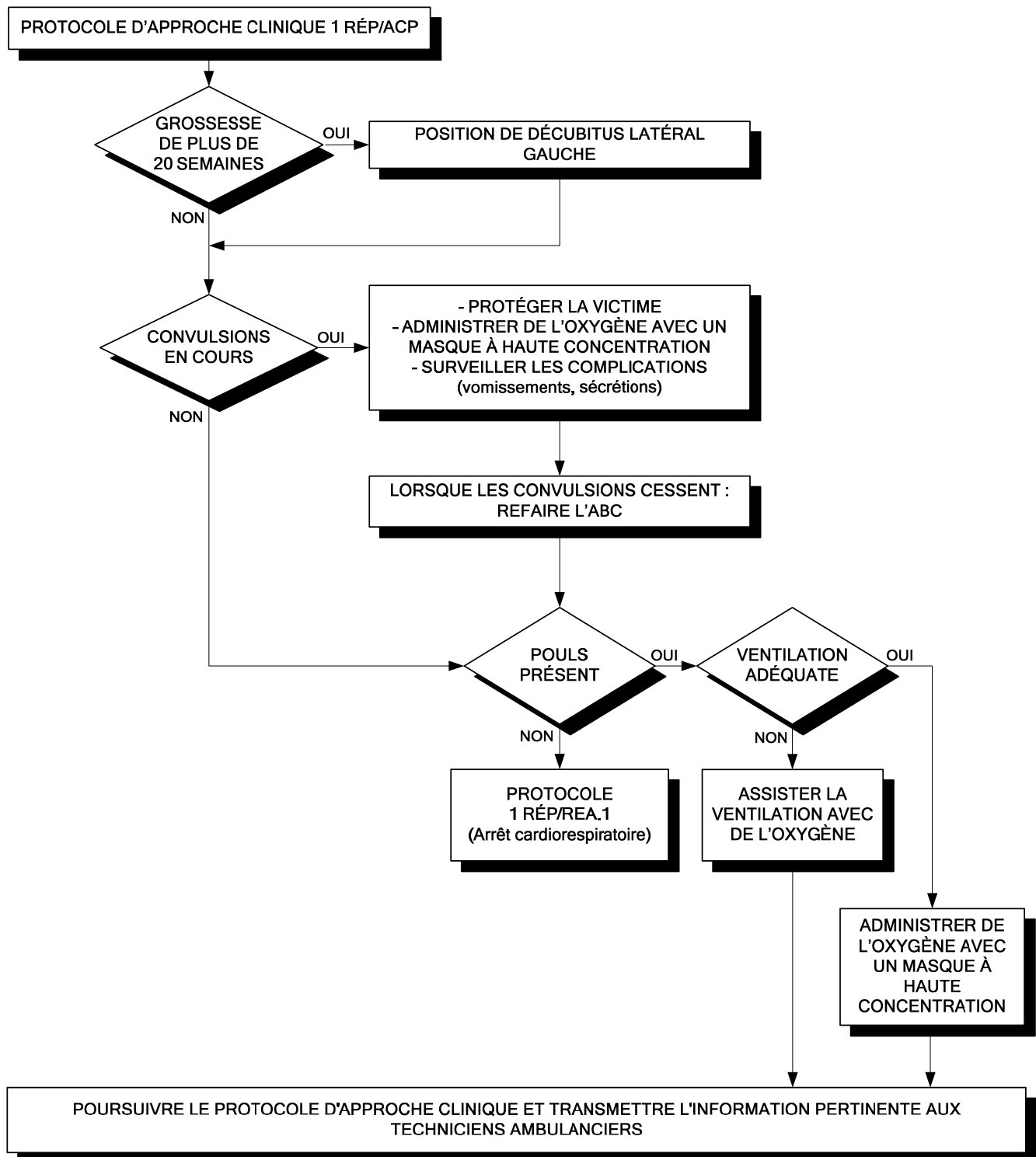
Renseignements requis

- Circonstances de l'événement.
- Antécédents médicaux.

Remarques

- Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, vomissements et aspiration.
- S'assurer que la succion est prête à être utilisée.

CONVULSIONS 1 RÉP/MED.7



1 RÉP/MED.7

Convulsions

Critère d'inclusion :

Atteinte de l'état de conscience associée à des mouvements spasmodiques.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Si grossesse de plus de 20 semaines, installer la patiente en décubitus latéral gauche.
3. Convulsions en cours :
 - Protéger la victime pour éviter qu'elle ne se blesse;
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration;
 - Surveiller les complications (vomissements, sécrétions).

Lorsque les convulsions cessent

 - Refaire L'ABC et passer à l'étape suivante;
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
4. Confirmer la présence de pouls :

Absence de pouls

 - Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire médical-adulte).

Présence de pouls

 - Passer à l'étape suivante.
5. Évaluer la ventilation :

Ventilation inadéquate

 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.

Ventilation adéquate

 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
6. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

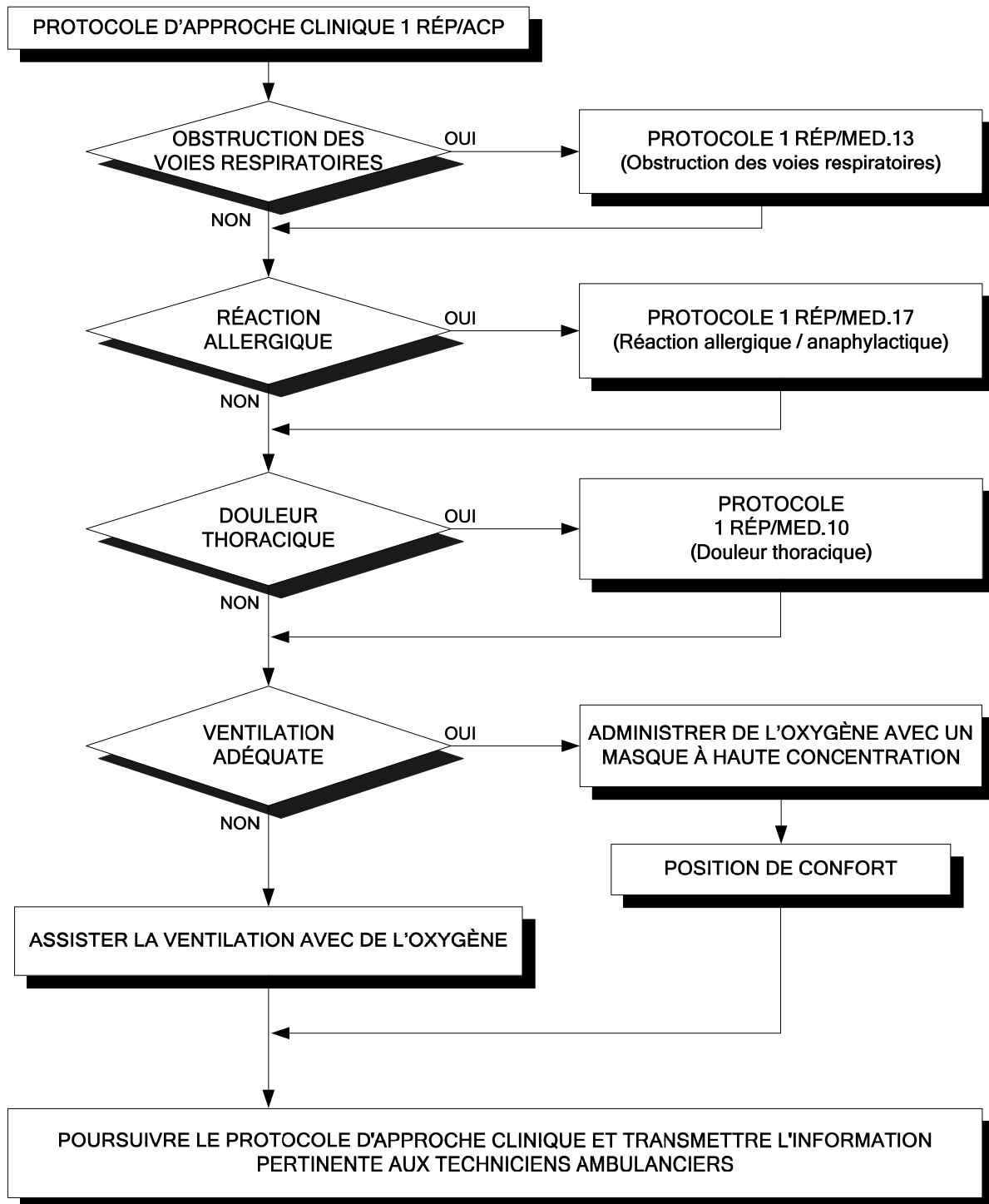
Renseignement requis

- Circonstances de l'événement.

Remarques

- La convulsion peut être la première manifestation d'un ACR, si une convulsion survient pendant une intervention, il faut absolument s'assurer que le pouls est présent. S'il est absent, débiter immédiatement le protocole 1 RÉP/REA.1 ou 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire médical-adulte ou pédiatrie).
- L'installation d'une canule oropharyngée ou nasopharyngée doit se faire de façon non traumatique.
- Après les convulsions, reprendre le protocole d'approche clinique.
- Surveiller les complications : vomissements, aspiration et ACR.

DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE 1 RÉP/MED.8



Difficulté respiratoire

Critère d'inclusion :

Victime avec difficulté respiratoire avouée ou apparente
ou
Avec une fréquence respiratoire à moins de 10 par minute ou plus de 24 par minute
ou
Présentant des bruits respiratoires audibles.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Vérifier si présence d'obstruction des voies respiratoires :
 - Présence d'obstruction des voies respiratoires
 - Le protocole 1 RÉP/MED.13 (Obstruction des voies respiratoires) doit avoir priorité.
 - Absence d'obstruction des voies respiratoires
 - Passer à l'étape suivante.
3. Vérifier si réaction allergique :
 - Présence de réaction allergique
 - Le protocole 1 RÉP/MED.17 (Réaction allergique) doit avoir priorité.
 - Absence de réaction allergique
 - Passer à l'étape suivante.
4. Vérifier si présence de douleur thoracique :
 - Présence de douleur thoracique
 - Le protocole 1 RÉP/MED.10 (Douleur thoracique) doit avoir priorité.
 - Absence de douleur thoracique
 - Passer à l'étape suivante.
5. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
6. Installer la victime en position de confort.

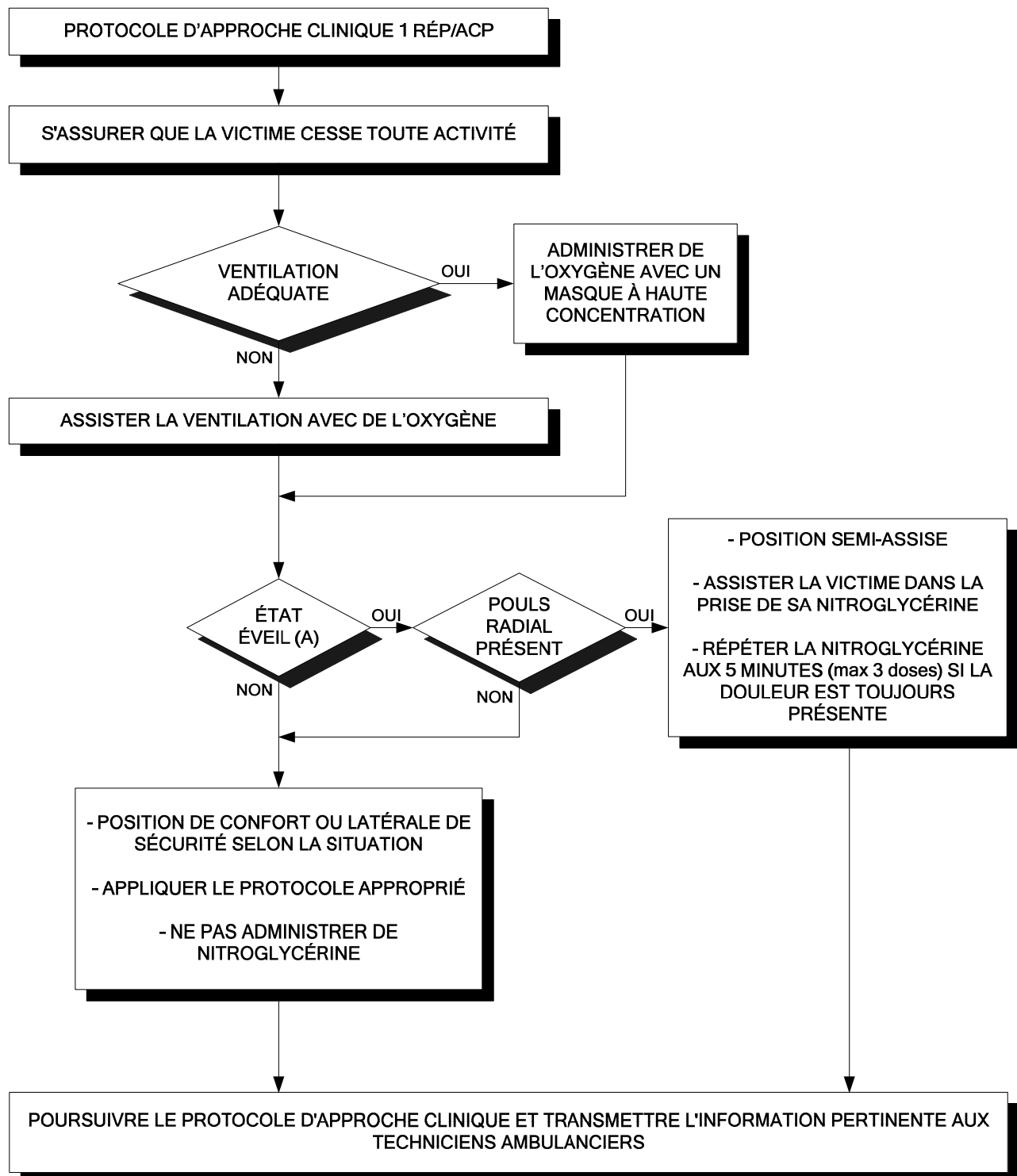
7. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Toujours s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une obstruction des voies respiratoires.

Remarque

- Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, atteinte de l'état de conscience, douleur thoracique, vomissements et aspiration.

DOULEUR THORACIQUE 1 RÉP/MED.10



Douleur thoracique

Critère d'inclusion :

Douleur ou malaise dans la région entre l'ombilic et la mâchoire incluant le dos et les bras.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).

2. S'assurer que la victime cesse toute activité.

3. Évaluer la ventilation :

Ventilation inadéquate

- Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.

Ventilation adéquate

- Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.

4. État d'éveil Alerte (A) et pouls radial présent :

Victime consciente et orientée avec pouls radial présent

- Installer la victime en position semi-assise;
- Assister la victime dans la prise de **sa nitroglycérine** si les critères d'exclusion sont absents;
- Répéter sa prise de nitroglycérine aux 5 minutes (maximum de 3) si la douleur est toujours présente et que les critères d'exclusion sont absents.

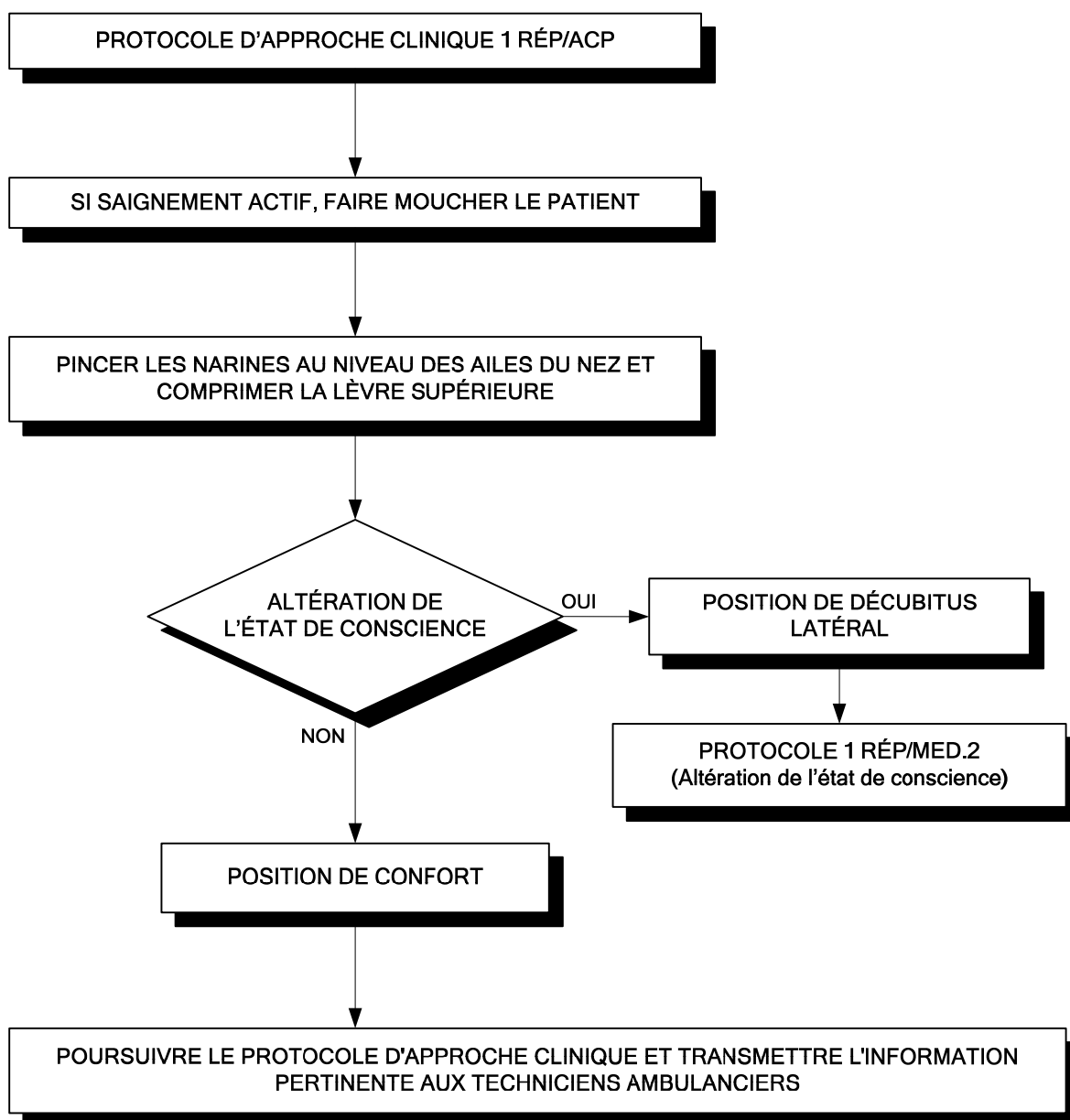
État de conscience V, P, U ou pouls radial absent

- Installer la victime en position de confort ou décubitus latéral selon la situation;
- Appliquer le protocole approprié;
- Ne pas administrer de nitroglycérine.

5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Critères d'exclusion

- État de conscience V, P ou U.
- Absence de pouls radial.
- Prise de Sinédafile (Viagra) ou Vardenafil (Levitra) dans les dernières 24 heures ou Tadalafil (Cialis) dans les 48 dernières heures.
- Bradycardie < 50 ou tachycardie > 150.

EPISTAXIS 1 RÉP/MED.11

1 RÉP/MED.11**Epistaxis**

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Si saignement actif, faire moucher le patient.
3. Pincer les narines au niveau des ailes du nez et comprimer l'espace supérieur entre la lèvre supérieure et le nez.
4. Si altération de l'état de conscience :
 - Position de décubitus latéral;
 - Référez vous au protocole 1 RÉP/MED.2 (Altération de l'état de conscience)
5. Position de confort.
6. Surveillance continue et réévaluation des signes vitaux.
7. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

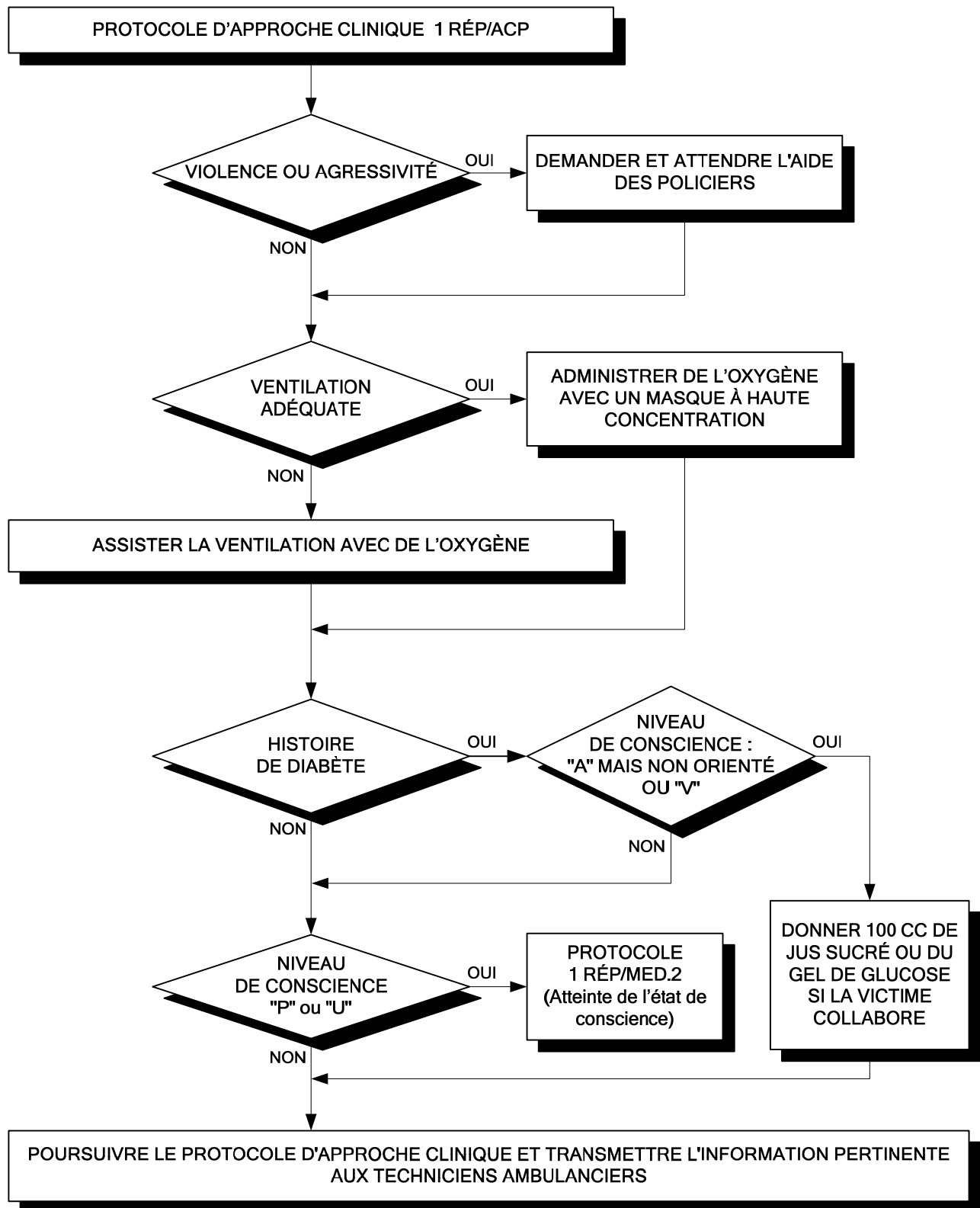
Renseignement requis

- Prise de médicaments affectant la coagulation.

Remarque

- La quantité de sang écoulé du nez peut être une sous-estimation de la quantité réelle de sang perdu.

INTOXICATION 1 RÉP/MED.12



Intoxication

Critère d'inclusion :

Histoire d'intoxication avec médicaments, alcool ou drogue.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Vérifier si violence ou agressivité :
 - Présence de violence ou d'agressivité
 - Demander et attendre l'aide des policiers.
 - Absence de violence ou d'agressivité
 - Passer à l'étape suivante.
3. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
4. Niveau de conscience, orientation et histoire de diabète
 - Niveau de conscience « A (mais non orienté) ou V » ET histoire de diabète
 - Donner à la victime 100 cc de jus sucré ou du gel de glucose, si la victime collabore;
 - Passer à l'étape 5.
 - Niveau de conscience « A » SANS histoire de diabète
 - Passer à l'étape 5.
 - Niveau de conscience « V, P ou U »
 - Appliquer le protocole 1 RÉP/MED.2 (Atteinte de l'état de conscience).
5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

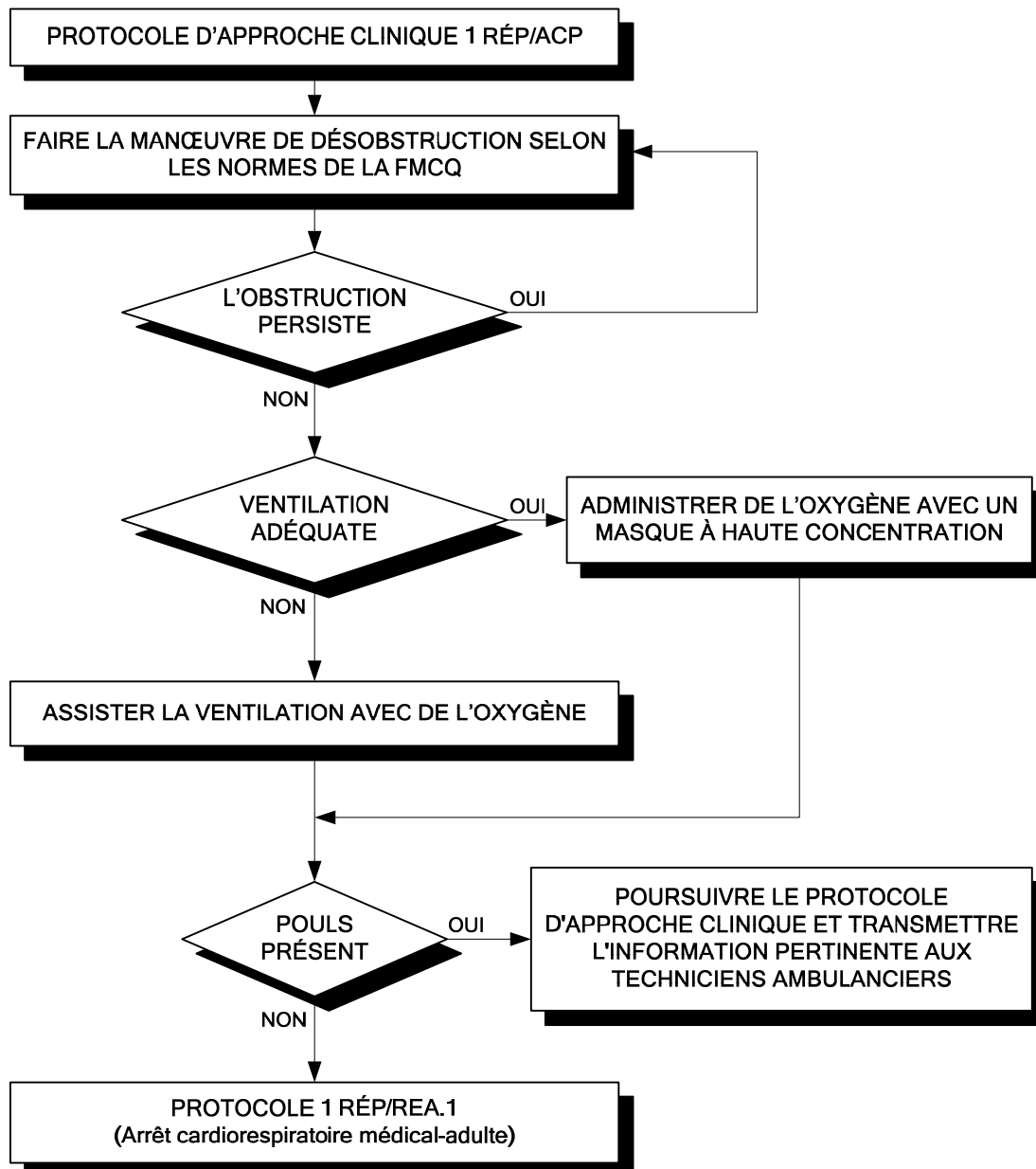
Renseignements requis

- Remettre tous les médicaments, bouteilles de médicaments ou produits aux techniciens ambulanciers.
- Obtenir l'histoire des témoins présents.

Remarque

- Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, vomissements, aspiration et convulsions.

OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES
(≥ 8 ans ou ≥ 25 Kg) 1 RÉP/MED.13



Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (victime de 8 ans et plus ou 25 Kg et plus)

Critère d'inclusion :

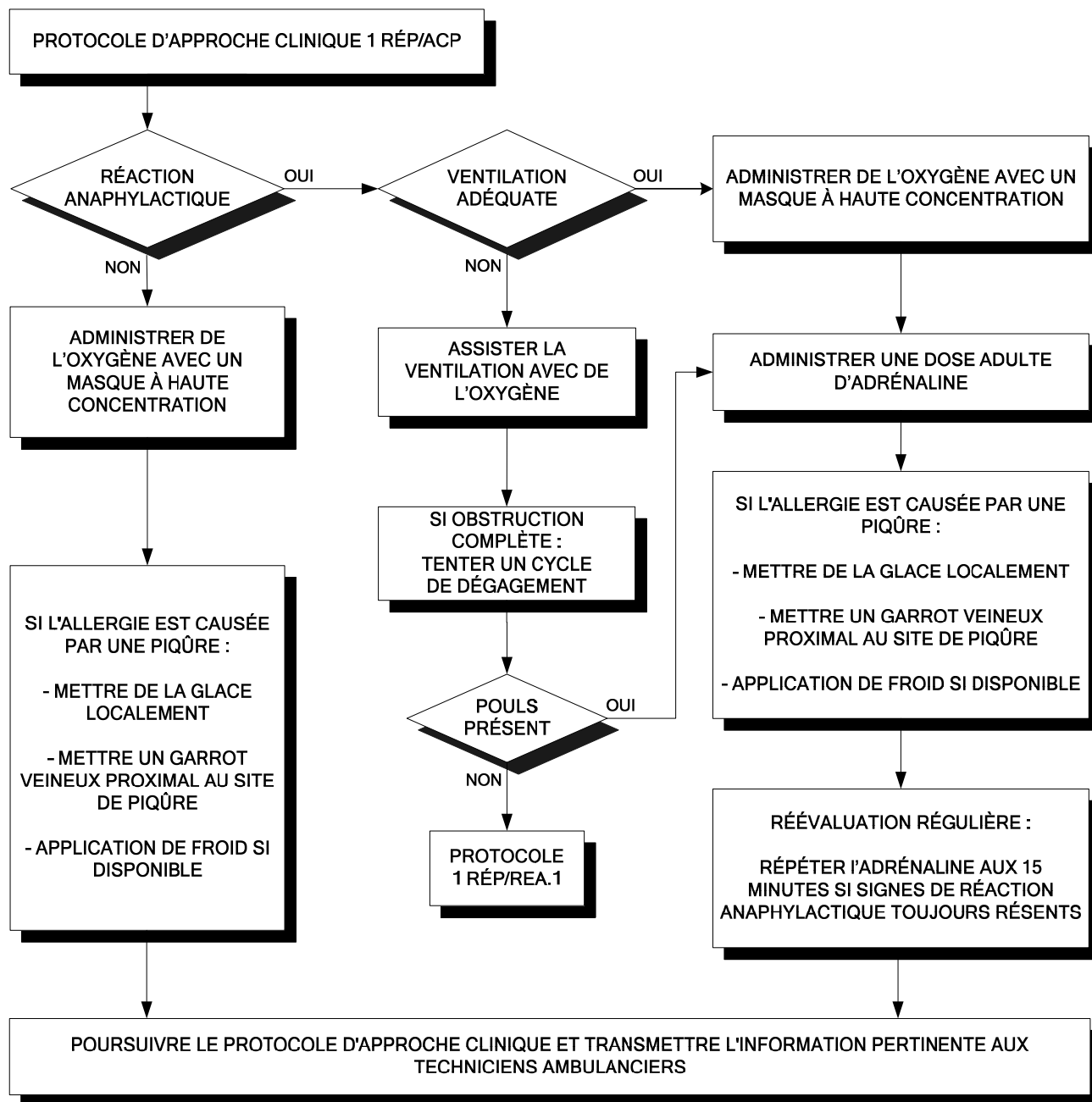
Obstruction respiratoire probable par un corps étranger.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Procéder aux manœuvres de désobstruction des voies respiratoires selon les normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ).
 - a) L'obstruction des voies respiratoires persiste :
 - Reprendre l'étape 2;
 - L'obstruction des voies respiratoires est levée : passer à l'étape suivante.
 - b) Respiration spontanée :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
 - c) Pouls :
 - Absence de pouls
 - Débuter la réanimation cardiorespiratoire selon les normes de la FMCQ et du protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire médical-adulte).
 - Présence de pouls
 - Passer à l'étape suivante.
3. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarques

- Se référer aux normes RCR-FMCQ pour les étapes de chacune des situations décrites ci-haut.
- Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, arrêt respiratoire, obstruction complète, vomissements et aspiration.

RÉACTION ALLERGIQUE/ANAPHYLACTIQUE 1 RÉP/MED.17



Réaction allergique/Anaphylactique

Critères d'inclusion:

Histoire récente confirmée ou suspectée d'exposition à un allergène.
Absence de corps étranger (voies respiratoires).
Poids de la victime : 25 kg ou plus.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).

2. Évaluer la sévérité de la réaction allergique :

– **Réaction anaphylactique** : Réaction allergique avec signes de défaillance respiratoire et/ou circulatoire :

Signes de **défaillance respiratoire** tels que :

- ⇒ Dyspnée bruyante;
- ⇒ Dyspnée avec tirage intercostal;
- ⇒ Dyspnée avec peau cyanosée;
- ⇒ Dyspnée avec atteinte de l'état de conscience « V, P ou U ».

ET/OU

Signes de **défaillance circulatoire** tels que :

- ⇒ Tachypnée;
- ⇒ Peau pâle froide et moite;
- ⇒ Tachycardie;
- ⇒ Hypotension artérielle;
- ⇒ Atteinte de l'état de conscience (signe tardif).

ET/OU

Oedème de la langue **objectif** par le premier répondant.

– **Réaction allergique non anaphylactique** : réaction allergique sans problème respiratoire ou circulatoire.

3. Si présence d'une réaction anaphylactique :

a) Mettre le DEA sous tension (voir remarques).

b) Évaluer la ventilation :

Ventilation inadéquate

- Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration;
- Si obstruction complète des voies respiratoires : tenter un cycle de dégagement des voies respiratoires;
- Si arrêt cardiorespiratoire, appliquer le protocole 1 RÉP/REA.1 (Arrêt cardiorespiratoire médical-adulte).

Ventilation adéquate

- Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.

c) Administrer l'adrénaline :

- Administrer une dose adulte (0.3 mg) d'adrénaline à l'aide d'un dispositif auto-injecteur dans le deltoïde (épaule) ou dans la cuisse.

d) Réévaluer régulièrement

- Répéter l'administration d'adrénaline à l'aide d'un dispositif auto-injecteur aux 15 minutes si l'état de la victime s'aggrave, ne s'améliore pas ou si elle présente encore les signes d'une réaction allergique sévère.

4. Si présence d'une réaction non anaphylactique :

a) Administrer de l'oxygène à haute concentration.

b) Afin de limiter la réaction allergique, si l'allergène semble être une piqûre (insecte) ou tout autre type d'injection transcutanée :

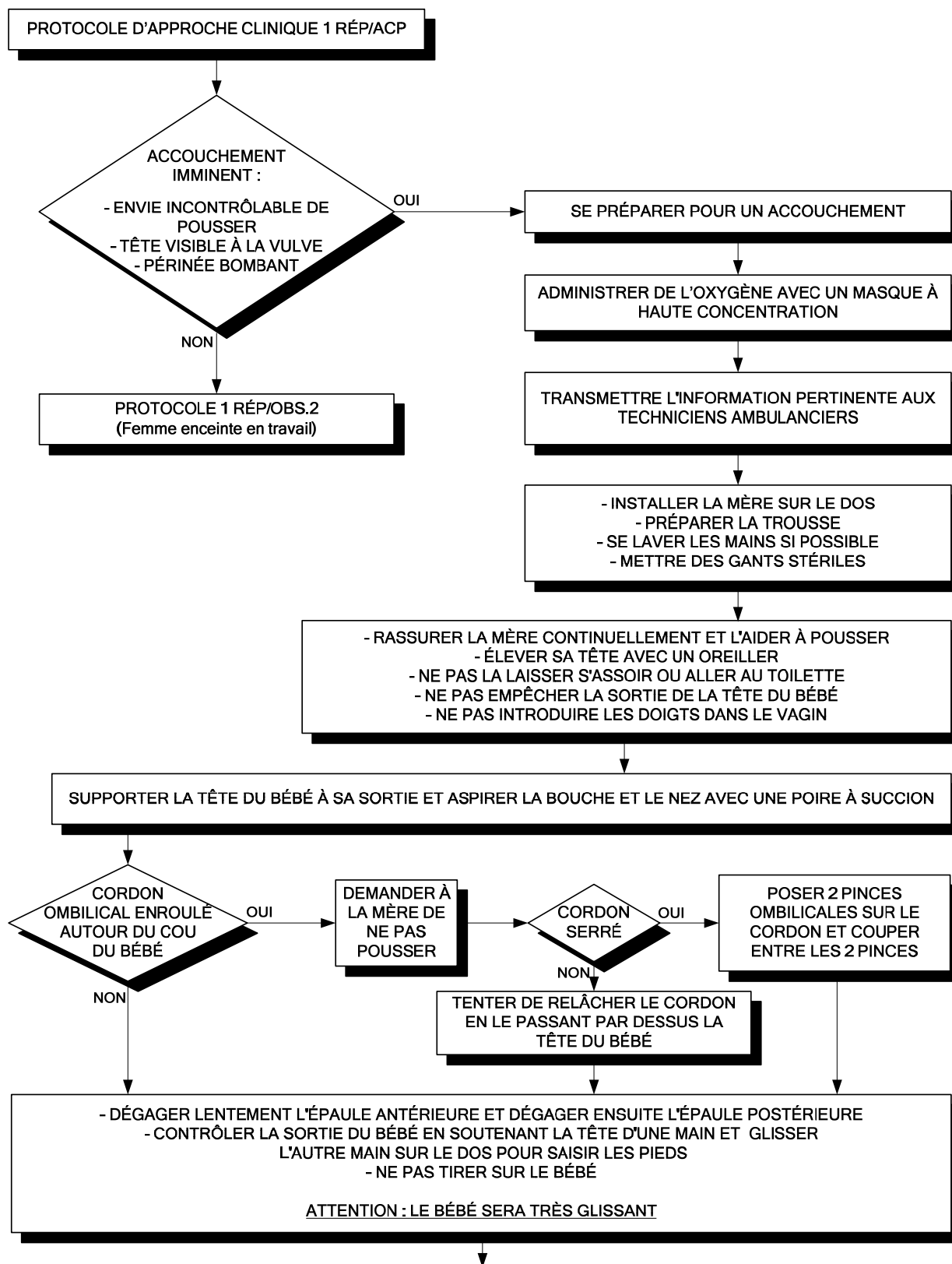
- Appliquer de la glace localement;
- Mettre un garrot veineux proximale au site d'injection ou de piqûre;
- Si le dard est visible facilement, l'extraire sans le pincer.

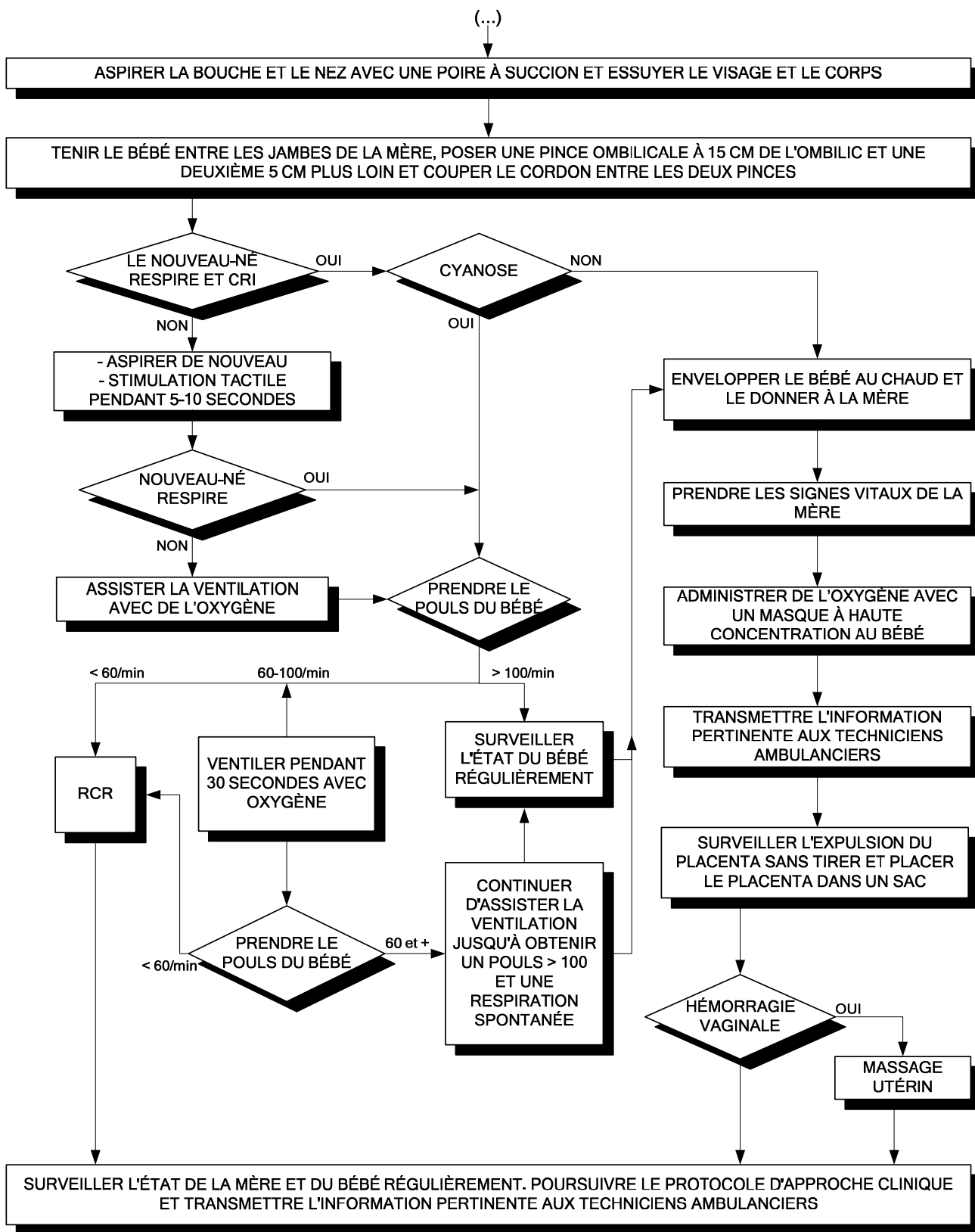
5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.
Remarques

- Le garrot veineux ne doit pas être trop serré afin de ne pas empêcher la circulation artérielle, s'assurer de la persistance du pouls distal au garrot.
- DEA : si les électrodes de défibrillation ne sont pas apposées sur la victime, certains modèles d'appareils DEA nécessitent l'installation d'une « résistance vocale » afin de permettre l'enregistrement de la voix et par la suite, la transmission par modem.

PROBLÈMES OBSTÉTRICAUX

ACCOUCHEMENT D'URGENCE 1 RÉP/OBS.1





1 RÉP/OBS.1

Accouchement d'urgence

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Vérifier si l'accouchement est imminent (envie incontrôlable de pousser, tête visible à la vulve ou périnée bombant) :
 - Présence d'envie de pousser incontrôlable, tête visible ou périnée bombant
 - Se préparer pour un accouchement.
 - Absence d'envie incontrôlable de pousser, tête visible ou périnée bombant
 - Appliquer le protocole 1 RÉP/OBS.2 (Femme enceinte en travail).
3. Administrer de l'oxygène à haute concentration à la mère.
4. Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.
5. Installer la mère sur le dos, préparer la trousse, se laver les mains si possible et mettre des gants stériles. Si la situation le permet, s'assurer d'une certaine stérilité lors de l'accouchement afin d'éviter une infection post-accouchement.
6. Rassurer la mère continuellement et l'aider à pousser, élever sa tête avec un oreiller, mais ne pas la laisser s'asseoir ni aller à la toilette. Ne pas empêcher la sortie de la tête du bébé, ne pas introduire les doigts dans le vagin.
7. Supporter la tête du bébé à sa sortie et aspirer la bouche et le nez avec une poire à succion.
8. Vérifier si enroulement du cordon autour du cou du bébé :
 - Présence d'un enroulement du cordon autour du cou du bébé
 - Demander à la mère de ne pas pousser;
 - Tenter de le relâcher en le passant par-dessus la tête du bébé;
 - Si le cordon est trop serré, poser deux (2) pinces ombilicales sur le cordon et couper entre les deux pinces.
 - Absence d'un enroulement du cordon autour du cou du bébé
 - Passer à l'étape 9.
9. Dégager lentement l'épaule antérieure et, par la suite, l'épaule postérieure. Contrôler la sortie du bébé en soutenant la tête et glisser la main libre sur le dos pour saisir les pieds. Ne jamais tirer sur le bébé (ATTENTION : le bébé sera très glissant).
10. À la sortie du bébé, aspirer la bouche et le nez avec une poire à succion et essuyer le visage et le corps.
11. Tenir le nouveau-né entre les jambes de la mère, poser une pince ombilicale à 15 cm de l'ombilic et une deuxième pince approximativement 5 cm plus loin (vers la mère). Couper le cordon entre les deux pinces.

12. Évaluer la respiration et le cri du nouveau-né :
Absence de respiration et de cri

- Aspirer de nouveau la bouche et le nez avec une poire;
- Stimulation tactile pendant 5 à 10 secondes;
- Revérifier la respiration :
 - Si le nouveau-né ne respire pas, assister la ventilation et passer à l'encadré;
 - Si le nouveau-né respire mais ne crie pas, passer à l'encadré.

Présence de respiration et de cri

- Passer à l'étape 13.

Évaluer le pouls :
Pouls à plus de 100/min

- Passer à l'étape 13.

Pouls à moins de 60/min

- Débuter la RCR selon les normes FMCQ;
- Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Pouls entre 60 et 100/min

- Assister la ventilation pour 30 secondes et administrer de l'oxygène;
- Réévaluer le pouls.

Pouls à 60/min et +

- Continuer d'assister la ventilation pour obtenir un pouls à plus de 100 et une respiration spontanée;
- Vérifier le pouls et la respiration régulièrement;
- Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Vérifier le pouls et la respiration régulièrement et passer à l'étape 13 lorsque le pouls et la respiration sont adéquats.

Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

13. Évaluer la cyanose :**Présence de cyanose chez le bébé**

- Passer à l'encadré de l'étape 12.

Absence de cyanose chez le bébé

- Passer à l'étape 14.

14. Essuyer et envelopper le bébé au chaud et le donner à la mère :

- Surveiller l'état du bébé et de la mère régulièrement.

15. Prendre les signes vitaux de la mère.**16. Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration au bébé.****17. Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.****18. Surveiller l'expulsion du placenta sans tirer sur le cordon, placer le placenta dans un sac et le remettre aux techniciens ambulanciers pour qu'il soit apporté au centre hospitalier.****19. Vérifier la présence d'hémorragie vaginale :****Présence d'hémorragie vaginale**

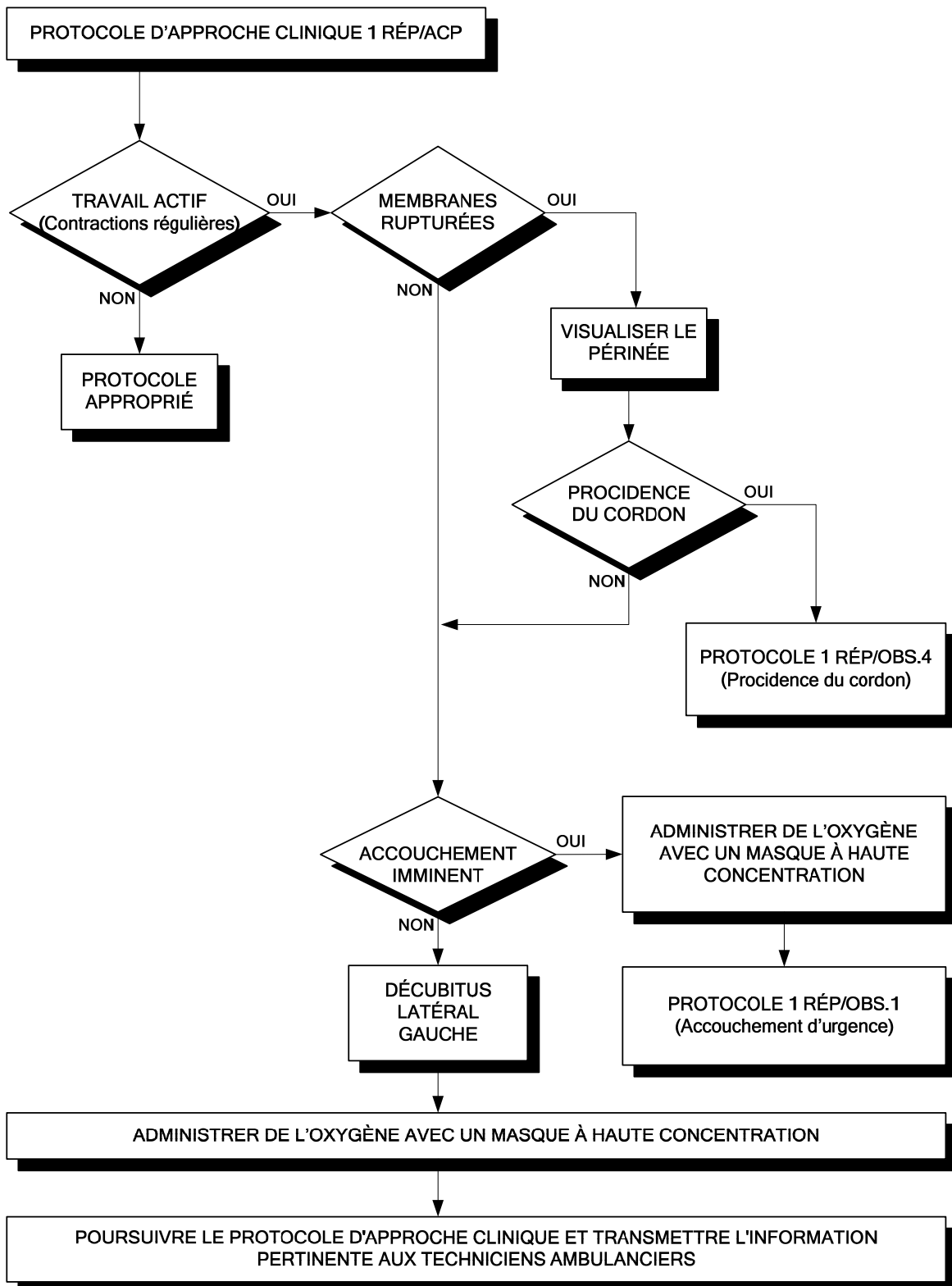
- Massage utérin.

Absence d'hémorragie vaginale

- Passer à l'étape suivante.

20. Surveiller l'état du bébé et de la mère régulièrement. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

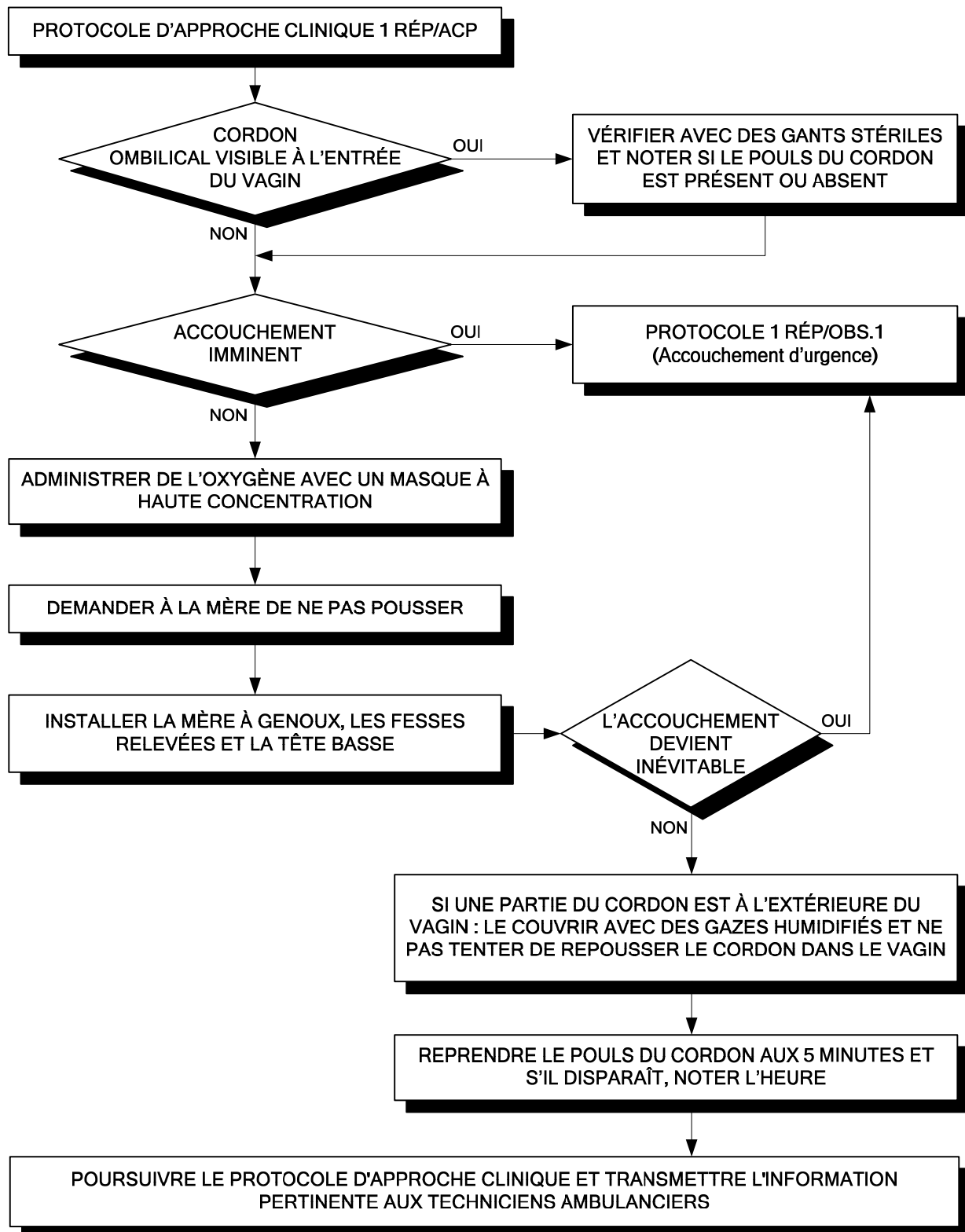
FEMME ENCEINTE EN TRAVAIL 1 RÉP/OBS.2



1 RÉP/OBS.2
Femme enceinte en travail

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Vérifier si le travail est actif (contractions régulières) :
 - Absence de travail actif (les contractions ne sont pas régulières)
 - Se référer au protocole approprié.
 - Présence de travail actif (les contractions sont régulières)
 - Passer à l'étape suivante.
3. Vérifier si les membranes sont rompues (demander à la patiente si elle a ressenti un écoulement de liquide chaud) :
 - Présence de membranes rompues
 - Visualiser le périnée;
 - S'il y a procidence du cordon, se référer au protocole 1 RÉP/OBS.4 (Procidence du cordon) et au support médical si disponible;
 - S'il n'y a pas de procidence du cordon, passer à l'étape 4.
 - Absence de membranes rompues
 - Passer à l'étape suivante.
4. Vérifier si l'accouchement est imminent (si envie incontrôlable de pousser, tête visible à la vulve ou périnée bombant) :
 - Présence de signes d'un accouchement imminent
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration;
 - Se référer au protocole 1 RÉP/OBS.1 (Accouchement d'urgence).
 - Absence de signes d'un accouchement imminent
 - Installer la mère en position de décubitus latéral gauche.
5. Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
6. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

PROCIDENCE DU CORDON 1 RÉP/OBS.4



1 RÉP/OBS.4
Procidence du cordon

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Procéder à un examen visuel de l'entrée du vagin (le cordon ombilical peut être visible ou non) :
 - Cordon ombilical visible à l'entrée du vagin
 - Vérifier avec une main gantée stérile, si le poulx du cordon est présent ou absent;
 - Passer à l'étape 3.
 - Cordon ombilical non visible à l'entrée du vagin
 - Poursuivre le protocole.
3. Vérifier si l'accouchement est imminent (si envie incontrôlable de pousser, tête visible à la vulve ou périnée bombant) :
 - Présence de signes d'un accouchement imminent
 - Favoriser l'accouchement et se référer au protocole 1 RÉP/OBS.1 (Accouchement d'urgence).
 - Absence de signes d'un accouchement imminent
 - Passer à l'étape 4.
4. Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
5. Demander à la mère de ne pas pousser.
6. Installer la mère à genoux, les fesses relevées et la tête basse.
7. Vérifier si l'accouchement devient imminent :
 - Présence de signes d'un accouchement inévitable
 - Favoriser l'accouchement et se référer au protocole 1 RÉP/OBS.1 (Accouchement d'urgence).
 - Absence de signes d'un accouchement inévitable
 - Passer à l'étape 8.
8. Vérifier si une partie du cordon est à l'extérieur du vagin :
 - Couvrir le cordon avec des gazes stériles humidifiées (NaCl 0.9 %) et minimiser ensuite les manipulations du cordon. Ne pas tenter de repousser le cordon dans le vagin.
9. Reprendre le poulx du cordon aux 5 minutes et s'il disparaît, noter l'heure.
10. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

PROBLÈMES PÉDIATRIQUES

Généralités

Les protocoles *Problèmes pédiatriques* s'adressent à tout individu morphologiquement non adulte de 8 ans et moins ou de 25 kg et moins, sauf spécifications contraires dans un protocole donné.

La ventilation en pédiatrie peut s'évaluer en terme de fréquence respiratoire, mais également en fonction d'autres critères dont :

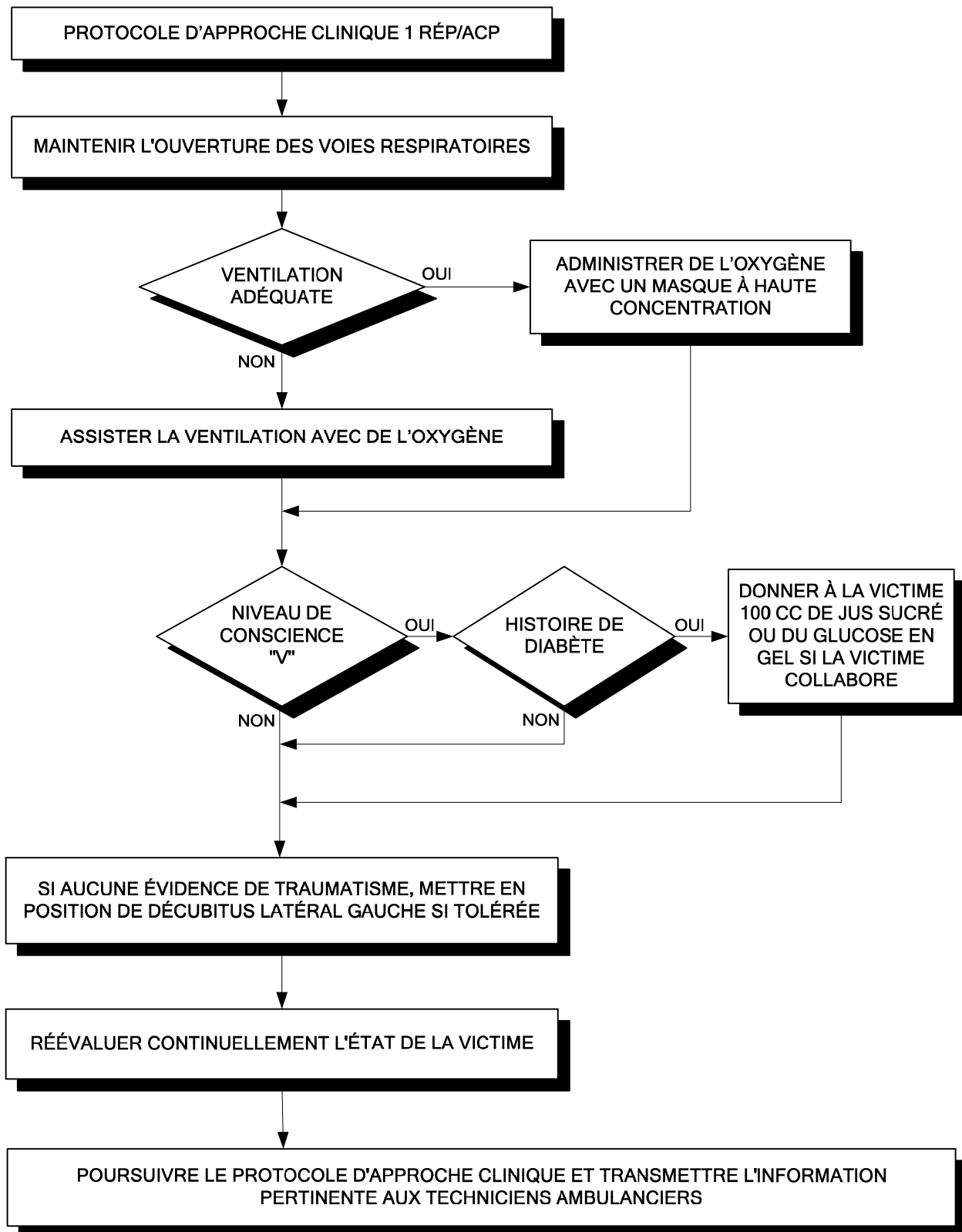
- L'amplitude respiratoire (mouvement du thorax).
- L'état de conscience « A ou V ».
- Le remplissage capillaire (normal si < 2 secondes).
- Présence/absence de cyanose.
- Le soulèvement du thorax lors de l'assistance respiratoire.

L'évaluation de la ventilation en pédiatrie est très importante, les enfants étant beaucoup plus fragiles à l'hypoxie. Des signes tels que : la fatigue, la pâleur, des mouvements de la tête de haut en bas à chaque respiration, la rétraction des muscles du thorax, le battement des ailes du nez doivent être considérés.

De plus, la bradycardie est un signe d'hypoxie sévère chez l'enfant.

La ventilation en pédiatrie devrait se faire avec un masque de type « Seal-easy ».

ATTEINTE DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE 1 RÉP/PED.1



1 RÉP/PED.1

Atteinte de l'état de conscience

Critère d'inclusion :

Victime avec niveau de conscience « V, P ou U ».

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Maintenir l'ouverture des voies respiratoires. Les enfants étant plus fragiles à l'hypoxie, le maintien des voies respiratoires est essentiel.
3. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la respiration et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
4. Niveau de conscience et histoire de diabète
 - Niveau de conscience « V » ET histoire de diabète
 - Donner à la victime 100 cc de jus sucré ou du glucose en gel, si la victime collabore.
 - Niveau de conscience « V » SANS histoire de diabète OU « P ou U »
 - Passer à l'étape suivante.
5. Si aucune évidence de traumatisme, installer la victime en position de décubitus latéral gauche si tolérée.
6. Réévaluer continuellement l'état de la victime.
7. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

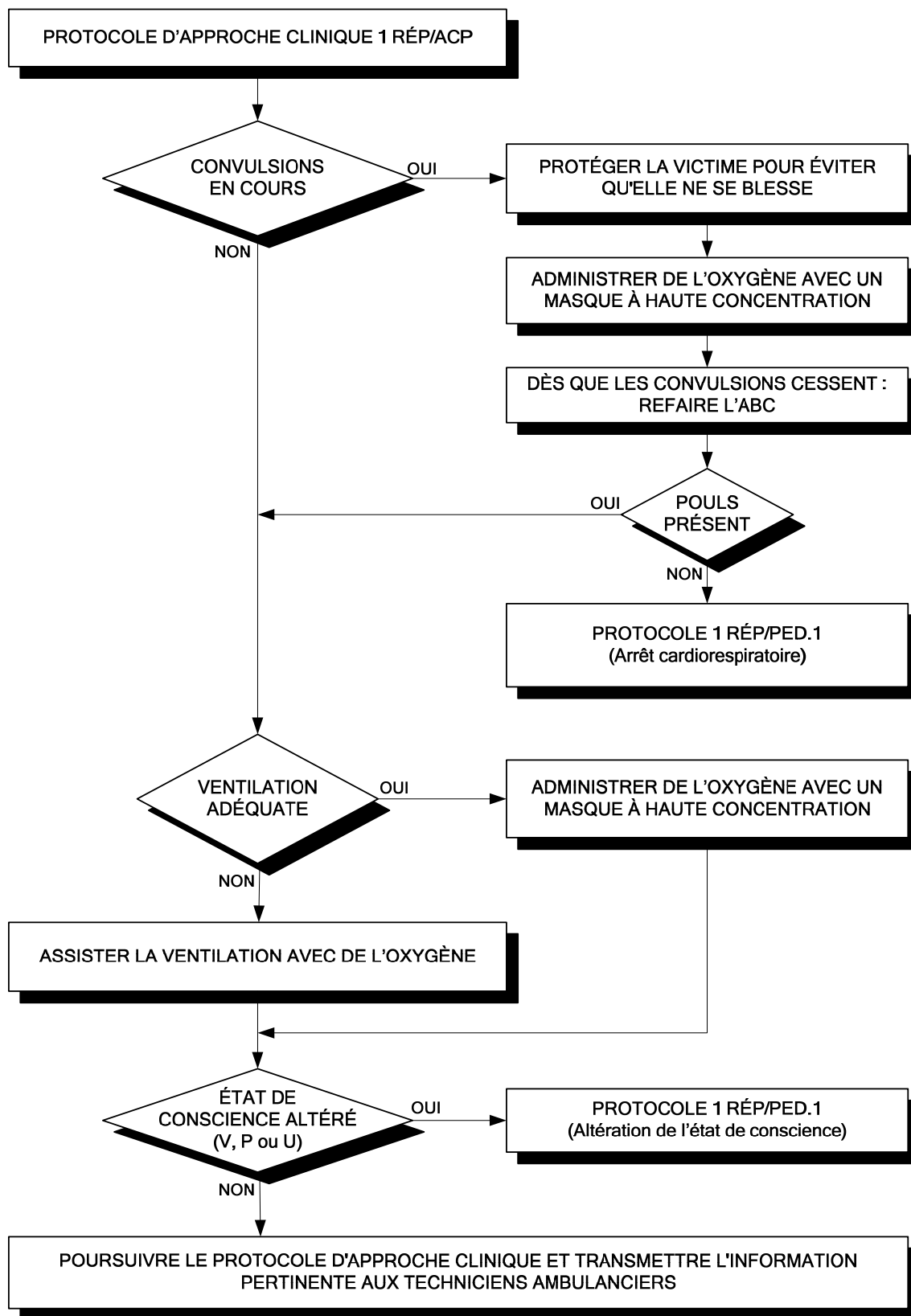
Renseignements requis

- Circonstances de l'événement.
- Antécédents médicaux.

Remarques

- Ne pas faire d'hyperextension du cou chez les enfants en essayant de libérer les voies aériennes. Une hyperextension peut obstruer les voies respiratoires.
- Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, vomissements et aspiration.
- S'assurer que la succion est prête à être utilisée.

CONVULSIONS 1 RÉP/PED.2



1 RÉP/PED.2

Convulsions

Critère d'inclusion :

Perte de conscience associée à des mouvements spasmodiques localisés ou généralisés.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).

2. Vérifier si convulsions en cours :

Présence de convulsions

- Protéger la victime pour éviter qu'elle ne se blesse;
- Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration;
- Dès que les convulsions cessent, refaire L'ABC.

Absence de convulsions

- Passer à l'étape suivante.

3. Évaluer la ventilation :

Ventilation inadéquate

- Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.

Ventilation adéquate

- Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.

4. Évaluer l'état de conscience :

État de conscience altéré, niveau de conscience « V, P ou U »

- Appliquer le protocole 1 RÉP/PED.1 (Atteinte de l'état de conscience).

État de conscience non altéré, niveau de conscience « A »

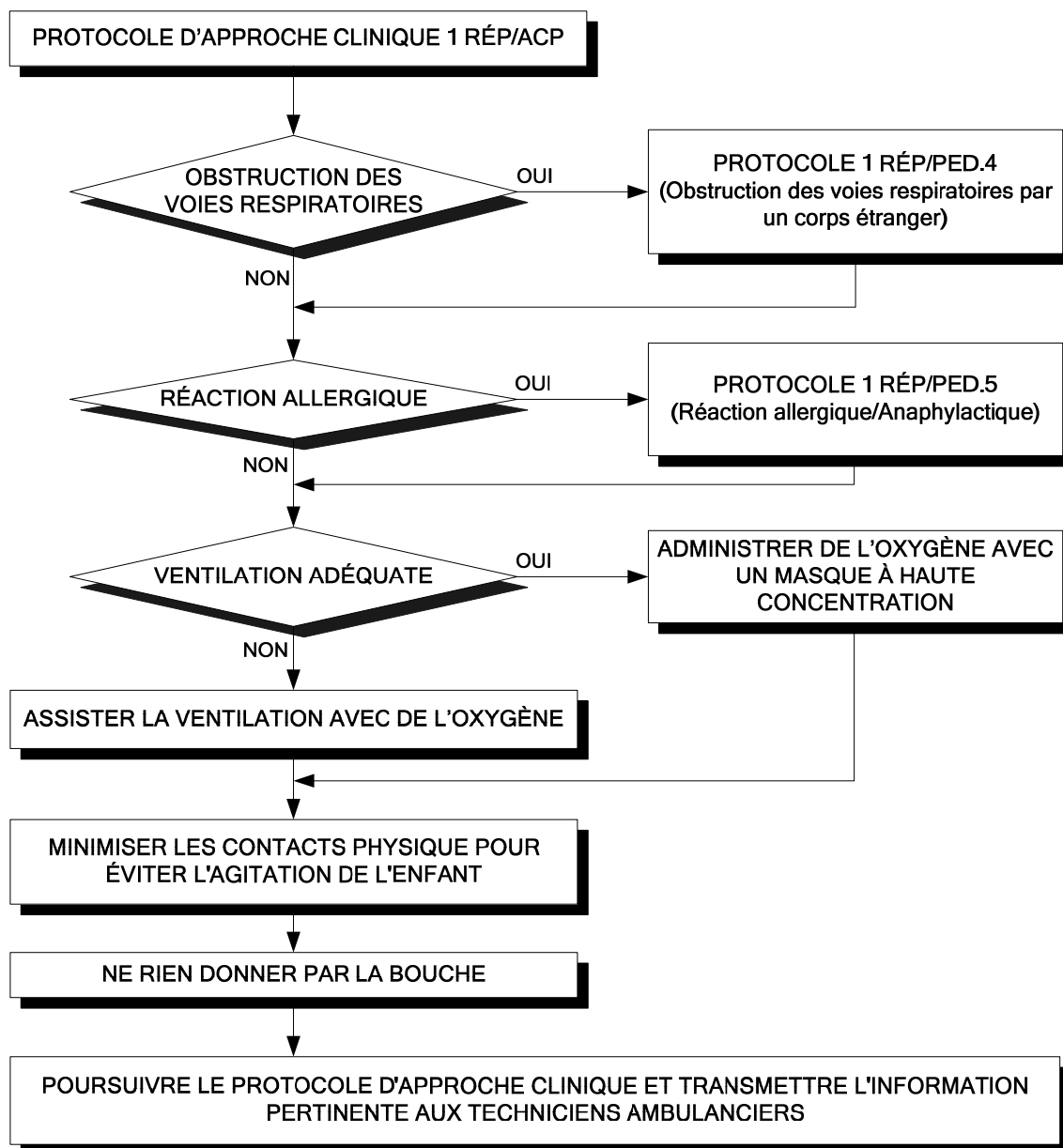
- Passer à l'étape suivante.

5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarques

- Une hyperextension de la tête peut obstruer les voies respiratoires.
- Chez la victime de moins de 5 ans, les convulsions peuvent être provoquées par de la fièvre importante. Il faut donc couvrir la victime le moins possible.
- L'installation d'une canule oropharyngée ou nasopharyngée doit se faire de façon non traumatique.
- Après les convulsions, reprendre le protocole d'approche clinique.

DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE 1 RÉP/PED.3

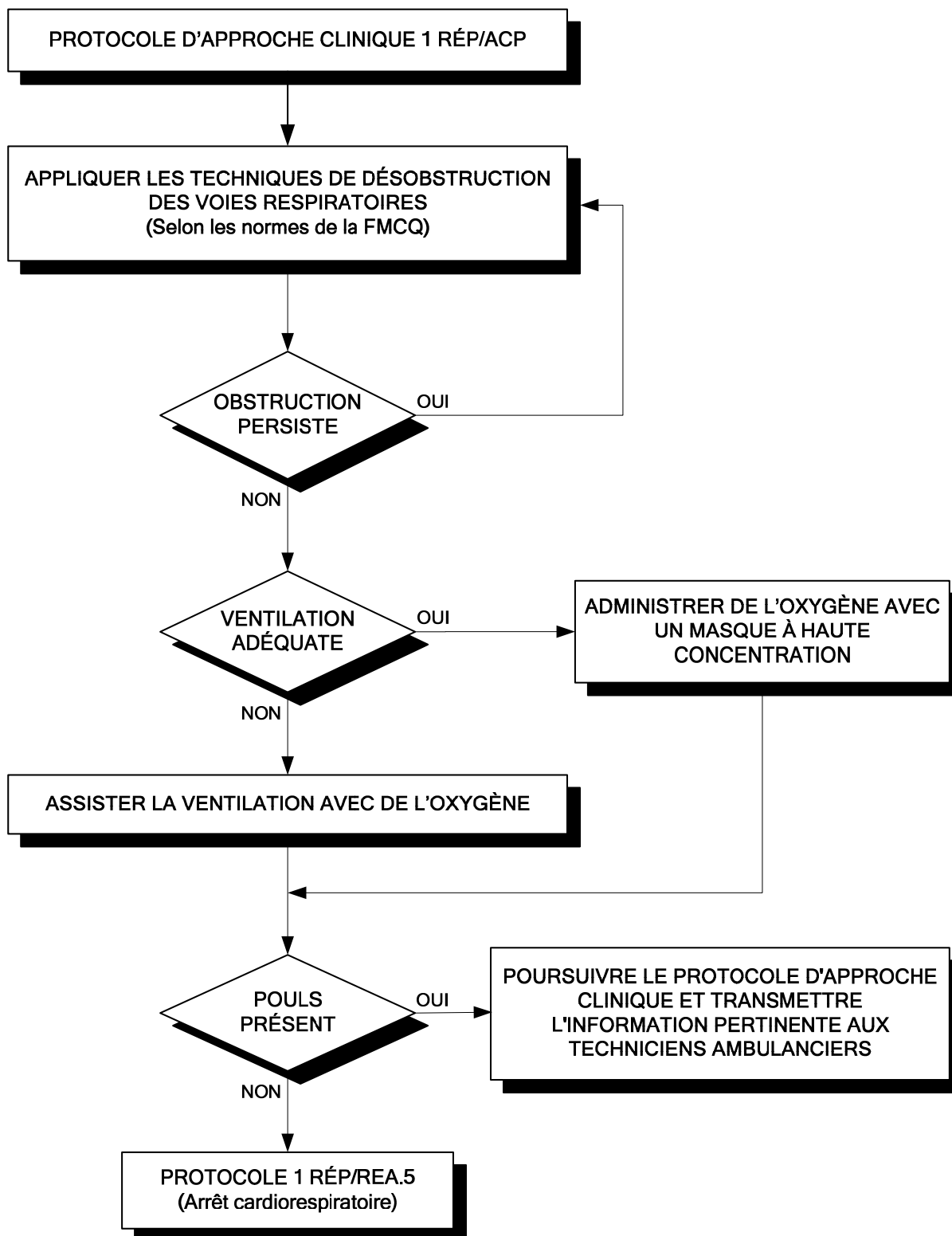


1 RÉP/PED.3
Difficulté respiratoire

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Si obstruction des voies respiratoires, se référer au protocole 1 RÉP/PED.4 (Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger).
3. Si réaction allergique, se référer au protocole 1 RÉP/PED.5 (Réaction allergique / anaphylactique)
4. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration, en positionnant le masque de manière à ne pas effrayer l'enfant.
5. Minimiser les contacts physiques pour éviter l'agitation de l'enfant.
6. Laisser l'enfant prendre une position de confort.
7. Ne rien donner par la bouche.
8. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarques

- Atteinte de l'état de conscience, fatigue, pâleur, mouvement de la tête de haut en bas à chaque respiration, rétraction des muscles du thorax, le battement des ailes du nez sont des signes que l'état de l'enfant s'aggrave.
- La bradycardie peut être un signe d'hypoxie sévère chez l'enfant.

OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES (0-7 ANS OU < 25 KG) 1 RÉP/PED.4

1 RÉP/PED.4

Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger (0-7 ans ou < 25 kg)

Critère d'inclusion :

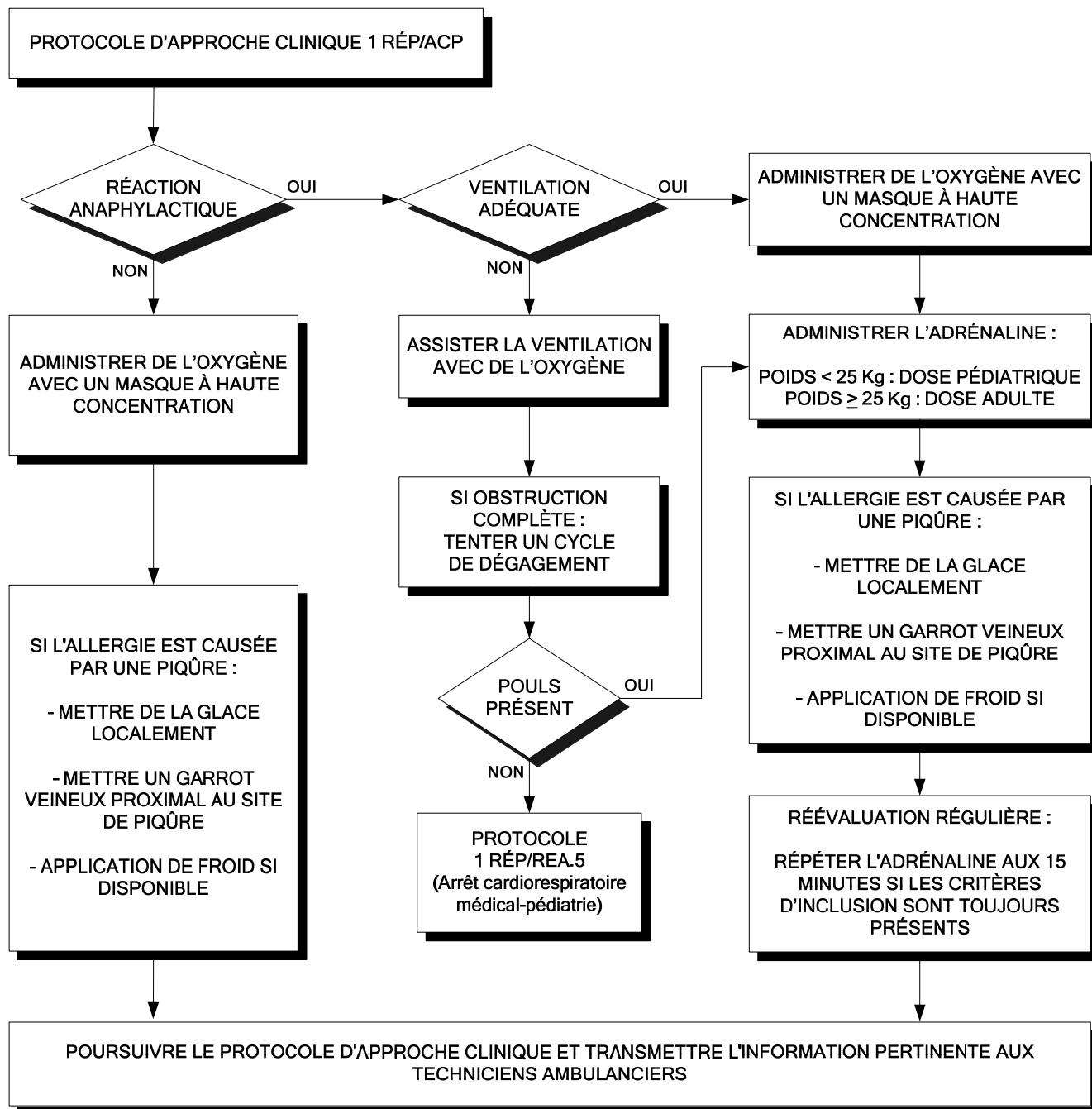
Obstruction respiratoire probable par un corps étranger.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Procéder aux manœuvres de désobstruction des voies respiratoires selon les normes de la FMCQ.
 - a) L'obstruction des voies respiratoires persiste :
 - Reprendre l'étape 2;
 - L'obstruction des voies respiratoires a été levée, passer à l'étape suivante.
 - b) Respiration spontanée :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
 - c) Pouls :
 - Absence de pouls
 - Débuter la réanimation cardiorespiratoire selon les normes de la FMCQ et du protocole 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire médical-pédiatrie).
 - Présence de pouls
 - Passer à l'étape suivante.
3. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarques

- Se référer aux normes de RCR de la FMCQ pour les étapes de chacune des situations décrites ci-haut.
- Surveiller les complications : arrêt cardiorespiratoire, arrêt respiratoire, obstruction complète, vomissements et aspiration.

RÉACTION ALLERGIQUE/ANAPHYLACTIQUE 1 RÉP/PED.5



Réaction allergique/Anaphylactique

Critères d'inclusion :

Histoire récente confirmée ou suspectée d'exposition à un allergène.
Absence de corps étranger (voies respiratoires).

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).

2. Évaluer la sévérité de la réaction allergique :

– **Réaction anaphylactique** : Réaction allergique avec signes de défaillance respiratoire et/ou circulatoire.

Signes de **défaillance respiratoire** tels que :

- ⇒ Dyspnée bruyante;
- ⇒ Dyspnée avec tirage intercostal;
- ⇒ Dyspnée avec peau cyanosée;
- ⇒ Dyspnée avec atteinte de l'état de conscience « V, P ou U ».

ET/OU

Signes de **défaillance circulatoire** tels que :

- ⇒ Tachypnée;
- ⇒ Peau pâle froide et moite;
- ⇒ Tachycardie;
- ⇒ Hypotension artérielle;
- ⇒ Atteinte de l'état de conscience (signe tardif).

ET/OU

Œdème de la langue **objectivé** par le premier répondant.

– **Réaction allergique non anaphylactique** : réaction allergique sans problème respiratoire ou circulatoire.

3. Si présence d'une réaction anaphylactique :

a) Mettre le DEA sous tension (voir remarques).

b) Évaluer la ventilation :

Ventilation inadéquate

- Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration;
- Si obstruction complète des voies respiratoires, tenter un cycle de dégagement des voies respiratoires;
- Si arrêt cardiorespiratoire, appliquer le protocole 1 RÉP/REA.5 (Arrêt cardiorespiratoire).

Ventilation adéquate

- Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.

c) Administrer l'adrénaline

- Administrer l'adrénaline à l'aide d'un dispositif auto-injecteur dans le deltoïde (épaule) ou dans la cuisse.

Choisir le bon dispositif (bon dosage) selon le poids de la victime :

- Si poids de **25 kg ou plus** : dispositif auto-injecteur adulte (0.3 mg).
- Si poids de **moins de 25 kg** : dispositif auto-injecteur pédiatrique (0.15 mg).

d) Afin de limiter la réaction allergique, si l'allergène semble être une piqûre (insecte) ou tout autre type d'injection transcutanée :

- Appliquer de la glace localement;
- Mettre un garrot veineux proximale à la site d'injection ou de piqûre;
- Si le dard est visible facilement, l'extraire sans le pincer.

e) Réévaluer régulièrement

- Répéter l'adrénaline aux 15 minutes si l'état de la victime s'aggrave, ne s'améliore pas ou si elle présente encore les signes d'une réaction allergique sévère.

4. Si présence d'une réaction non anaphylactique :

a) Administrer de l'oxygène à haute concentration.

b) Afin de limiter la réaction allergique, si l'allergène semble être une piqûre (insecte) ou tout autre type d'injection transcutanée :

- Appliquer de la glace localement;
- Mettre un garrot veineux proximale à la site d'injection ou de piqûre;
- Si le dard est visible facilement, l'extraire sans le pincer.

5. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarques

- Le garrot veineux ne doit pas être trop serré afin de ne pas empêcher la circulation artérielle, s'assurer de la persistance du pouls distal au garrot.
- DEA : avec certains modèles d'appareils DEA, il faut installer une « résistance vocale » afin de permettre l'enregistrement et la transmission de la voix sans avoir à connecter les électrodes de défibrillation sur la victime.

PROBLÈMES MÉDICAUX-LÉGAUX

1 RÉP/MED-LEG.1

Enfant maltraité

Critères d'inclusion basés sur la Loi sur la protection de la jeunesse :

Abus physique.
 Abus sexuel.
 Mauvais traitement physique.
 Absence de soins appropriés.
 Conditions matérielles d'existence inappropriées.
 Troubles de comportement sérieux.
 Abandon.
 Isolement, rejet affectif.
 Mode de vie du gardien ou de la personne responsable qui risque de créer un danger moral ou physique pour l'enfant.
 Abus de sa vulnérabilité.
 Fugue.
 Absentéisme scolaire continu ou fréquent.

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Se référer au protocole approprié selon les signes et symptômes en présence.
3. Si évidence ou doute de mauvais traitement, signaler la situation à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) après l'intervention et suivre ses instructions. C'est le devoir du PR de signaler tout cas évident ou suspect, même si plusieurs intervenants sont impliqués dans le dossier (exemple : médecin, infirmières, techniciens ambulanciers, etc.).
4. Donner le maximum d'informations aux techniciens ambulanciers (circonstances, comportement des parents ou du gardien, état du logement, etc.).

Téléphone de la DPJ de votre région :

Renseignements requis

- Circonstances.
- Comportement des parents.
- État du logement.

1 RÉP/MED-LEG.2
Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation impraticable

(Mort obscure ou non datant de plusieurs heures)

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Mettre le DEA sous tension dès l'arrivée sur les lieux de l'intervention.
3. Comme la priorité est l'accès à l'utilisateur, les policiers doivent permettre immédiatement cet accès aux ressources préhospitalières. En cas de refus, les premiers répondants doivent expliquer l'importance de cette priorité aux policiers et quitter les lieux si le refus est maintenu.
4. Constater l'arrêt cardiorespiratoire :

En présence de :

A+B = impossibilité d'ouvrir les mâchoires et de ventiler en raison d'une rigidité cadavérique
et
C = absence de pouls

– Assurez-vous de l'enregistrement vocal et de bien documenter la situation. Ne pas faire de manœuvres.
5. Si possibilité de faire l'ABC, se référer à 1 REP/REA.0 (Arrêt cardiorespiratoire – Intervention globale).
6. Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers et attendre leur arrivée.
7. Toutes ces situations doivent être soumises au directeur médical régional pour suivi du dossier.

Remarques

- DEA : avec certains modèles d'appareils DEA, il faut installer une « résistance vocale » afin de permettre l'enregistrement et la transmission de la voix sans avoir à connecter les électrodes de défibrillation sur la victime.
- Prendre garde de ne pas déplacer ou manipuler des objets au moment d'une intervention sur les lieux d'une scène de crime ou d'une scène suspecte.
- Ne pas utiliser le téléphone du patient.
- Demander l'intervention des ressources policières, si elles ne sont pas présentes sur la scène.
- Observer et détailler la scène.
- Protéger la scène, éviter que des curieux ne s'approchent.
- Éviter de fouiller les lieux afin de trouver des informations relatives au patient (identification, médicaments, etc.).
- Éviter de répondre aux questions des journalistes et de dévoiler l'identité du patient.

1 RÉP/MED-LEG.3

Directives de non-initiation de la réanimation

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Mettre le DEA sous tension dès l'arrivée sur les lieux de l'intervention.
3. Dictier un rapport verbal succinct de la situation sur la bande audio du moniteur.
4. Demander l'attestation de non-initiation de la réanimation. Vérifier si le document a été signé par l'usager ou par son représentant légal.
5. En l'absence d'une ordonnance écrite de non-initiation de réanimation :
 - Une ordonnance verbale de non-initiation de la réanimation doit être respectée au même titre qu'une ordonnance écrite. L'ordonnance verbale peut être émise dans l'ordre, par un tuteur, un curateur, un mandataire, un conjoint légal, un membre de la famille ou toute personne ayant un lien significatif avec l'usager.
 - Dans un tel cas, inscrire clairement sur le RIP et/ou mentionner verbalement sur l'enregistrement du DEA le nom de la personne ayant signifié l'ordonnance de non-initiation de la réanimation ainsi que son lien avec l'usager.
 - S'il y a désaccord parmi les proches de la famille sur l'ordonnance verbale de non-initiation de la réanimation, procéder au protocole 1 RÉP/REA.0 (Arrêt cardiorespiratoire – intervention globale).
 - S'il y a une ordonnance écrite de non-initiation de la réanimation et qu'un des proches insiste pour qu'il y ait des manœuvres, débiter le protocole 1 RÉP/REA.0 (Arrêt cardiorespiratoire – intervention globale). Ces situations doivent être soumises au directeur médical pour suivi du dossier.
6. Bien documenter le dossier en tout temps.
7. Confirmer avec le Centre de communication santé pour informer les techniciens ambulanciers.

Critères d'exclusion

- Suicide.
- Homicide.

1 RÉP/MED-LEG.4**Mort évidente**

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. En présence de critères de mort évidente, ne pas faire de manœuvres de réanimation. Si aucun de ces critères n'est présent et que la réanimation est praticable, référez-vous à 1 REP/REA.0 (Arrêt cardiorespiratoire – intervention globale). Les critères de mort évidente sont les suivants :
 - Ossements;
 - Décapitation;
 - Sectionnement complet du corps;
 - Compression totale du crâne;
 - Évidement du crâne;
 - Putréfaction avancée;
 - Adipocire;
 - Momification;
 - Calcination.
3. Lorsque les services préhospitaliers sont appelés sur les lieux où une personne présente l'une des caractéristiques énumérées en 2, suite à une évaluation de l'état du patient, ne pas faire de manœuvres de réanimation. Assurez-vous de l'enregistrement vocal et bien documenter la situation.
4. Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers et attendre leur arrivée.
5. Toute situation problématique doit être soumise au directeur médical régional pour un suivi du dossier.

1 RÉP/MED-LEG.5**Présence d'un médecin / sage-femme sur place**

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière (1 RÉP/ACP).
2. Prendre charge de l'utilisateur selon les protocoles habituels. Aviser le médecin/sage-femme que les PR agissent selon des protocoles approuvés par un directeur médical régional.
3. Si le médecin/sage-femme veut prendre en charge l'utilisateur, noter au dossier son nom et numéro de pratique au Québec.
4. Offrir une assistance à l'intervenant sur place et attendre les techniciens ambulanciers.
5. Toute situation problématique doit être soumise au directeur médical régional pour suivi de dossier.

Remarques

- Seul un médecin avec permis de pratique du Québec peut faire un constat de décès au Québec.

PROBLÈMES TRAUMATIQUES

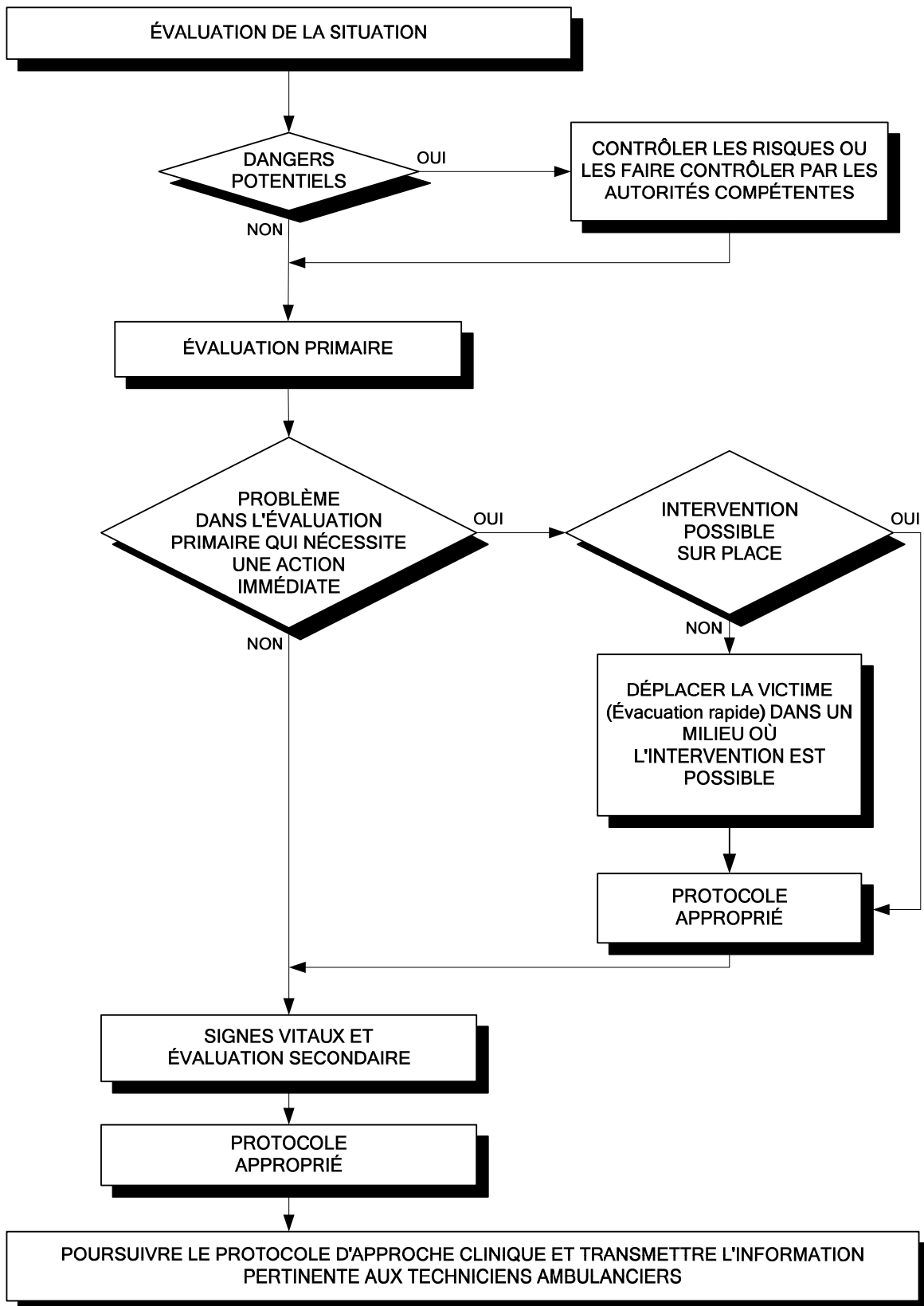
Information sur les problèmes traumatiques

Introduction

Les protocoles inhérents aux problèmes traumatiques doivent toujours tenir compte des principes suivants :

- Assurer la sécurité sur le site d'intervention y compris la sécurité des intervenants.
- Rechercher et documenter le mécanisme du traumatisme avec la participation des témoins et autres intervenants (policiers, pompiers, etc.).
- Ne rien donner par la bouche.

APPROCHE CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE 1 RÉP/ACP.TRAU.



Approche clinique préhospitalière en traumatologie

Dès qu'une victime présente une atteinte des ses fonctions vitales (évaluation primaire ou signes vitaux), il faut procéder immédiatement à l'intervention appropriée.

1. Évaluer la situation :

- Sécuriser les lieux (dangers potentiels);
- Évaluer le nombre de victimes (mécanisme de l'accident, triage, etc.);
- Sécuriser les espaces de travail;
- Demander les ressources supplémentaires nécessaires.

2. Évaluation primaire :

- L'** : (État de conscience) présence ou absence de réaction – protection cervicale;
- A** : (Airway) ouverture des voies respiratoires;
- B** : (Breathing) respiration;
- C** : (Circulation) pouls;
- D** : (Disability) incapacité, niveau de conscience « AVPU »;
- E** : (Exposure) découvrir la partie affectée seulement.

3. Problème trouvé dans l'évaluation primaire : évaluer si l'intervention est possible sans déplacer la victime :

Problème nécessitant une action immédiate

- S'il est possible d'intervenir sur place, appliquer le(s) protocole(s) approprié(s);
- S'il est impossible d'intervenir sur place, déplacer la victime (principe d'évacuation rapide) dans un milieu où l'intervention est possible.

4. Prendre les signes vitaux et procéder à l'examen secondaire.

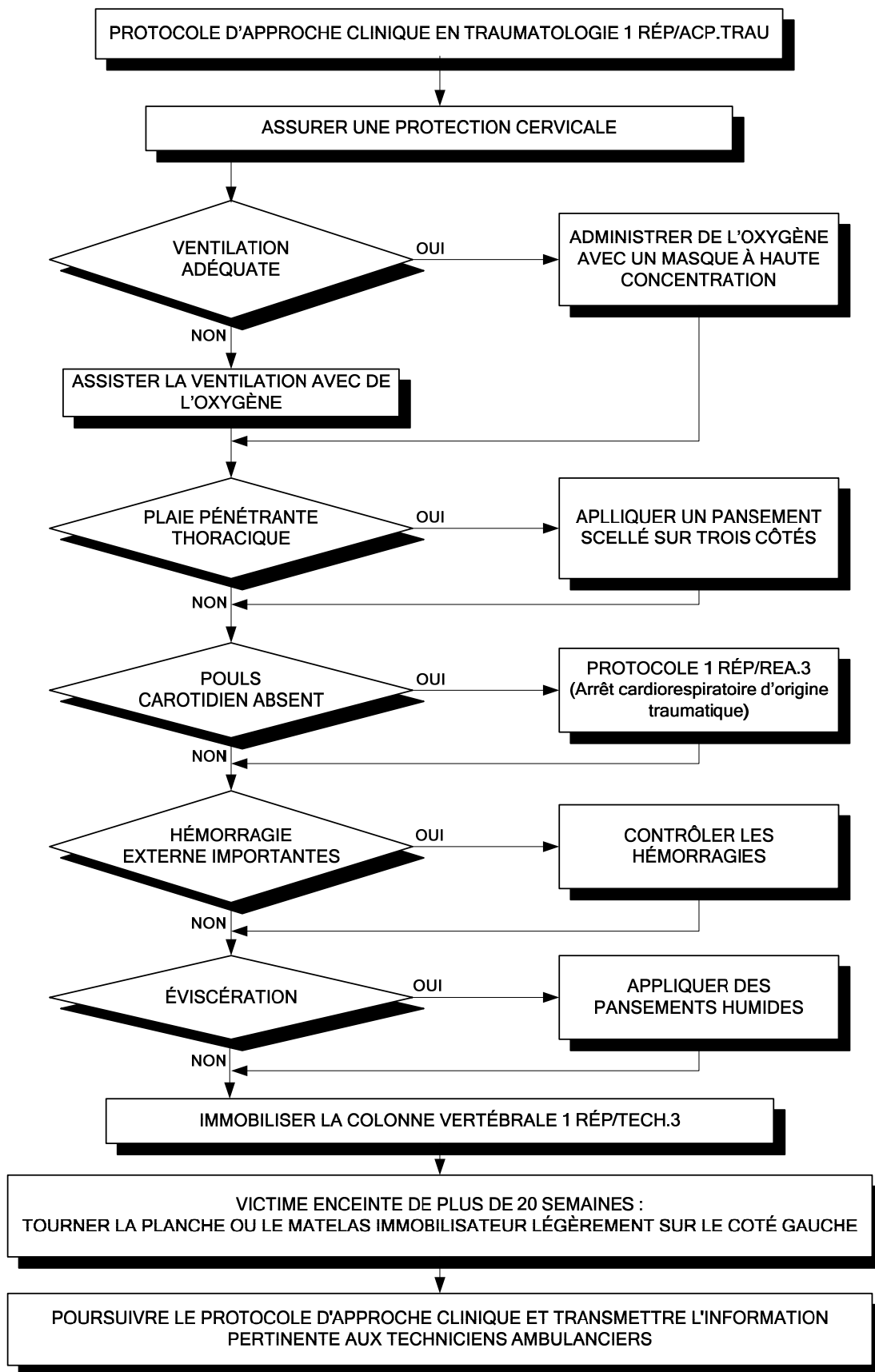
5. Problème nécessitant une intervention : appliquer le protocole approprié.

6. Transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarque

- L'évaluation secondaire se fait uniquement dans les cas de traumatisme. Elle consiste en une évaluation rapide de la tête aux pieds afin de déterminer les lésions évidentes ou les déformations. L'évaluation doit être pratiquée **dans un temps maximal d'une minute**. Dans le cas d'un traumatisme isolé, seule la partie affectée fait l'objet d'une évaluation.

TRAUMATISME ADULTE 1 RÉP/TRAU.1



Traumatisme adulte (Incluant traumatisme thoracique et abdominal)

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière en traumatologie (1 RÉP/ACP.TRAU).
2. Assurer une protection cervicale.
3. Anomalie de L'ABCD qui ne peut être résolue sur place ou environnement problématique :
 - Déplacer la victime en immobilisant la colonne cervicale manuellement.
4. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
5. Vérifier la présence de plaie pénétrante thoracique :
 - Présence de plaie pénétrante thoracique
 - Appliquer un pansement scellé sur 3 côtés.
 - Absence de plaie pénétrante thoracique
 - Passer à l'étape suivante.
6. Prendre le pouls carotidien :
 - Présence de pouls carotidien
 - Passer à l'étape suivante.
 - Absence de pouls carotidien
 - Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.3.
7. Vérifier la présence d'hémorragie externe importante :
 - Présence d'hémorragie externe importante
 - Contrôler les hémorragies externes importantes.
 - Absence d'hémorragie externe importante
 - Passer à l'étape suivante.

8. Vérifier la présence d'éviscération :

Présence d'éviscération

- Appliquer des pansements humides.

Absence d'éviscération

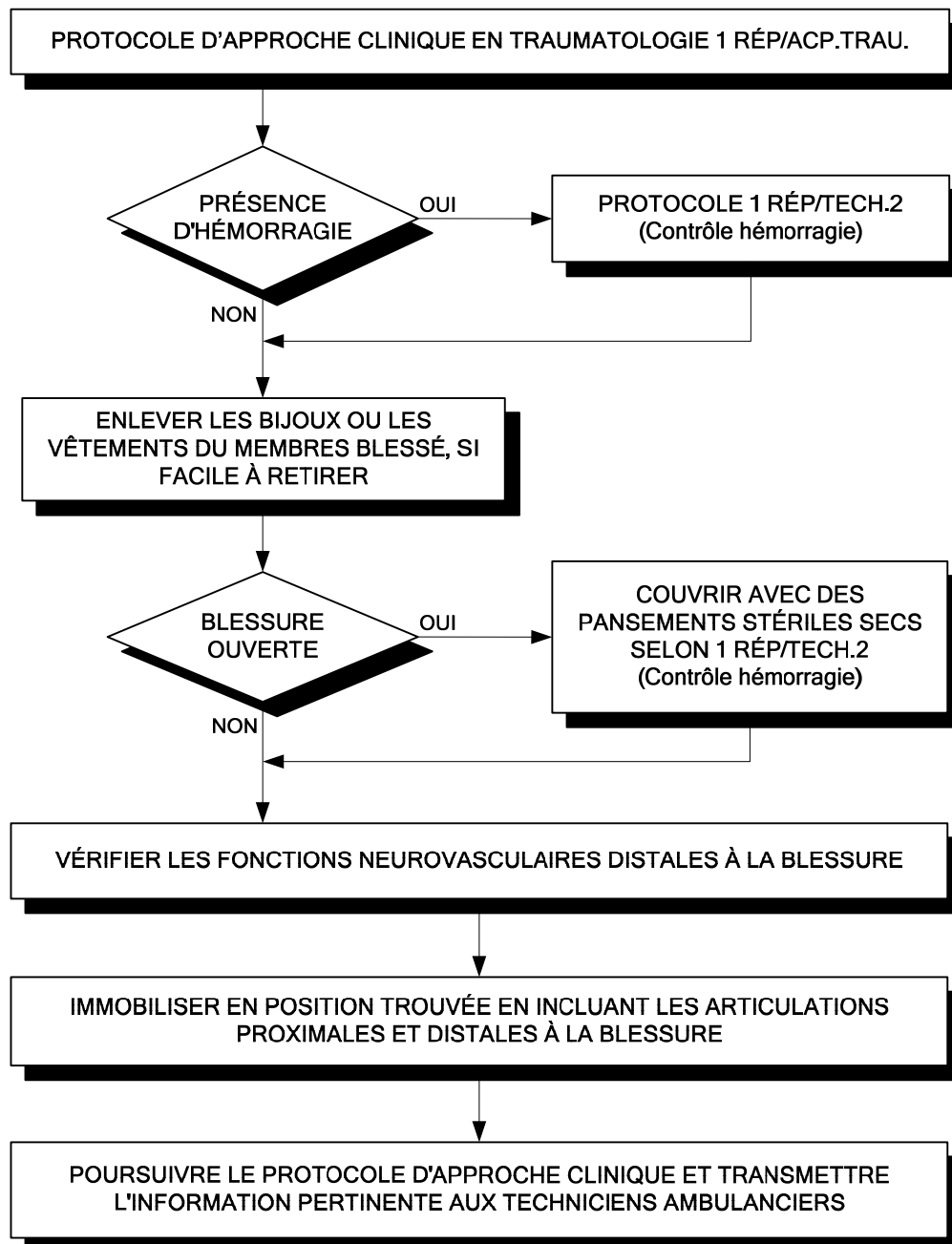
- Passer à l'étape suivante.

9. Immobiliser la colonne vertébrale selon la technique (1 RÉP/TECH.3).

10. Si la victime est enceinte de plus de 20 semaines : tourner la planche (ou le matelas immobilisateur) légèrement sur le côté gauche.

11. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

TRAUMATISME ISOLÉ DES EXTRÉMITÉS 1 RÉP/TRAU.3



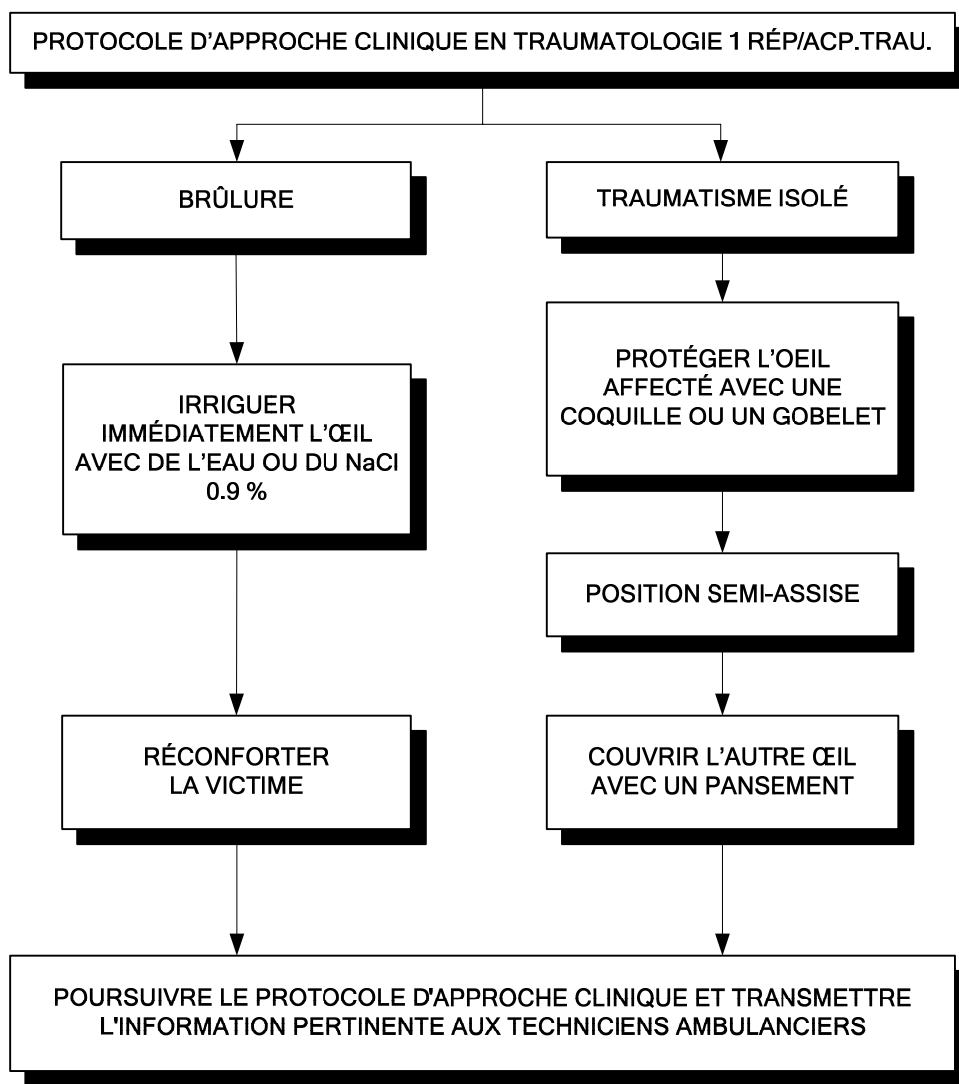
Traumatisme isolé des extrémités

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière en traumatologie (1 RÉP/ACP.TRAU).
2. Vérifier la présence d'hémorragie :
 - Présence d'hémorragie
 - Contrôler l'hémorragie selon la technique (1 RÉP/TECH.2);
 - Passer à l'étape suivante.
 - Absence d'hémorragie
 - Passer à l'étape suivante.
3. Enlever les bijoux ou les vêtements du membre blessé, seulement s'ils sont faciles à retirer.
4. Couvrir les blessures ouvertes avec des pansements stériles selon la technique 1 RÉP/TECH.2.
5. Vérifier la fonction neurovasculaire distale avant et après l'immobilisation.
6. Immobiliser le membre en position trouvée :
 - Incluant les articulations proximales et distales à la blessure.
7. Poursuivre le protocole d'approche clinique en traumatologie et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarques

- Évaluation des fonctions neurovasculaires : Motricité, sensibilité, pouls distal, coloration, remplissage capillaire, température.
- Les priorités de réanimation de la victime polytraumatisée ont toujours préséance sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié.

TRAUMATISME OU BRÛLURE OCULAIRE 1 RÉP/TRAU.4



1 RÉP/TRAU.4

Traumatisme ou brûlure oculaire

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière en traumatologie (1 RÉP/ACP.TRAU).
 - Protection cervicale si nécessaire.

2. Vérifier la présence de brûlure :

Présence de brûlure

- Irriguer immédiatement l'œil avec de l'eau OU du NaCl 0.9 %;
- Réconforter la victime;
- Continuer l'irrigation.

3. Vérifier la présence de traumatisme :

Présence de traumatisme

- Protéger l'œil affecté avec une coquille ou un gobelet;
- Installer la victime en position semi-assise;
- Couvrir l'autre œil avec un pansement.

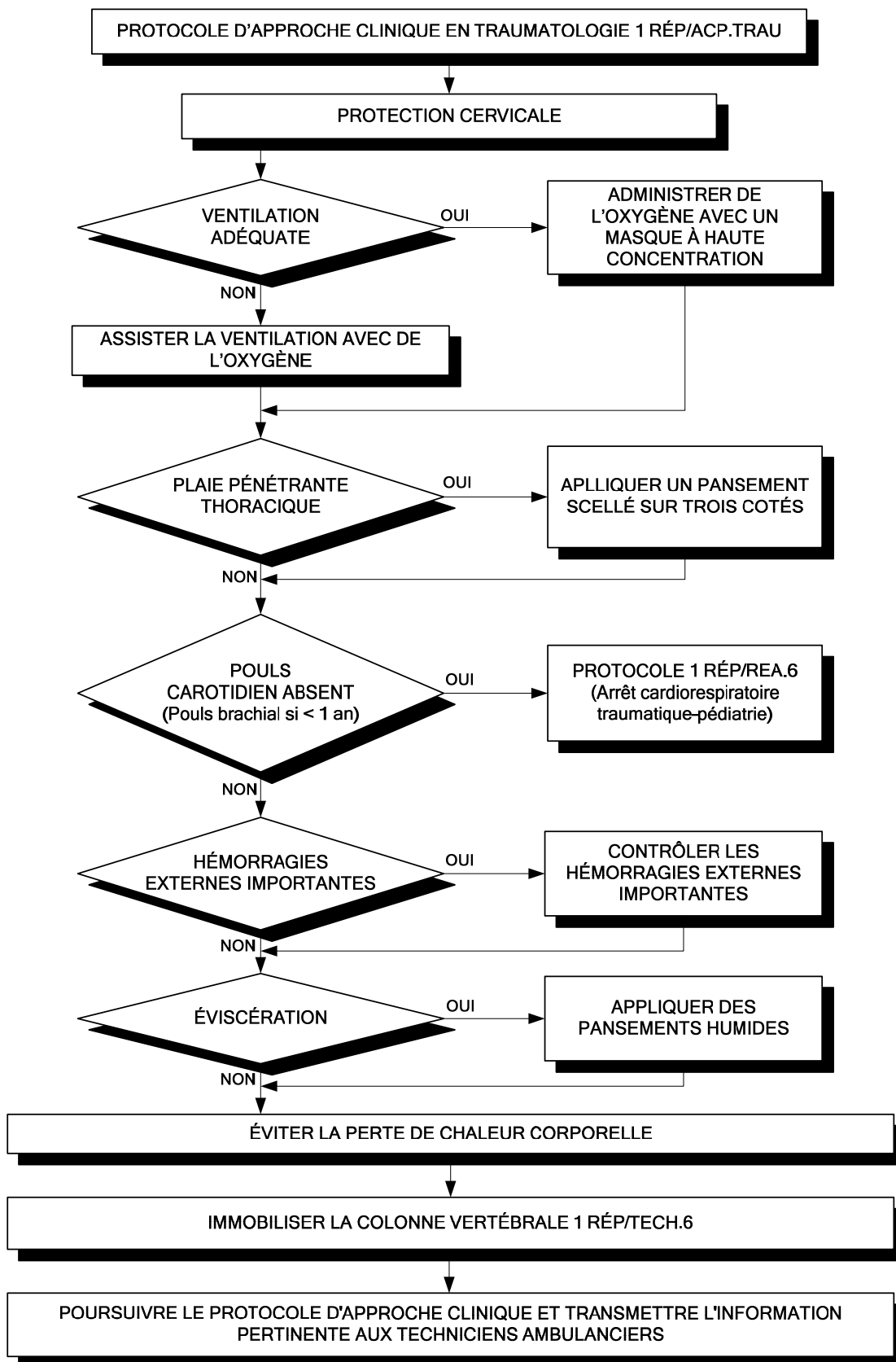
4. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Ne jamais retirer un corps étranger pénétrant.

Remarque

- Les priorités de réanimation de la victime polytraumatisée ont toujours préséance sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié.

TRAUMATISME PÉDIATRIQUE 1 RÉP/TRAU.5



Traumatisme pédiatrique

1. Se référer au protocole d'approche clinique préhospitalière en traumatologie (1 RÉP/ACP.TRAU).
2. Assurer une protection cervicale.
3. Anomalie de L'ABCD qui ne peut être résolue sur place ou environnement problématique.
 - Déplacer la victime en immobilisant la colonne cervicale manuellement.
4. Évaluer la ventilation :
 - Ventilation inadéquate
 - Assister la ventilation et administrer de l'oxygène à haute concentration.
 - Ventilation spontanée adéquate
 - Administrer de l'oxygène avec un masque à haute concentration.
5. Vérifier la présence de plaie pénétrante thoracique :
 - Présence de plaie pénétrante thoracique
 - Appliquer un pansement scellé sur 3 côtés.
 - Absence de plaie pénétrante thoracique
 - Passer à l'étape suivante.
6. Prendre le pouls carotidien ou brachial :
 - Présence de pouls carotidien ou brachial
 - Passer à l'étape suivante.
 - Absence de pouls carotidien ou brachial
 - Appliquer le protocole 1 RÉP/REA.6 (Arrêt cardiorespiratoire traumatique-pédiatrie).
7. Vérifier la présence d'hémorragie externe importante :
 - Présence d'hémorragie externe importante
 - Contrôler les hémorragies externes importantes.
 - Absence d'hémorragie externe importante
 - Passer à l'étape suivante.

8. Vérifier la présence d'éviscération :**Présence d'éviscération**

- Appliquer des pansements humides.

Absence d'éviscération

- Passer à l'étape suivante.

9. Éviter la perte de chaleur corporelle (Couvrir la victime).**10. Immobiliser la colonne vertébrale selon la technique 1 RÉP/TECH.6.****11. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.****Remarque**

- Chez les enfants de moins de 1 an, prendre le pouls brachial au lieu du pouls carotidien.

TECHNIQUES

1 RÉP/TECH.1

Retrait du casque protecteur

1. Le PR1 se place parallèlement à la victime, maintient la tête et ouvre la visière.
2. Le PR2 se place à la tête de la victime et prend la relève de l'immobilisation manuelle de la tête.
3. Si la victime n'est pas déjà en position couchée sur le dos, les premiers répondants placent la victime en position de décubitus dorsal, de préférence directement sur l'équipement d'immobilisation, en limitant les mouvements de la tête.
4. Le PR1 détache ou coupe la sangle de retenue du casque du motocycliste.
5. Le PR1 maintient la tête en position neutre :
 - Une main posée sur la base de l'occiput;
 - Une main posée sur le maxillaire inférieur.
6. Retrait du casque de moto selon a) ou b) :
 - a) Si casque avec mentonnière rigide couvrant le visage (full face)
 Tout en écartant légèrement les côtés du casque :
 - Effectuer une légère bascule vers l'arrière;
 - Effectuer ensuite une bascule vers l'avant en retirant le casque;
 - S'assurer de l'immobilité de la tête lors de la manœuvre.
 - b) Si casque sans mentonnière rigide
 - Tout en écartant légèrement les côtés du casque, retirer le casque lentement en s'assurant de l'immobilité de la tête.
7. Le PR2 pose les mains de chaque côté de la tête et maintient la tête en ne couvrant pas les oreilles.
8. Le PR1 détermine la taille du collier cervical rigide.
9. Le PR1 applique le collier cervical rigide.
10. Compléter l'immobilisation de la victime au besoin selon la technique 1 RÉP/TECH.3.
11. Remettre le casque aux techniciens ambulanciers.
12. Poursuivre le protocole d'approche clinique et transmettre l'information pertinente aux techniciens ambulanciers.

Remarque

- Si la victime porte des épaulettes, s'assurer de maintenir la colonne vertébrale en position neutre.

Contrôle d'hémorragie

1. Localiser l'hémorragie.
2. Noter la nature de l'hémorragie et la présence d'un corps étranger, si visible.
 - a) En présence d'un corps étranger :
 - Ne pas retirer l'objet;
 - Immobiliser l'objet;
 - Exercer une pression autour de l'objet.

En l'absence de corps étranger visible :

 - Exercer une pression directe sur la plaie.
 - b) Si l'hémorragie est située au niveau des membres :
 - Élever le membre;
 - Vérifier le pouls distal et le retour capillaire;
 - Appliquer des compresses de gazes stériles;
 - Faire un pansement compressif;
 - Réévaluer le pouls distal et le retour capillaire.
 - c) Si l'hémorragie est située au niveau de la tête, du cou ou du tronc :
 - Appliquer des compresses de gazes stériles;
 - Faire un pansement compressif.
 - d) En présence d'hémorragie non contrôlée :
 - Ajouter un nouveau pansement compressif par-dessus le précédent (renforcer le pansement);
 - Comprimer l'artère proximale à la blessure, si l'hémorragie persiste.
3. Faire étendre la victime.

1 RÉP/TECH.3

Immobilisation de la colonne vertébrale chez l'adulte

1. Victime en position debout :

- Demander à la victime de ne pas bouger;
- Immobiliser la tête manuellement;
- Mesurer et appliquer un collier cervical rigide;
- Placer la planche debout et l'adosser à la victime;
- Tout en maintenant la tête, descendre lentement la victime adossée à la planche;
- Transférer la victime sur le matelas immobilisateur et compléter l'immobilisation selon la technique 1 RÉP/TECH.8.

2. Victime couchée par terre :

- Demander à la victime de ne pas bouger;
- Immobiliser la tête manuellement;
- Mesurer et appliquer un collier cervical rigide;
- Tout en maintenant la tête, aligner avec le corps et tourner la victime en bloc vers soi;
- Placer le matelas immobilisateur parallèlement à la victime;
- Tourner la victime sur le matelas immobilisateur et compléter l'immobilisation selon la technique 1 RÉP/TECH.8.

3. Victime dans une autre position :

- Demander à la victime de ne pas bouger;
- Immobiliser la tête manuellement;
- Positionner le matelas immobilisateur (préalablement préparé) de façon appropriée selon la technique 1 RÉP/TECH.8;
- Installer la victime en position de décubitus dorsal tout en tentant de réaligner l'axe de la tête;
- Mesurer et appliquer un collier cervical rigide;
- Compléter l'immobilisation sur matelas immobilisateur selon la technique 1 RÉP/TECH.8.

**En présence de douleur ou si résistance à l'immobilisation de la tête,
immobiliser dans la position trouvée.**

Remarques

- Si, de façon exceptionnelle, une victime doit être immobilisée sur planche dorsale, suivre la technique suivante :
 - ◆ Si planche avec courroie, immobiliser d'abord le thorax, le bassin, la tête, puis les pieds;
 - ◆ Immobiliser le thorax à l'aide de 2 courroies posées en « X »;
 - ◆ Immobiliser le bassin à l'aide d'une courroie posée horizontalement;
 - ◆ Immobiliser la tête à l'aide d'une couverture ou de l'équipement approprié;
 - ◆ Immobiliser les pieds à l'aide d'une courroie simple en « 8 »;
 - ◆ Maintenir les mains jointes à l'aide d'une bande triangulaire, au besoin;
 - ◆ Si une fracture aux membres inférieurs est suspectée, il faut d'abord immobiliser la ou les jambes blessées avant de les fixer à la planche. Par la suite, compléter l'immobilisation des membres inférieurs sur la planche à l'aide de courroies placées perpendiculairement à l'axe des membres. La technique en 8 ne doit pas être appliquée dans ces circonstances. Attention de ne pas placer de courroies directement sur le site de la fracture.

1 RÉP/TECH.4**Immobilisation des extrémités**

1. Considérer tout traumatisme à une extrémité comme une fracture possible.
2. Minimiser les mouvements de la partie blessée.
3. Évaluer les fonctions neurovasculaires distales.
4. Maintenir le membre en position trouvée en le soutenant par les parties distale et proximale à la fracture.
5. Utiliser une attelle qui soutient le membre et le maintient en position adéquate.
6. Combler l'intérieur de l'attelle à l'aide de coussinets.
7. Immobiliser l'articulation proximale et distale.
8. Soutenir le membre immobilisé à l'aide de bandes triangulaires ou en utilisant une partie du corps.
9. Réévaluer les fonctions neurovasculaires distales.

Immobilisation du bébé

1. Immobilisation dans un siège d'auto :

- Maintenir la tête en position neutre;
- Combler les espaces creux avec des coussinets;
- Fixer le tronc;
- Fixer la tête au niveau du front.

2. Si le siège du bébé présente des dommages, ceci indique un impact à haute vitesse. Le bébé devra être immobilisé sur un dispositif d'immobilisation.

3. Transfert d'un bébé sur un dispositif d'immobilisation :

- Combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de l'immobilisation et la neutralité de la position de la colonne vertébrale avec des coussinets;
- Retirer ou couper les sangles qui retiennent le siège d'appoint à la banquette de l'automobile et retirer le bébé du véhicule dans son siège;
- Le PR1 maintient la tête avec les avant-bras et les épaules avec les mains;
- Le PR2 maintient le tronc avec les deux mains;
- De façon coordonnée, les deux premiers répondants transfèrent le bébé sur le dispositif d'immobilisation;
- Des coussinets doivent être installés sous le tronc (des épaules jusqu'au bassin) afin d'éviter la flexion cervicale;
- Des coussinets peuvent être installés (rouleaux) de chaque côté du tronc pour éviter les mouvements latéraux.

Remarques

- Éviter de provoquer une restriction respiratoire lors de l'installation de courroies thoraciques.
- Cette technique d'immobilisation pourrait être utilisée lors de tout type de traumatisme impliquant ou non un véhicule automobile.

1 RÉP/TECH.6

Immobilisation de l'enfant

1. Enfant couché par terre : (approcher calmement la victime)

- Demander à l'enfant de ne pas bouger;
- Maintenir la tête en position neutre;
- Mesurer et installer un collier cervical rigide (3 ans et plus);
- Tout en maintenant la tête bien alignée avec le tronc, tourner la victime en bloc vers soi;
- Placer le dispositif d'immobilisation parallèlement à la victime;
- Des coussinets peuvent être utilisés sur le dispositif d'immobilisation afin de combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de l'immobilisation et la neutralité de la position de la colonne vertébrale;
- Le PR1 maintient la tête;
- Le PR2 maintient le tronc avec les deux mains;
- De façon coordonnée, les deux premiers répondants transfèrent l'enfant sur le dispositif d'immobilisation;
- Des coussinets doivent être installés sous le tronc (des épaules jusqu'au bassin) afin d'éviter la flexion cervicale;
- Des coussinets peuvent être installés (rouleaux) de chaque côté du tronc pour éviter les mouvements latéraux.

2. Enfant dans une autre position :

- Demander à l'enfant de ne pas bouger;
- Maintenir la tête en position neutre;
- Placer le dispositif d'immobilisation parallèlement à la victime;
- Installer l'enfant en position de décubitus dorsal, avec coussinets, tel que décrit ci-haut, en tentant de réaligner l'axe de la tête;
- Mesurer et installer un collier cervical rigide (3 ans et plus);
- Continuer la technique d'immobilisation décrite en 1.

3. Enfant en position debout : (l'application de cette technique exige que l'enfant soit assez âgé pour obtenir sa collaboration)

- Demander à l'enfant de ne pas bouger;
- Maintenir la tête en position neutre;
- Mesurer et installer un collier cervical rigide (3 ans et plus);
- Placer la planche dorsale debout et l'adosser à l'enfant (ajout de coussinets en fonction de l'enfant);
- Tout en maintenant la tête, descendre lentement l'enfant adossé à la planche jusqu'au sol;
- Continuer la technique d'immobilisation décrite en 1.

Remarques

- L'utilisation de coussinets permet de conserver une position neutre de la tête et du cou. Une flexion antérieure de la tête peut entraîner des problèmes respiratoires.
- Une planche dorsale pédiatrique, si disponible, peut remplacer une planche dorsale longue avec coussinets.
- En présence de douleur ou si résistance à l'immobilisation de la tête, immobiliser en position trouvée.

Installation du K.E.D.

1. **Maintenir la tête en position neutre :**
 - Mesurer le collier cervical rigide;
 - Installer le collier cervical rigide.
2. **Tout en maintenant la tête immobile (déplacer en bloc) :**
 - Glisser le K.E.D. derrière le dos de la victime;
 - Centrer le K.E.D. avec la colonne vertébrale.
3. **Placer les courroies inférieures (jambes) en bas de chaque côté de la victime. Ne pas les installer immédiatement.**
4. **Ramener les rabats thoraciques vers l'avant et boucler les courroies du centre et du bas seulement.**
5. **Amener la partie supérieure des rabats thoraciques sous les aisselles de la victime, en utilisant les poignées de soulèvement.**
6. **Resserrer les deux courroies préalablement bouclées.**
7. **Passer les courroies inférieures sous les jambes de la victime de l'extérieur vers l'intérieur et boucler chacune dans les boucles femelles du même côté.**
8. **Remplir l'espace entre l'arrière de la tête et le K.E.D. au besoin, à l'aide d'accessoires spongieux (fournis ou improvisés).**
9. **Fixer les bandes en ramenant chacun des rabats de chaque côté de la tête :**
 - Une bande frontale;
 - Une bande mentonnière.
10. **Ajuster toutes les courroies de bas en haut. Ajuster et boucler la dernière courroie thoracique en demandant à la victime d'inspirer profondément.**
11. **S'assurer que toutes les courroies soient ajustées adéquatement.**

SORTIE DU VÉHICULE :

12. **Placer une planche dorsale de manière à ce que son extrémité inférieure soit glissée sous le bassin de la victime. La planche doit être soutenue à son autre extrémité par une troisième personne.**
13. **Effectuer une rotation de la victime pour qu'elle soit dos à la sortie (la tête doit sortir en premier).**

14. Coucher la victime sur la planche dorsale. Pendant la manœuvre, la tête de la victime doit être maintenue manuellement. Les deux premiers répondants doivent coordonner leurs actions.
15. Glisser la victime sur la planche tout en maintenant l'axe de la colonne, puis déposer la planche sur le matelas immobilisateur préalablement préparé sur le sol, près du véhicule.
16. Immobiliser la victime sur le matelas immobilisateur selon la technique 1 RÉP/TECH.8.

Remarque

- Si, exceptionnellement, le matelas immobilisateur n'est pas disponible, la victime peut être immobilisée sur planche.

1 RÉP/TECH.8

Installation du matelas immobilisateur dans les cas de traumatisme**1. Préparation du matelas :**

- Sortir le matelas de son sac protecteur et le déplier;
- Étendre le matelas et disperser les billes qu'il contient de manière uniforme;
- Mettre un drap ou une flanelle sur le matelas;
- À moins de déposer la victime sur le matelas à l'aide d'une planche dorsale, replier par en-dessous le rebord du matelas du côté où se trouve la victime à immobiliser;
- Connecter la pompe au matelas en s'assurant que la valve est ouverte;
- Faire le demi-vide (2 à 3 coups de pompe) et fermer la valve.

2. Victime debout :

- Le matelas immobilisateur ne doit pas être utilisé pour une descente rapide au sol;
- Utiliser la planche dorsale selon la technique 1 RÉP/TECH.3, partie 1, pour la descente rapide puis immobiliser ensuite la victime dans le matelas immobilisateur.

3. Victime couchée par terre :

- Le matelas doit être préparé selon la technique expliquée précédemment. Cependant, le drap (ou la flanelle) doit être tiré à moitié du côté où se trouve la victime;
- Après avoir installé un collier cervical de dimension appropriée à la victime conformément au point 2 de la technique 1 RÉP/TECH.3, tourner la victime en bloc (il est préférable de procéder avec l'aide d'un troisième intervenant si possible);
- Tirer le matelas le plus près possible de la victime;
- Retourner la victime en bloc sur le matelas;
- Pendant que le PR2 maintient toujours manuellement la tête de la victime, le PR1 étend le drap;
- Le PR1 (et le troisième intervenant si présent) passe de l'autre côté de la victime de manière à pouvoir la déplacer en tirant sur le drap;
- Repositionner la victime au centre du matelas en tirant sur le drap, sans provoquer de mouvement de zigzag et de manière parfaitement coordonnée avec l'autre premier répondant;
- Compléter l'immobilisation selon la technique expliquée au point 6 de cette technique.

4. Victime sur planche :

- Placer le matelas immobilisateur sur le côté parallèlement à la victime immobilisée sur planche;
- Déplacer la victime (avec la planche) de manière à la déposer sur le matelas immobilisateur;
- Détacher les courroies qui immobilisent la victime sur la planche. La tête de la victime doit alors être maintenue manuellement par le PR2;
- Le PR1 se place à genoux sur le côté de la victime et tient le côté opposé de la planche au niveau des épaules et des hanches de la victime;
- Pendant que le PR2 maintient la tête de la victime dans l'axe de la colonne, le PR1 tourne la planche et la victime vers lui. Le travail des deux premiers répondants doit être parfaitement coordonné;
- Le PR1 place son bras (situé du côté de la tête de la victime) de manière à ce que son avant-bras supporte la colonne vertébrale de la victime. De l'autre main, il repose la planche et la repousse en dehors du matelas immobilisateur;
- Retourner la victime en bloc sur le dos, sur le matelas immobilisateur;
- Positionner correctement la victime sur le matelas immobilisateur;
- Immobiliser la victime selon la technique décrite au point 6 de cette technique.

5. Victime avec K.E.D. :

- Transférer la victime avec K.E.D. et planche sur le matelas immobilisateur selon la technique vue au point précédent;
- Pendant que le PR2 maintient manuellement la tête de la victime, le PR1 détache les courroies du K.E.D.;
- Le PR1 prend la relève du PR2 au maintien manuel de la tête de la victime;
- Enlever la bande mentonnière du K.E.D., puis la bande frontale;
- Un troisième intervenant se place sur le côté parallèlement à la victime et glisse ses mains sous les omoplates de celle-ci;
- N.B. : Si seulement 2 intervenants sont disponibles, le PR1 immobilise la tête de la victime avec ses mains et les épaules de la victime avec ses avant-bras. Cependant, cette technique est plus difficile que celle à 3 intervenants.
- Le PR2 prend le K.E.D. et le tire dans l'axe de la colonne sans aucun effet de zigzag;
- Le PR2 enlève ainsi le K.E.D. pendant que le PR1 maintient la tête de la victime et que le troisième intervenant maintient le tronc;
- L'immobilisation de la victime est ensuite complétée selon la technique décrite au point 6 de cette technique.

6. Immobilisation avec le matelas immobilisateur :

- Après avoir installée la victime sur le matelas immobilisateur et l'avoir positionnée correctement au centre, ouvrir la valve du matelas pour y laisser entrer de l'air et le ramollir;
- Utiliser un second drap (ou flanelle) le rouler et le placer entre les jambes de la victime;
- Fixer les courroies du matelas en commençant par la partie supérieure du thorax et en terminant par les pieds de la victime;
- Le PR1 prend la relève du maintien manuel de la tête de la victime;
- Le PR2 moule le matelas immobilisateur à la forme de la tête de la victime en repliant les rebords vers l'extérieur (respecter le champ de vision de la victime);
- Faire le vide d'air dans le matelas à l'aide de la pompe, la forme des billes doit être visible à la surface du matelas et/ou une complète rigidité de la surface;
- Bien fermer la valve du matelas immobilisateur et débrancher la pompe;
- Immobiliser la tête avec du ruban adhésif en commençant par le front de la victime et en terminant par le menton;
- Réajuster les courroies (attention de ne pas comprimer le thorax afin de ne pas gêner la respiration);
- Transporter, si besoin, à deux personnes à l'aide des poignées sur le côté (ne jamais transporter par les extrémités du matelas).

Indication

- Toutes les victimes traumatisées de 7 ans et plus.

Contre-indication

- Victimes pédiatriques de moins de 7 ans.

Remarques

- Ne jamais transporter la victime par les extrémités du matelas.
- Si la situation requiert une mobilisation par les extrémités, le matelas sera fixé sur une planche dorsale qui sera manipulée par les extrémités.

Oxygène

1. Exclure histoire d'obstruction des voies respiratoires.
2. Ouvrir la valve de la bouteille d'oxygène et ajuster le débitmètre à 10L/min ou plus.
3. Gonfler le réservoir du masque à haute concentration.
4. Installer le masque à haute concentration sur le visage de la victime.
5. Ajuster le débitmètre pour maintenir le réservoir toujours gonflé au 2/3.
6. Installer la bouteille d'oxygène de façon sécuritaire, en s'assurant que la tubulure ne soit pas repliée ou obstruée.

Transport d'un membre amputé

Critère d'inclusion :

Tout membre ou partie de membre amputé.

1. Récupérer la partie amputée.
2. Recouvrir la partie amputée de compresses stériles humidifiées avec du NaCl 0.9 %.
3. Placer à l'intérieur d'un sac de plastique hermétiquement fermé.
4. Déposer le sac dans de l'eau avec de la glace.
5. À l'arrivée des techniciens ambulanciers, remettre le membre amputé en spécifiant le contenu et le temps écoulé depuis l'amputation.
6. Si l'amputation est partielle, la partie amputée doit être immobilisée dans l'axe normal, appliquer un pansement humide et un sac de glace placé sur le pansement stérile.

Remarques

- Le délai d'intervention est très important : il est primordial d'intervenir rapidement et efficacement.
- Une dent devrait être transportée dans la bouche du patient (si son état de conscience est « A » sur l'échelle « AVPU ») ou dans du lait chaud.
- Dans le cas d'un membre amputé, en plus du contrôle d'hémorragie du moignon, il faut faire un pansement humidifié avec une solution saline et le couvrir d'un sac imperméable.

AUTRES

Protocole de transfert de responsabilité

Intervention avec DEA par les premiers répondants

1. Le protocole d'ACR 1 RÉP/REA.O avec DEA est débuté par les premiers répondants jusqu'à l'arrivée des techniciens ambulanciers.
2. À l'arrivée des techniciens ambulanciers, les PR continuent leur manœuvres de réanimation telles que prévues au protocole. Les PR résument la situation aux TA.
3. Pendant que le TA2 prépare le combi-tube, le TA1 fait un ABC progressif.
4. Lorsque le TA2 est prêt à intuber, les PR doivent faire une autre analyse en présence des TA :
 - a) Si les PR font la RCR
 - Les PR terminent les deux minutes de RCR et procèdent à l'analyse suivante;
 - Les TA prennent charge de la victime après cette analyse;
 - Les PR demeurent disponibles pour assister les TA dans les manœuvres de réanimation et d'évacuation à la demande de ces derniers.
 - b) Si les PR ont entamé une analyse
 - Les PR terminent leur séquence d'analyse/choc en présence des TA;
 - Les TA prennent charge de la victime après cette séquence;
 - Les PR demeurent disponibles pour assister les TA dans les manœuvres de réanimation et d'évacuation à la demande de ces derniers.

Remarque

- Le PR1 doit indiquer au TA1 le nombre d'analyse(s) faite(s) et le nombre de choc(s) donné(s).

LEXIQUE

A

ACR : arrêt cardiorespiratoire

Arythmie : trouble du rythme cardiaque

B

Bradycardie : ralentissement de la fréquence cardiaque

C

Cyanose : coloration bleue des téguments

D

DEA : défibrillateur externe automatisé

Décubitus dorsal : position couchée sur le dos

Dyspnée : difficulté respiratoire

H

Hypotension : diminution de la tension artérielle

Hypoxie : diminution de la quantité d'oxygène distribuée aux tissus par le sang

M

Mesures de protection : protections universelles

O

Œdème : enflure

P

PR1 : premier répondant responsable de la victime

PR2 : premier répondant qui assiste le PR1

S

SPU : services préhospitaliers d'urgence

T

T.A. #1 : préposé

T.A. #2 : conducteur

Tachycardie : augmentation de fréquence cardiaque

Tachypnée : respiration rapide